KRANKHEITSLEHRE · PFLEGEPLANUNG · MÜNDLICHE PRÜFU

Krankheitsbilder & Pflegeplanung

107 Krankheitsbilder aus 10 Fachgebieten – Definition, Symptome, Diagnostik, Therapie, fertige Pflegeplanung und Prüfungsfragen. Ideal für die mündliche Prüfung.

Bestehen ist planbar.

ICD-10 · Pflegeplanung · Prüfungsfragen · Mündliche Prüfung

107	10	A4
Krankheitsbilder	Fachgebiete	druckfertig

INHALT

1. Innere Medizin
2. Chirurgie
3. Psychologie für Pflege
4. Gynäkologie
5. Urologie
6. Neurologie
7. HNO
8. Onkologie
9. Pädiatrie
10. … und Orthopädie

⚠ Lernhilfe, mit KI-Unterstützung erstellt und fachlich geprüft. Maßgeblich sind Lehrinhalte, Leitlinien und Standards deiner Einrichtung.

Patrick Schenkelberger · Fachpfleger Anästhesie & Intensivmedizin, Praxisanleiter

plan-nrw.de

So lernst du mit dem Heft

Jedes Krankheitsbild folgt demselben Aufbau – genau so, wie in der mündlichen Prüfung gefragt wird: Was ist es? Woran erkenne ich es? Wie wird es behandelt? Was tue ich als Pflegefachkraft?

PFLEGEPLANUNG

Pflegeproblem nach PESR, Ressourcen, Ziel, Maßnahmen und Evaluation – als Vorlage für deine eigene Planung.

PRÜFUNGSFRAGEN

Zu den meisten Krankheitsbildern Kontrollfragen mit Lösung am Ende des Hefts.

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.

Innere Medizin

10 Krankheitsbilder

Herzinsuffizienz I50

Unfähigkeit des Herzens, ausreichend Blut/Sauerstoff zu pumpen. Einteilung: Links-, Rechts- oder Globalinsuffizienz. NYHA-Stadien I–IV.

SYMPTOME

- Dyspnoe (Belastung → Ruhe)
- Orthopnoe (flach liegen nicht möglich)
- Ödeme (Knöchel, Unterschenkel)
- Nykturie
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Zyanose
- Gewichtszunahme durch Wassereinlagerung
- Tachykardie

DIAGNOSTIK

- Echo (EF < 40% = systolische HI)
- BNP/NT-proBNP erhöht
- Röntgen Thorax (Kardiomegalie, Lungenödem)
- EKG
- Labor: Kreatinin, Elektrolyte

THERAPIE

- ACE-Hemmer/Sartane
- Betablocker
- Diuretika (Furosemid)
- Aldosteronantagonisten
- Digoxin
- ICD/Resynchronisation

Pflegeproblem	Beeinträchtigte kardiopulmonale Gewebeperfusion r/t verminderter Herzleistung m/d/s Dyspnoe, Zyanose, SpO_2 < 94%
Ressourcen	Kooperativ, Versteht Anweisungen, Angehörige unterstützend
Pflegeziel	Patient atmet in Ruhe ohne Dyspnoe (NRS Atemnot 0-2) innerhalb von 48h
Maßnahmen	• Oberkörperhochlagerung 30-45° kontinuierlich • O_2-Gabe nach Anordnung, SpO_2 ≥ 94% sichern • Vitalzeichen 4-stündlich: RR, HF, AF, SpO_2 • Flüssigkeitsbilanz (Ein-/Ausfuhr täglich) • Tägliche Gewichtskontrolle (gleiche Zeit, Waage) • Ödeme dokumentieren (Umfang messen) • Aktivität schrittweise steigern nach Befinden
Evaluation	Täglich: Dyspnoe-NRS, SpO_2, Gewicht, Ödeme

Pflegeproblem	Überschuss an Körperflüssigkeit r/t Herzpumpversagen m/d/s Ödeme, Gewichtszunahme 3kg/Woche
Ressourcen	Versteht Bedeutung der Trinkmengenbeschränkung
Pflegeziel	Gewichtsreduktion um 0,5-1kg/Tag durch Diurese, Ödeme rückläufig nach 3 Tagen
Maßnahmen	• Trinkmengenbeschränkung nach Anordnung (meist 1,5-2L/Tag) • Diuretika pünktlich verabreichen, Wirkung dokumentieren • Natriumarme Ernährung besprechen • Hautpflege ödematöser Extremitäten (Druckgefahr!) • Hochlagerung der Beine • Patient über Selbstkontrolle schulen (Tagesgewicht)
Evaluation	Täglich Gewicht, Bilanz, Ödemstatus

KONTROLLFRAGEN

1 **Was bedeutet NYHA III bei Herzinsuffizienz?**

- A Keine Symptome
- B Symptome bei leichter Belastung
- C Symptome bei stärkerer Belastung
- D Symptome in Ruhe

2 **Welche Lagerung ist bei akuter kardialer Dyspnoe indiziert?**

- A Flachlagerung
- B Oberkörperhochlagerung 30-45°
- C Bauchlagerung
- D Linksseitenlage

3 **Was ist das wichtigste Pflegemonitoring bei Herzinsuffizienz?**

- A Temperatur
- B Tägliche Gewichtskontrolle + Flüssigkeitsbilanz
- C Pupillenkontrolle
- D Blutzucker

COPD J44

Chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Nicht vollständig reversible Atemwegsobstruktion durch chronische Bronchitis + Lungenemphysem. Hauptursache: Rauchen. GOLD-Stadien I–IV.

SYMPTOME

- Chronischer Husten (Raucherhusten)
- Auswurf (morgens besonders)
- Belastungsdyspnoe (progredient)
- Giemen/Brummen
- Fassthorax (Emphysem)
- Lippenzyanose
- Uhrglasnägel
- Trommelschlägelfinger

DIAGNOSTIK

- Spirometrie (FEV1/FVC < 0,7)
- Blutgasanalyse (BGA)
- Röntgen/CT Thorax
- 6-Minuten-Gehtest
- COPD-Assessment-Test (CAT)

THERAPIE

- Raucherentwöhnung (!)
- Bronchodilatatoren (LABA, LAMA)
- Inhalatoren-Schulung
- Kortikosteroide inhalativ
- Atemphysiotherapie
- Langzeit-O_2 bei PaO_2 < 55mmHg

Pflegeproblem	Ineffektives Atemmuster r/t bronchialer Obstruktion m/d/s Dyspnoe NRS 6, AF 26/min, SpO_2 88%
Ressourcen	Kann Lippenbremse anwenden, Motiviert zur Mitarbeit
Pflegeziel	SpO_2 ≥ 90% (COPD-Ziel!), Dyspnoe NRS ≤ 3 nach 24h
Maßnahmen	• O_2-Gabe VORSICHTIG: Ziel SpO_2 88-92% (nicht höher! Atemantriebreduktion!) • Kutschersitz anleiten (sitzend, Arme aufgestützt → Atemhilfsmuskulatur) • Lippenbremse üben und anwenden • Bronchodilatator-Inhalation nach Anordnung, Technik kontrollieren • Sekretmobilisation: atemunterstützende Lagerung, PEP-Geräte • Atemgymnastik 3x täglich • Körperliche Schonung, Aktivität nach Befinden
Evaluation	4-stündlich SpO_2, AF, Dyspnoe-NRS

KONTROLLFRAGEN

4 **Warum darf COPD-Patienten NICHT unkontrolliert hochdosiert O_2 gegeben werden?**

- A O_2 ist zu teuer
- B Hypoxischer Atemantrieb: zu viel O_2 → Atemdepression
- C O_2 verschlimmert Bronchitis
- D Keine Kontraindikation

5 **Was ist der Kutschersitz bei Dyspnoe?**

- A Flachlagerung
- B Sitzend, Arme auf Oberschenkeln/Tisch aufgestützt – entlastet Atemhilfsmuskulatur
- C Linksseitenlage
- D Stehend an Wand gelehnt

6 **Was ist die Lippenbremse?**

- A Medikament
- B Atemtechnik: Ausatmung durch halb geöffnete Lippen – erhöht Atemwegsdruck → verhindert Bronchiolenkollaps
- C Eine Lagerungstechnik
- D Ein Absaugverfahren

Diabetes mellitus Typ 2 E11

Chronische Stoffwechselerkrankung mit Insulinresistenz und relativem Insulinmangel. Häufigste Diabetesform (90%). Risikofaktoren: Adipositas, Bewegungsmangel, genetische Disposition.

SYMPTOME

- Polyurie, Polydipsie (bei Entgleisung)
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Wundheilungsstörungen
- Häufige Infektionen
- Sehstörungen (Retinopathie)
- Kribbeln/Taubheit Füße (Neuropathie)
- Oft lange symptomlos!

DIAGNOSTIK

- Nüchtern-BZ ≥ 126 mg/dl
- HbA1c ≥ 6,5%
- OGTT
- Urin: Mikroalbuminurie
- Augenhintergrund, Fußstatus

THERAPIE

- Basistherapie: Ernährung + Bewegung
- Metformin (First-Line)
- SGLT2-Inhibitoren, GLP-1-RA
- Insulin (bei Versagen oraler Antidiabetika)
- HbA1c-Ziel individuell (meist < 7%)

Pflegeproblem	Risiko für Hypoglykämie r/t Insulintherapie und unregelmäßiger Nahrungsaufnahme
Ressourcen	Erkennt Hypoglykämie-Zeichen, Kann BZ selbst messen
Pflegeziel	Keine Hypoglykämie-Episode (BZ > 70 mg/dl) während des stationären Aufenthalts
Maßnahmen	• BZ-Kontrolle nach Anordnung (nüchtern, vor/nach Mahlzeiten) • Mahlzeiten pünktlich, Insulin zeitgerecht verabreichen (6-R-Regel!) • Hypoglykämie-Schema beachten: BZ < 70 → 20g KH oral (Traubenzucker) • BZ < 50 oder bewusstlos → Glukose 40% i.v. nach Anordnung • Notfallset: Glukose immer griffbereit • Schulung: Symptome Hypoglykämie (Zittern, Schwitzen, Herzrasen, Verwirrtheit)
Evaluation	BZ-Profil täglich, Hypoglykämie-Ereignisse dokumentieren

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Gewebeintegrität r/t Wundheilungsstörung bei diabetischer Polyneuropathie m/d/s Ulcus plantare rechts
Ressourcen	Kooperativ, Familie unterstützt Verbandswechsel
Pflegeziel	Wunde zeigt nach 7 Tagen Granulationsgewebe, keine Infektzeichen
Maßnahmen	• Tägliche Wundinspektion und Dokumentation (Foto, Maße, Exsudat, Geruch) • Verbandswechsel nach Wundexpertenstandard (feuchte Wundversorgung) • Druckentlastung: kein Druck auf Ulcus (Spezialschuhe, Bettung) • BZ-Einstellung optimieren (schlechte BZ → schlechte Wundheilung) • Fußpflege täglich: Inspektion alle Zehenzwischenräume • Fußwärme nicht mit Wärmflasche/Heizkissen! (Neuropathie = kein Temperaturempfinden)
Evaluation	Täglich: Wunddokumentation, BZ-Verlauf

KONTROLLFRAGEN

7 **Welche Pflegemaßnahme hat bei Hypoglykämie (BZ < 70 mg/dl, Patient wach) höchste Priorität?**

A) Sofort Insulin geben

B) 20g schnell resorbierbare Kohlenhydrate oral (Traubenzucker, Fruchtsaft)

C) Patient schlafen lassen

D) Blutabnahme

8 **Was ist das Diabetische Fußsyndrom (DFS) und welche Pflegemaßnahme ist FALSCH?**

A) Täglich Füße inspizieren

B) Wärmflasche bei kalten Füßen anwenden

C) Druckentlastung sicherstellen

D) Feuchte Wundversorgung

9 **Was ist HbA1c und was zeigt er?**

A) Aktueller Blutzucker

B) Durchschnittlicher Blutzucker der letzten 2-3 Monate (Langzeitblutzucker)

C) Insulinspiegel

D) Ketonkörper

Schlaganfall (Apoplex) I63/I61

Akute Durchblutungsstörung des Gehirns. Ischämisch (80%: Hirninfarkt) oder hämorrhagisch (20%: Hirnblutung). Time is brain: jede Minute zählt!

SYMPTOME

- Plötzliche Halbseitenlähmung
- Gesichtsfeldausfall
- Sprachstörung (Aphasie, Dysarthrie)
- Schluckstörung (Dysphagie)
- Sehstörungen
- Schwindel, Gangunsicherheit
- Plötzlich stärkste Kopfschmerzen (Hirnblutung)
- Bewusstseinsstörung

DIAGNOSTIK

- FAST-Test (Face, Arms, Speech, Time)
- cCT sofort (Blutung ausschließen)
- MRT
- EKG (Vorhofflimmern?)
- Doppler-Sonographie

THERAPIE

- Lysetherapie (rtPA) bei Ischämie innerhalb 4,5h
- Thrombektomie (mechanisch)
- Stroke Unit Behandlung
- Sekundärprophylaxe: ASS, Antikoagulation bei VHF
- Frührehabilitation!

Pflegeproblem	Beeinträchtigte körperliche Mobilität r/t neurologischem Defizit nach Apoplex m/d/s Hemiparese links, Barthel-Index 35
Ressourcen	Rechte Seite gut beweglich, Motiviert zur Rehabilitation, Tochter unterstützt
Pflegeziel	Patient sitzt nach 3 Tagen mit Unterstützung 30 Min. auf Bettkante, Barthel-Index +10 nach 1 Woche
Maßnahmen	• Bobath-Konzept: betroffene Seite bewusst einbeziehen, Lagerung auf betroffener + gesunder Seite wechselnd • Physiotherapie täglich koordinieren • Transfertraining: immer von der betroffenen Seite ansprechen/aktivieren • Sturzprophylaxe: Bettgitter, Patientenklingel erreichbar • Dekubitusprophylaxe: Umlagerung alle 2h, Druckpunkte prüfen • Kontinenzförderung: regelmäßige Toilettengänge anbieten • Alle Pflegehandlungen langsam, sprachlich begleiten
Evaluation	Täglich Barthel-Index, Mobilisationsprotokoll, Sturzprotokoll

Pflegeproblem	Beeinträchtigte verbale Kommunikation r/t Aphasie nach Apoplex m/d/s Patient versteht Anweisungen, kann nicht sprechen
Ressourcen	Versteht einfache Sätze, Gestik möglich, Schreiben eingeschränkt möglich
Pflegeziel	Patient kommuniziert Grundbedürfnisse (Schmerz, Hunger, Toilette) mit Kommunikationshilfen nach 5 Tagen
Maßnahmen	• Logopädie täglich einbeziehen • Kommunikationsboard/Bildkarten einsetzen • Kurze einfache Sätze, langsam sprechen, nicht schreien • Ja/Nein-Fragen stellen • Geduld: Patient nicht unterbrechen oder Sätze ergänzen • Angehörige in Kommunikationsstrategien schulen • Frustration des Patienten anerkennen und ernst nehmen
Evaluation	Täglich Kommunikationsfortschritt dokumentieren

KONTROLLFRAGEN

10 **Was bedeutet FAST beim Schlaganfall?**

- A) Fast, Accurate, Safe, Treatment
- B) Face (Gesichtslähmung), Arms (Armlähmung), Speech (Sprache), Time (Zeit notieren, Notruf)
- C) First Aid Stroke Treatment
- D) Focused Assessment Stroke Tool

11 **Was ist das Bobath-Konzept in der Schlaganfallpflege?**

- A) Medikamentöse Therapie
- B) Rehabilitationskonzept: betroffene Körperseite bewusst einbeziehen, normale Bewegungsmuster fazilitieren
- C) Ein Lagerungskonzept für Dekubitusprophylaxe
- D) Eine Kommunikationshilfe

12 **Was ist Dysphagie und welche Gefahr besteht?**

- A) Sehstörung
- B) Schluckstörung – Gefahr: stille Aspiration → Aspirationspneumonie
- C) Gehstörung
- D) Hörstörung

Hypertonie I10

Chronisch erhöhter Blutdruck ≥ 140/90 mmHg. Häufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung. Meist primär (essentiell, 90%). Stiller Killer – oft jahrelang symptomlos.

SYMPTOME

- Oft symptomlos!
- Kopfschmerzen (okzipital, morgens)
- Schwindel
- Ohrensausen
- Sehstörungen
- Hypertensive Krise: RR > 180/120 + Symptome

DIAGNOSTIK

- Blutdruckmessung (mehrfach, beide Arme)
- 24h-Langzeit-RR
- EKG (LVH)
- Echo
- Labor: Kreatinin, Elektrolyte, Urin

THERAPIE

- Lebensstiländerung: Gewicht, Salz, Alkohol, Bewegung
- ACE-Hemmer/Sartane
- Kalziumantagonisten
- Betablocker
- Diuretika
- Ziel: < 130/80 mmHg

Pflegeproblem	Unzureichendes Selbstmanagement r/t Wissensmangel über Hypertonie m/d/s RR 175/105 trotz Medikation, unregelmäßige Einnahme
Ressourcen	Lernbereit, Möchte RR senken, Ehefrau unterstützt
Pflegeziel	Patient nennt nach 3 Tagen 5 Maßnahmen zur RR-Senkung und nimmt Medikamente regelmäßig
Maßnahmen	• RR-Messung 2x täglich (morgens/abends, protokollieren) • Patientenedukation: Ursachen, Folgen, Therapieziel • Medikamenteneinnahme erklären: warum täglich, nicht absetzen! • Ernährungsberatung: salzarm < 6g/Tag, Alkohol reduzieren • Gewichtskontrolle täglich • Bewegung: 30 Min./Tag moderate Aktivität • Stressreduktion besprechen
Evaluation	Täglich RR-Protokoll, nach 3 Tagen Wissenstest

KONTROLLFRAGEN

13 **Ab welchem Wert spricht man von arterieller Hypertonie?**

(A) 130/80 mmHg
(B) 140/90 mmHg
(C) 160/100 mmHg
(D) 120/80 mmHg

14 **Was ist bei der RR-Messung zu beachten?**

(A) Direkt nach dem Sport messen
(B) 5 Min. Ruhe, sitzen, Arm auf Herzhöhe, beide Arme vergleichen, korrekte Manschettengröße
(C) Immer im Stehen
(D) Nur rechter Arm

15 **Was ist eine hypertensive Krise und wie reagiert die Pflege?**

(A) RR > 140/90
(B) RR > 180/120 mmHg + Symptome (Kopfschmerz, Sehstörung, Brustschmerz) → Notfall! Arzt sofort, Patient beruhigen, RR-Monitoring
(C) Normaler hoher RR
(D) Postoperativer RR-Anstieg

Pneumonie J18

Akute Entzündung des Lungenparenchyms, meist bakteriell (häufig Pneumokokken) oder viral. Ambulant oder nosokomial erworben.

SYMPTOME

- Fieber, Schüttelfrost
- Husten mit Auswurf
- Dyspnoe, Tachypnoe
- Atemabhängige thorakale Schmerzen
- Abgeschlagenheit
- Bei älteren Menschen oft Verwirrtheit

DIAGNOSTIK

- Auskultation (Rasselgeräusche), Klinik
- Röntgen Thorax (Infiltrat)
- Labor (CRP, Leukozyten)
- SpO_2/BGA
- Erregerdiagnostik (Sputum/ Blutkultur)
- CRB-65-Score

THERAPIE

- Antibiotika nach AO (kalkuliert/ gezielt)
- O_2 bei Hypoxie
- Ausreichend Flüssigkeit, Antipyrese
- Sekretmanagement, Atemtherapie/ Mobilisation
- Stationär/Intensiv je nach Schwere

Pflegeproblem	Beeinträchtigter Gasaustausch r/t Lungeninfiltration m/d/s Dyspnoe, Tachypnoe, SpO_2-Abfall
Ressourcen	Patient kooperativ bei Atemübungen, Motiviert zu mobilisieren
Pflegeziel	Patient zeigt innerhalb von 48 h $SpO_2 \geq 94$ % und reduzierte Atemarbeit
Maßnahmen	• O_2 nach AO, SpO_2/Atemfrequenz überwachen • Oberkörperhochlagerung, Atemtherapie anleiten • Sekretmobilisation, abhusten lassen, ausreichend Flüssigkeit • Antibiotika/Antipyrese nach AO • Frühmobilisation und Pneumonieprophylaxe
Evaluation	SpO_2 stabil, Atemarbeit reduziert, Fieber rückläufig.

Chronische Niereninsuffizienz N18

Dauerhafte Abnahme der Nierenfunktion über Monate/Jahre mit Anstieg der Retentionswerte. Stadieneinteilung nach GFR; Endstadium dialysepflichtig.

SYMPTOME

- Lange asymptomatisch
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Ödeme, Bluthochdruck
- Verminderte Urinausscheidung (spät)
- Juckreiz, blass-graue Haut
- Übelkeit/Appetitlosigkeit (Urämie)

DIAGNOSTIK

- Labor (Kreatinin, GFR, Harnstoff, Elektrolyte)
- Urinstatus (Proteinurie)
- Sonografie der Nieren
- Blutdruck
- Verlaufskontrollen

THERAPIE

- Grunderkrankung behandeln (Diabetes/Hypertonie)
- Blutdruck-/Stoffwechseleinstellung
- Flüssigkeits-/Elektrolyt-/ Diätmanagement nach AO
- Renale Medikamentenanpassung
- Nierenersatztherapie (Dialyse) im Endstadium

Pflegeproblem	Flüssigkeitsüberschuss r/t eingeschränkter Nierenfunktion m/d/s Ödemen, Gewichtszunahme, Hypertonie
Ressourcen	Patient hält Vorgaben ein, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Ödeme und Gewicht sind innerhalb der Vorgaben stabil, RR im Zielbereich
Maßnahmen	• Ein-/Ausfuhr und tägliches Gewicht dokumentieren • Trinkmengen-/Diätvorgaben nach AO unterstützen • Blutdruck/Ödeme überwachen • Medikamente (inkl. renaler Dosis) nach AO • Hautpflege, Edukation zu Flüssigkeit/Ernährung
Evaluation	Gewicht/Ödeme stabil, RR im Zielbereich, Vorgaben eingehalten.

Leberzirrhose K74

Irreversibler bindegewebiger Umbau der Leber mit Funktionsverlust, häufig durch Alkohol oder Hepatitis. Folgen: portale Hypertension, Aszites, Ösophagusvarizen, hepatische Enzephalopathie.

SYMPTOME

- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Ikterus
- Aszites, Ödeme
- Spider naevi, Palmarerythem, Caput medusae
- Blutungsneigung
- Bewusstseinsveränderungen (Enzephalopathie)

DIAGNOSTIK

- Labor (Leberwerte, Gerinnung, Albumin, Ammoniak)
- Sonografie/ggf. Elastografie
- Gastroskopie (Varizen)
- Aszitespunktion
- Child-Pugh/MELD-Einschätzung

THERAPIE

- Auslöser meiden (Alkoholkarenz), Grunderkrankung behandeln
- Aszites: Diuretika/Punktion, Kochsalzrestriktion nach AO
- Varizenprophylaxe/-behandlung
- Enzephalopathie behandeln (z. B. Laktulose nach AO)
- Ernährung, Infekt-/Blutungsprophylaxe

Pflegeproblem	Gefahr von Blutung und Bewusstseinsstörung r/t Leberzirrhose (Varizen, Enzephalopathie) m/d/s Gerinnungsstörung, Aszites
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige unterstützen, Alkoholkarenz angestrebt
Pflegeziel	Blutungs- und Enzephalopathiezeichen werden früh erkannt; der Patient bleibt kreislaufstabil und orientiert
Maßnahmen	• Auf Blutungszeichen (Teerstuhl, Bluterbrechen) achten, Vitalzeichen • Bewusstsein/Orientierung beobachten (Enzephalopathie) • Bauchumfang/Gewicht/Bilanz bei Aszites • Medikamente (z. B. Laktulose, Diuretika) nach AO • Ernährung/Alkoholkarenz unterstützen, Edukation
Evaluation	Keine unerkannte Blutung, orientiert, kreislaufstabil, Aszites kontrolliert.

Vorhofflimmern I48

Häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung mit unkoordinierter Vorhofaktivität und unregelmäßigem Puls. Hauptgefahr: Thrombenbildung mit Schlaganfallrisiko.

SYMPTOME

- Unregelmäßiger Puls
- Herzstolpern/Palpitationen
- Leistungsminderung, Dyspnoe
- Schwindel
- Oft auch asymptomatisch
- Ggf. Schlaganfallsymptome als Komplikation

DIAGNOSTIK

- EKG/Langzeit-EKG
- Puls-/Herzfrequenzkontrolle
- Echo (Vorhof, Thromben)
- Labor (Schilddrüse, Elektrolyte)
- Schlaganfall-/Blutungsrisiko (CHA_2DS_2-VASc)

THERAPIE

- Frequenz- oder Rhythmuskontrolle nach AO
- Antikoagulation zur Schlaganfallprophylaxe nach AO
- Ggf. Kardioversion/Ablation
- Auslöser behandeln (Elektrolyte/ Schilddrüse)
- Patientenedukation

Pflegeproblem	Gefahr einer Thromboembolie (Schlaganfall) r/t Vorhofflimmern m/d/s unregelmäßigem Herzrhythmus
Ressourcen	Patient nimmt Medikamente zuverlässig, Versteht die Edukation
Pflegeziel	Der Patient zeigt keine thromboembolischen Komplikationen; die Antikoagulation wird korrekt umgesetzt
Maßnahmen	• Herzrhythmus/Frequenz und Vitalzeichen überwachen • Antikoagulation nach AO, auf Blutungszeichen achten • Auf Schlaganfallzeichen (FAST) achten • Auslöser/Elektrolyte beachten • Edukation zu Adhärenz und Blutungsrisiken
Evaluation	Keine Thromboembolie/Blutungskomplikation, Antikoagulation korrekt, Frequenz im Zielbereich.

Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) E05

Überproduktion von Schilddrüsenhormonen mit gesteigertem Stoffwechsel, häufig Morbus Basedow oder Schilddrüsenautonomie. Gefährliche Maximalform: thyreotoxische Krise.

SYMPTOME

- Tachykardie, Herzklopfen
- Gewichtsverlust trotz Appetit
- Innere Unruhe, Nervosität, Tremor
- Wärmeintoleranz, Schwitzen
- Schlafstörungen
- Ggf. Exophthalmus (Basedow)

DIAGNOSTIK

- Labor (TSH erniedrigt, fT3/fT4 erhöht)
- Sonografie/Szintigrafie der Schilddrüse
- Antikörper (Basedow)
- Puls/Blutdruck
- EKG

THERAPIE

- Thyreostatika nach AO
- Symptomatisch Betablocker nach AO
- Definitiv: Radiojodtherapie oder Operation
- Bei thyreotoxischer Krise intensivmedizinische Behandlung
- Patientenedukation

Pflegeproblem	Aktivitätsintoleranz und Unruhe r/t gesteigertem Stoffwechsel m/d/s Tachykardie, Nervosität, Gewichtsverlust
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Der Patient ist ruhiger, Puls im Zielbereich, Gewicht stabilisiert sich
Maßnahmen	• Puls/Blutdruck/Temperatur überwachen • Reizarme, kühle Umgebung, Ruhe und Schlaf fördern • Ausreichende Kalorien-/Flüssigkeitszufuhr, Gewicht dokumentieren • Medikamente (Thyreostatika/Betablocker) nach AO • Auf thyreotoxische Krise achten, Edukation
Evaluation	Puls im Zielbereich, ruhiger, Gewicht stabil, keine Krisenzeichen.

Chirurgie

10 Krankheitsbilder

Postoperative Pflege Z48

Pflegerische Versorgung nach operativen Eingriffen. Ziel: Komplikationen verhindern, Erholung fördern, Selbstständigkeit wiederherstellen. ABCDE-Schema im AWR.

SYMPTOME

- Schmerzen (NRS beachten!)
- Übelkeit/Erbrechen (PONV)
- Hypothermie
- Nachblutung
- Wundinfektion (ab Tag 3-5)
- Thrombose (ab Tag 1)
- Pneumonie (ab Tag 2-3)

DIAGNOSTIK

- Vitalzeichen-Monitoring
- Wundinspektion
- Drainageoutput
- Labor (BB, CRP, Gerinnung)
- Schmerzassessment NRS

THERAPIE

- Schmerztherapie nach WHO-Schema
- Frühmobilisation!
- Thromboseprophylaxe
- Wundversorgung
- Ernährungsmanagement

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t operativem Gewebetrauma m/d/s NRS 7/10, Patient schont sich, vermeidet Bewegung
Ressourcen	Kooperativ, Kann NRS-Skala anwenden, Versteht Bedeutung von Mobilisation trotz Schmerz
Pflegeziel	Schmerzreduktion auf NRS ≤ 3 in Ruhe und NRS ≤ 5 bei Bewegung innerhalb von 2h nach Schmerzmedikation
Maßnahmen	• Schmerzerfassung NRS alle 4h + bei Bedarf • Analgetika nach Anordnung pünktlich (nicht erst bei NRS 8!) • Wirkung nach 30-60 Min. kontrollieren, dokumentieren • Lagerung: schmerzarme Position, Kissen zur Abstützung • Nicht-pharmakologisch: Kühlung, Ablenkung, Entspannung • Patienten zur Beurteilung von Schmerz vor Mobilisation einbeziehen • Arzt informieren bei NRS > 6 trotz Analgetikum
Evaluation	NRS 30-60 Min. nach Medikation, täglich Schmerztagebuch

Pflegeproblem	Risiko einer Wundinfektion r/t operativem Eingriff und Immunsuppression
Ressourcen	Versteht Hygienemaßnahmen, Kooperiert bei Verbandswechsel
Pflegeziel	Keine Infektzeichen (Rötung, Schwellung, Eiter, Fieber > 38°C) bis zur Entlassung
Maßnahmen	• Verbandswechsel nach Standard, aseptisch • Wunddokumentation: Größe, Rand, Exsudat, Geruch, Temperatur • Vitalzeichen 2x täglich: Temperatur als Infektmarker • Labor: CRP, Leukozyten beachten • Drainagen: Menge, Farbe, Konsistenz täglich • Händehygiene bei jedem Wundkontakt • Patient: Wundzeichen erkennen, Selbstbeobachtung
Evaluation	Täglich Wundinspektion, Temperatur, Labor

KONTROLLFRAGEN

16 **Welche Prophylaxen sind postoperativ standardmäßig durchzuführen?**

(A) Nur Schmerztherapie

(B) Thromboseprophylaxe + Pneumonieprophylaxe + Dekubitusprophylaxe + Sturzprophylaxe

(C) Nur Antibiotika

(D) Nur Mobilisation

17 **Wann soll eine postoperative Frühmobilisation begonnen werden?**

(A) Erst nach 3 Tagen

(B) So früh wie möglich, meist am OP-Tag oder Tag 1 – nach Stabilität und ärztlicher Freigabe

(C) Erst wenn Schmerzen weg

(D) Erst nach Entfernung der Drainagen

18 **Wann sollte der Arzt bei Wundinspektion sofort informiert werden?**

(A) Bei jedem Verbandswechsel

(B) Bei Zeichen einer Wundinfektion: Rötung, Wärme, Schwellung, Eiter, Fieber, zunehmender Schmerz

(C) Bei normalem Wundsekretverlauf

(D) Bei trockener Wunde

Hüft-TEP / Knie-TEP Z96.6

Totalendoprothese der Hüfte (Hüft-TEP) oder des Knies (Knie-TEP). Häufigste elektive Orthopädie-Operation. Ziel: Schmerzfreiheit und Beweglichkeit wiederherstellen.

SYMPTOME

- Postoperativ: Schmerzen, Schwellung
- Bewegungseinschränkung
- Luxationsgefahr (Hüft-TEP!)
- Thrombosegefahr

DIAGNOSTIK

- Röntgen postoperativ
- Laborkontrollen
- Doppler bei TVT-Verdacht

THERAPIE

- Frühfunktionelle Behandlung
- Physiotherapie ab Tag 1
- Analgesie (PDA, Regionalanästhesie)
- Thromboseprophylaxe (NMH + Strümpfe)

Pflegeproblem	Risiko der Hüft-TEP-Luxation r/t postoperativer Instabilität m/d/s Erstmobilisation Tag 1
Ressourcen	Versteht Luxationsprophylaxe, Kooperativ
Pflegeziel	Keine Luxation während des stationären Aufenthalts, Patient kennt Verbotspositionen nach Entlassung
Maßnahmen	• Verbotspositionen einhalten: kein Beugen > 90°, kein Überkreuzen der Beine, kein Drehen des Fußes nach innen • Lagerungskeil zwischen die Beine (Abduktionskeil) • Transfer immer auf operierte Seite, Anleitung bei jedem Transfer • Toilettenerhöhung, erhöhte Sitzmöbel (Beugewinkel < 90°) • Patient und Angehörige in Verbotspositionen schulen • Physio: Gangschulung mit Gehstützen
Evaluation	Täglich Transfer kontrollieren, Patientenwissen überprüfen

KONTROLLFRAGEN

19 Welche Lagerung ist nach Hüft-TEP zwingend einzuhalten?

A) Beine überkreuzen erlaubt

B) Abduktionskeil zwischen die Beine, kein Beugen > 90°, keine Innenrotation

C) Bauchlagerung

D) Beine eng zusammenhalten

20 Warum ist Thromboseprophylaxe nach Knie-/Hüft-TEP besonders wichtig?

A) Standard bei jedem OP

B) Hohe TVT-Rate (bis 40% ohne Prophylaxe) durch Blutstase und Gefäßverletzung

C) Nur bei übergewichtigen Patienten

D) Nur bei älteren Patienten

21 Was ist bei der Mobilisation nach Knie-TEP zu beachten?

A) Erst nach 1 Woche mobilisieren

B) Frühmobilisation ab Tag 1 mit Physio, Vollbelastung sofort erlaubt je nach Fixation

C) Bettruhe 3 Wochen

D) Nur passive Bewegung

Appendizitis K35

Entzündung des Wurmfortsatzes (Appendix vermiformis). Häufigste chirurgische Notfallerkrankung. Therapie: Appendektomie (laparoskopisch oder offen). Komplikation: Perforation!

SYMPTOME

- Schmerz: periumbilikal → rechter Unterbauch
- McBurney-Punkt druckschmerzhaft
- Loslassschmerz (Blumberg-Zeichen)
- Übelkeit, Erbrechen
- Fieber 37,5-38,5°C
- Abwehrspannung bei Perforation

DIAGNOSTIK

- Klinische Untersuchung (Alvarado-Score)
- Labor: Leukozyten, CRP
- Sonographie
- CT bei Unklarheit

THERAPIE

- Appendektomie laparoskopisch (Standard)
- Antibiose perioperativ
- Bei Perforation: Drainage, Lavage

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t entzündlichem Prozess/OP m/d/s NRS 8, Schonhaltung
Ressourcen	Jung, sonst gesund, Kooperativ
Pflegeziel	NRS ≤ 3 in Ruhe nach 2h, NRS ≤ 5 bei Bewegung
Maßnahmen	• Analgetika nach Anordnung (kein Wärmepflaster auf Bauch!) • Schonlagerung: Knie leicht angewinkelt (Bauchdecke entspannt) • NRS alle 4h erheben • Kühlung auf Wunde wenn hilfreich • Bei Übelkeit: Antiemetikum nach Anordnung, Lagerung • Frühmobilisation nach OP trotz Schmerz anstreben
Evaluation	NRS 30-60 Min. nach Analgetikum

KONTROLLFRAGEN

22 **Was ist der McBurney-Punkt?**

- A Ein Herzpunkt
- B Druckschmerzpunkt bei Appendizitis: Mitte zwischen Nabel und rechtem Darmbeinstachel
- C Nierendruckpunkt
- D Gallenblasenpunkt

23 **Warum ist Wärme bei Appendizitisverdacht kontraindiziert?**

- A Kein Grund
- B Wärme fördert Entzündung und Perforation – absolut verboten!
- C Wärme ist erlaubt
- D Nur Kühlung verboten

24 **Was sind typische postoperative Komplikationen nach Appendektomie?**

- A Keine Komplikationen
- B Wundinfektion, Nachblutung, Darmparalyse (Ileus), Abszess bei Perforation
- C Nur Schmerzen
- D Nur Übelkeit

Cholezystitis / Gallensteine (Cholelithiasis) K80

Gallensteine mit möglicher Entzündung der Gallenblase. Häufige Ursache akuter rechtsseitiger Oberbauchschmerzen; Therapie oft operativ (Cholezystektomie).

SYMPTOME

- Kolikartige Schmerzen im rechten Oberbauch
- Ausstrahlung in Rücken/rechte Schulter
- Übelkeit/Erbrechen
- Fieber bei Entzündung
- Druckschmerz, positives Murphy-Zeichen
- Ggf. Ikterus bei Steinabgang

DIAGNOSTIK

- Sonografie Oberbauch (Steine, Wandverdickung)
- Labor (Entzündungs-/Cholestasewerte)
- Klinik (Murphy-Zeichen)
- Ggf. weitere Bildgebung
- Vitalzeichen

THERAPIE

- Nüchtern, Analgesie/Spasmolyse nach AO
- Antibiotika bei Entzündung nach AO
- Cholezystektomie (meist laparoskopisch)
- Perioperative Pflege
- Bei Gallengangsteinen endoskopische Entfernung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Gallenkolik/Gallenblasenentzündung m/d/s rechtsseitigem Oberbauchschmerz, Abwehrspannung
Ressourcen	Patient kooperativ, Frühzeitige Vorstellung
Pflegeziel	Der Patient ist innerhalb weniger Stunden schmerzarm (NRS ≤ 3) und kreislaufstabil
Maßnahmen	• Analgesie/Spasmolyse nach AO, Wirkung kontrollieren • Nüchtern lassen, Vitalzeichen überwachen • Übelkeit/Erbrechen behandeln, Bilanz • Perioperative Vorbereitung bei OP-Indikation • Auf Ikterus/Komplikationen achten
Evaluation	Schmerz reduziert, kreislaufstabil, keine Komplikationszeichen.

Ileus (Darmverschluss) K56

Störung der Darmpassage – mechanisch (z. B. Verwachsungen, Tumor) oder paralytisch (z. B. postoperativ, Peritonitis). Notfall mit Gefahr von Darmischämie/Sepsis.

SYMPTOME

- Zunehmende Bauchschmerzen, geblähtes Abdomen
- Erbrechen (ggf. Miserere bei tiefem Ileus)
- Stuhl-/Windverhalt
- Hochgestellte/klingende oder fehlende Darmgeräusche
- Übelkeit
- Zeichen der Exsikkose/Schock

DIAGNOSTIK

- Auskultation/Palpation des Abdomens
- Röntgen-Abdomen/CT (Spiegel, Dilatation)
- Labor (Entzündung, Laktat, Elektrolyte)
- Vitalzeichen, Bilanz
- Ursachensuche (OP-Anamnese, Tumor)

THERAPIE

- Nüchtern, Magensonde zur Entlastung nach AO
- Volumen-/Elektrolytausgleich i.v.
- Mechanischer Ileus: meist operativ
- Paralytischer Ileus: Ursache behandeln, Motilität fördern
- Engmaschiges Monitoring

Pflegeproblem	Gefahr von Volumenmangel und Komplikationen r/t gestörter Darmpassage m/d/s Erbrechen, geblähtem Abdomen, Stuhlverhalt
Ressourcen	Stationäre Versorgung, Patient kooperativ
Pflegeziel	Der Patient bleibt kreislaufstabil und ausreichend hydriert; Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Nüchtern lassen, Magensonde nach AO pflegen, Ablauf dokumentieren • i.v.-Volumen/Elektrolyte nach AO, Bilanz • Vitalzeichen, Bauchbefund und Darmgeräusche engmaschig • Schmerzmanagement nach AO • Auf Peritonitis-/Schockzeichen achten, OP-Vorbereitung
Evaluation	Kreislaufstabil, ausreichend hydriert, keine Komplikationszeichen, Passage wiederhergestellt.

Leistenhernie K40

Vorwölbung von Bauchinhalt durch eine Schwachstelle in der Leistenregion. Gefahr der Einklemmung (Inkarzeration) mit Durchblutungsstörung; Therapie operativ.

SYMPTOME

- Vorwölbung/Schwellung in der Leiste
- Ziehen/Schmerz, v. a. bei Belastung
- Reponierbar (unkompliziert)
- Bei Inkarzeration: starke Schmerzen, nicht reponierbar, Übelkeit
- Ggf. Ileuszeichen bei Einklemmung

DIAGNOSTIK

- Klinische Untersuchung (Reponierbarkeit)
- Sonografie bei Unklarheit
- Bei Verdacht auf Inkarzeration rasche Abklärung
- Vitalzeichen

THERAPIE

- Elektive Operation (Netzverfahren)
- Bei Inkarzeration: Notfall-OP
- Perioperative Pflege
- Postoperativ Schonung, schweres Heben vermeiden
- Analgesie nach AO

Pflegeproblem	Gefahr einer Inkarzeration r/t Leistenhernie m/d/s nicht reponibler, schmerzhafter Vorwölbung
Ressourcen	Patient kooperativ, Versteht Warnzeichen
Pflegeziel	Eine Einklemmung wird früh erkannt; postoperativ ist der Patient schmerzarm und komplikationsfrei
Maßnahmen	• Auf Inkarzerationszeichen achten (starker Schmerz, nicht reponibel, Übelkeit) • Perioperative Vorbereitung/Nachsorge, Wundkontrolle • Schmerzmanagement nach AO • Beratung zu Heben/Pressen und Obstipationsprophylaxe • Vitalzeichen überwachen
Evaluation	Keine unerkannte Inkarzeration, postoperativ schmerzarm, Wunde reizlos.

Stomaversorgung (Kolo-/Ileostomie) Z93

Operativ angelegte künstliche Darmöffnung (Stoma) zur Stuhlableitung. Pflegerischer Schwerpunkt: Versorgung, Hautschutz und Anleitung zur Selbstständigkeit.

SYMPTOME

- Stoma (rosig, feucht, leicht erhaben)
- Stuhlausscheidung über das Stoma
- Mögliche peristomale Hautreizung
- Komplikationen: Retraktion, Prolaps, Stenose, Parastomalhernie
- Psychische Belastung/ Akzeptanzprobleme

DIAGNOSTIK

- Inspektion von Stoma und peristomaler Haut
- Beurteilung von Durchblutung/ Vitalität des Stomas
- Ausscheidungskontrolle (Menge/ Konsistenz)
- Bei Komplikationen ärztliche/ Stomatherapeuten-Vorstellung

THERAPIE

- Sachgerechte Versorgung (passende Basisplatte/Beutel)
- Peristomaler Hautschutz
- Bei Komplikationen Anpassung/ ärztliche Behandlung
- Ernährungsberatung
- Einbindung der Stomatherapie

Pflegeproblem	Gefahr einer Hautschädigung r/t Stuhlkontakt bei Stoma m/d/s peristomaler Hautrötung/Reizung
Ressourcen	Patient lernbereit, Stomatherapie verfügbar, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Die peristomale Haut bleibt intakt; der Patient versorgt sein Stoma zunehmend selbstständig
Maßnahmen	• Versorgungssystem sachgerecht und dicht anpassen, Leckagen vermeiden • Peristomalen Hautschutz anwenden, Haut regelmäßig beurteilen • Ausscheidung dokumentieren, Komplikationen früh erkennen • Patienten Schritt für Schritt zur Selbstversorgung anleiten • Psychische Unterstützung, Stomatherapie/Ernährungsberatung einbeziehen
Evaluation	Peristomale Haut intakt, dichte Versorgung, zunehmende Selbstständigkeit.

Thoraxdrainage-Pflege Z48.0

Drainage des Pleuraraums zur Ableitung von Luft (Pneumothorax) oder Flüssigkeit (Erguss/Blut). Pflegerischer Schwerpunkt: sichere Handhabung des Drainagesystems und Überwachung.

SYMPTOME

- Liegende Thoraxdrainage mit Drainagesystem
- Atemabhängige Schwankung/Sog (je nach System)
- Mögliche Luftleckage (Blubbern)
- Atemnot/Schmerz bei Komplikationen
- Sekret-/Luftförderung

DIAGNOSTIK

- Atmung/SpO_2 und Vitalzeichen überwachen
- Drainagesystem prüfen (Sog, Wasserschloss, Fördermenge)
- Röntgen Thorax zur Lagekontrolle
- Auf Komplikationen (Dislokation, Verstopfung, Hautemphysem) achten

THERAPIE

- Korrekte Position des Drainagesystems (unter Thoraxniveau, kein Abknicken)
- Sog nach AO einstellen
- Fördermenge/Luftleck dokumentieren
- Schmerzmanagement, Atemtherapie/Mobilisation
- Entfernung nach AO bei Besserung

Pflegeproblem	Gefahr einer respiratorischen Komplikation r/t liegender Thoraxdrainage m/d/s Pneumothorax/Erguss, Dislokationsrisiko
Ressourcen	Patient kooperativ, Funktionierendes Drainagesystem
Pflegeziel	Die Drainage funktioniert sicher; der Patient bleibt respiratorisch stabil ($SpO_2 \geq 94$ %)
Maßnahmen	• Drainagesystem korrekt führen und regelmäßig kontrollieren (Sog/Wasserschloss/Förderung/Leck) • Atmung/SpO_2/Vitalzeichen überwachen, Eintrittsstelle beobachten • Schmerzmanagement, Atemtherapie und Mobilisation • Lage-/Verbandkontrolle, Komplikationen früh erkennen • Bei Diskonnektion/Dislokation nach Standard handeln und Arzt informieren
Evaluation	Drainage funktioniert sicher, SpO_2 stabil, keine Komplikation.

Postoperative Wundinfektion (SSI) T81.4

Infektion im Operationsgebiet nach einem Eingriff (Surgical Site Infection), oberflächlich oder tief. Wichtig: Früherkennung, Hygiene und Wundmanagement.

SYMPTOME

- Rötung, Schwellung, Überwärmung der Wunde
- Schmerzzunahme
- Eitrige Sekretion/Wunddehiszenz
- Fieber
- Verzögerte Wundheilung

DIAGNOSTIK

- Wundinspektion (Lokalzeichen)
- Temperatur/Entzündungswerte
- Wundabstrich nach AO
- Beurteilung von Sekret/Wundheilung
- Ggf. Bildgebung bei tiefer Infektion

THERAPIE

- Wundmanagement nach AO (Reinigung, ggf. Eröffnung/Drainage)
- Antibiotika bei Indikation nach AO
- Aseptischer Verbandwechsel
- Schmerzmanagement
- Ernährung/Allgemeinzustand optimieren

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Hautintegrität/Infektion r/t postoperativer Wundinfektion m/d/s Rötung, Sekretion, verzögerter Heilung
Ressourcen	Patient kooperativ, Gute Wundheilungsvoraussetzungen
Pflegeziel	Die Wundinfektion ist rückläufig (abnehmende Lokalzeichen), keine Ausbreitung
Maßnahmen	• Wunde regelmäßig beurteilen und dokumentieren • Aseptischer Verbandwechsel, konsequente Händehygiene • Temperatur/Entzündungszeichen überwachen • Wundmanagement und Antibiotika nach AO • Ernährung/Mobilisation fördern, Edukation, Hygienemaßnahmen
Evaluation	Lokalzeichen rückläufig, kein Fieber, fortschreitende Wundheilung.

Divertikulitis K57

Entzündung von Ausstülpungen der Darmwand (Divertikel), meist im Sigma. Verlauf von leicht bis kompliziert (Abszess, Perforation).

SYMPTOME

- Schmerzen im linken Unterbauch
- Fieber
- Stuhlunregelmäßigkeiten (Obstipation/Diarrhö)
- Übelkeit
- Druckschmerz/Abwehrspannung links
- Bei Komplikation: Peritonitiszeichen

DIAGNOSTIK

- Klinik (Druckschmerz links)
- Labor (Entzündungswerte)
- CT-Abdomen (Schweregrad/ Komplikationen)
- Vitalzeichen
- Koloskopie erst nach Abklingen der Akutphase

THERAPIE

- Leichte Form: Ernährung/ Schonung, ggf. ambulant
- Antibiotika nach AO bei Indikation
- Bei Komplikation (Abszess/ Perforation): stationär/operativ
- Analgesie nach AO
- Ernährungsberatung (ballaststoffreich nach Akutphase)

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Divertikelentzündung m/d/s linksseitigem Unterbauchschmerz, Druckschmerz, Fieber
Ressourcen	Patient kooperativ, Frühzeitige Vorstellung
Pflegeziel	Der Patient ist schmerzarm (NRS ≤ 3) und fieberfrei; Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Schmerz-/Temperatur-/Vitalzeichenüberwachung • Ernährung nach AO anpassen, Bilanz • Antibiotika/Analgesie nach AO • Auf Peritonitis-/Komplikationszeichen achten • Ernährungsberatung (ballaststoffreich nach Akutphase)
Evaluation	Schmerz reduziert, fieberfrei, keine Komplikationszeichen.

Psychologie für Pflege

10 Krankheitsbilder

Kommunikationsmodelle –

Theoretische Modelle zur Erklärung von Kommunikationsprozessen. In der Pflege grundlegend für therapeutische Kommunikation, Patientenedukation und Teamarbeit.

SYMPTOME

- Kommunikationsprobleme
- Missverständnisse
- Konflikte im Team
- Non-Compliance des Patienten

DIAGNOSTIK

- Gesprächsanalyse
- Selbstreflexion
- Supervision

THERAPIE

- Aktives Zuhören
- Gewaltfreie Kommunikation (GFK)
- Ich-Botschaften
- Feedback-Kultur

Pflegeproblem	Beeinträchtigte verbale Kommunikation r/t sprachlicher Barriere/Aphasie m/d/s Patient kann Bedürfnisse nicht äußern
Ressourcen	Gestik vorhanden, Familie als Dolmetscher, Bildkarten verfügbar
Pflegeziel	Patient kommuniziert 3 Grundbedürfnisse (Schmerz, Hunger, Toilette) mit Hilfsmitteln nach 48h
Maßnahmen	• Kommunikationsboard einsetzen (Bilder/Symbole) • Ja/Nein-Fragen stellen • Einfache kurze Sätze, langsam sprechen • Geduld: Patient nicht unterbrechen • Logopädie einbeziehen • Nonverbale Kommunikation bewusst einsetzen (Mimik, Gestik) • Angehörige als Kommunikationshelfer schulen
Evaluation	Täglich Kommunikationserfolge dokumentieren

KONTROLLFRAGEN

25 **Was besagt das 4-Ohren-Modell nach Schulz von Thun?**

(A) 4 Kommunikationsstile

(B) Jede Nachricht hat 4 Seiten: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung, Appell

(C) 4 Phasen der Kommunikation

(D) 4 Fehler in der Kommunikation

26 **Was ist aktives Zuhören in der Pflege?**

(A) Einfach schweigen

(B) Verbales + nonverbales Signalisieren von Aufmerksamkeit: Blickkontakt, Nicken, Paraphrasieren, offene Fragen, keine Ratschläge

(C) Nur nicken

(D) Patient ausreden lassen ohne Reaktion

27 **Was ist Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Rosenberg?**

A) Kommunikation ohne Schreien

B) 4-Schritte-Modell: Beobachtung - Gefühl - Bedürfnis - Bitte

C) Ein Konfliktmanagement-Kurs

D) Schweigen bei Konflikten

Stressbewältigung & Burnout Z73

Pflegeberufe haben hohes Burnout-Risiko. Burnout = emotionale Erschöpfung + Depersonalisation + reduzierte Leistungsfähigkeit. Prävention ist Kernaufgabe des Selbstmanagements.

SYMPTOME

- Emotionale Erschöpfung
- Zynismus, Distanzierung
- Leistungsabfall
- Schlafstörungen
- Psychosomatische Beschwerden
- Innere Kündigung

DIAGNOSTIK

- Maslach Burnout Inventory (MBI)
- Selbstreflexion
- Supervision
- Betriebsärztliche Beratung

THERAPIE

- Ressourcenaktivierung
- Work-Life-Balance
- Supervision
- Psychotherapie
- Stressmanagement-Techniken

Pflegeproblem	Risiko Burnout r/t chronischer Arbeitsbelastung und unzureichender Erholung m/d/s MBI-Score erhöht
Ressourcen	Hohe Berufsmotivation, Kollegiales Team, Sport als Ausgleich
Pflegeziel	Mitarbeiter benennt 3 persönliche Stressbewältigungsstrategien und nutzt sie regelmäßig
Maßnahmen	• Supervision regelmäßig anbieten • Dienstplanung: ausreichend Erholungszeiten • Ressourcen stärken: was gibt Energie? • Grenzen setzen: Nein sagen lernen • Progressive Muskelrelaxation (PMR) anleiten • Kollegiale Fallberatung etablieren
Evaluation	Nach 4 Wochen: MBI-Score, subjektives Wohlbefinden

KONTROLLFRAGEN

28 **Was sind die 3 Kernkomponenten des Burnout-Syndroms nach Maslach?**

A) Müdigkeit, Kopfschmerz, Rücken

B) Emotionale Erschöpfung + Depersonalisation + reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit

C) Stress, Konflikte, Überstunden

D) Depression, Angst, Panik

29 **Was ist Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobson?**

A) Eine Sportart

B) Stressbewältigungstechnik: bewusstes An- und Entspannen von Muskelgruppen → körperliche Entspannung → mentale Entspannung

C) Eine Massagetechnik

D) Ein Atemübungskonzept

30 **Was versteht man unter 'Selbstfürsorge' in der Pflege?**

A Eigene Interessen über Patienten stellen

B Bewusster Umgang mit den eigenen Ressourcen um langfristig gesund und arbeitsfähig zu bleiben

C Nur Urlaub nehmen

D Sich nicht um Arbeit kümmern

Motivationstheorien –

Theorien zur Erklärung menschlichen Verhaltens und Antriebe. In der Pflege relevant für Patientenedukation, Compliance-Förderung und Teamführung.

SYMPTOME
- Mangelnde Compliance
- Non-Adhärenz
- Motivationsprobleme im Team

DIAGNOSTIK
- Motivationsanalyse
- Gespräch
- Zielvereinbarung

THERAPIE
- Motivierende Gesprächsführung
- Ressourcenorientierung
- Zielvereinbarung

KONTROLLFRAGEN

31 **Was beschreibt Maslows Bedürfnispyramide?**

A 5 Kommunikationsstufen

B Hierarchie menschlicher Bedürfnisse: Physiologisch → Sicherheit → Soziales → Anerkennung → Selbstverwirklichung

C 5 Stressstufen

D 5 Lerntypen

32 **Was ist motivierende Gesprächsführung (Motivational Interviewing)?**

A Überredung des Patienten

B Patientenzentrierte Technik: Autonomie stärken, Ambivalenz erkunden, eigene Motivation aktivieren – nicht sagen was Patient tun soll

C Direktive Beratung

D Informationsvermittlung

33 **Was ist das Transtheoretische Modell (TTM) der Verhaltensänderung?**

A Ein Kommunikationsmodell

B 5 Stadien der Verhaltensänderung: Absichtslosigkeit → Absichtsbildung → Vorbereitung → Handlung → Aufrechterhaltung

C Ein Stressmodell

D Ein Lernmodell

Professionelle Nähe und Distanz –

Balance zwischen empathischer Zuwendung und professioneller Abgrenzung in der Pflegebeziehung. Zu viel Distanz wirkt kalt, zu viel Nähe überfordert und verwischt die Rollen.

SYMPTOME

- Übermäßige emotionale Verstrickung oder Gleichgültigkeit
- Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen
- Gefühl der Überforderung/ Ausbrennen
- Bevorzugung/Abneigung einzelner Patienten
- Rollenunklarheit

DIAGNOSTIK

- Selbstreflexion eigener Gefühle/ Reaktionen
- Kollegiale Beratung/Supervision
- Beobachtung von Beziehungsdynamiken
- Feedback im Team

THERAPIE

- Bewusste Rollenklärung und Grenzen
- Empathie mit professioneller Abgrenzung verbinden
- Supervision/Intervision nutzen
- Selbstfürsorge
- Klare, wertschätzende Kommunikation

Pflegeproblem	Gefahr emotionaler Überlastung r/t mangelnder Nähe-Distanz-Balance m/d/s Überforderungsgefühl, unklaren Grenzen
Ressourcen	Team/Supervision verfügbar, Bereitschaft zur Selbstreflexion
Pflegeziel	Die Pflegekraft gestaltet die Beziehung empathisch und zugleich professionell abgegrenzt
Maßnahmen	• Rollen und Grenzen bewusst klären und kommunizieren • Eigene Gefühle reflektieren, Supervision/Intervision nutzen • Empathie mit Abgrenzung verbinden • Selbstfürsorge praktizieren • Beziehungsdynamiken im Team besprechen
Evaluation	Beziehung tragfähig, Grenzen gewahrt, keine Überlastung.

Umgang mit Sterben, Tod und Trauer –

Begleitung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen sowie der Umgang mit Trauer. Erfordert Haltung, kommunikative Kompetenz und Selbstfürsorge.

SYMPTOME

- Sterbephasen (nach Kübler-Ross: Nicht-wahrhaben, Zorn, Verhandeln, Depression, Akzeptanz)
- Angst, Schmerz, Rückzug
- Belastung der Angehörigen
- Trauerreaktionen
- Eigene Betroffenheit der Pflegenden

DIAGNOSTIK

- Bedürfnisse und Wünsche des Sterbenden erfassen
- Belastung der Angehörigen einschätzen
- Symptome/Leiden beobachten
- Patientenverfügung/Wünsche beachten

THERAPIE

- Palliative Begleitung, Symptomlinderung nach AO
- Würde, Ruhe und Präsenz ermöglichen
- Angehörige einbeziehen und begleiten
- Spirituelle/seelsorgerische Unterstützung anbieten
- Abschied ermöglichen

Pflegeproblem	Bedürfnis nach würdevoller Begleitung r/t Sterbeprozess m/d/s Angst, Schmerz, Belastung von Patient und Angehörigen
Ressourcen	Angehörige anwesend, Palliativteam/Seelsorge verfügbar, Wünsche/Verfügung bekannt
Pflegeziel	Der sterbende Mensch wird würdevoll und möglichst beschwerdearm begleitet; Angehörige fühlen sich unterstützt
Maßnahmen	• Präsenz, Zuwendung, Zuhören • Schmerz-/Symptomkontrolle nach AO • Würde und Wünsche respektieren, Ruhe ermöglichen • Angehörige einbeziehen und begleiten, Abschied ermöglichen • Seelsorge/Palliativteam einbinden, Selbstfürsorge
Evaluation	Beschwerden gelindert, Würde gewahrt, Angehörige begleitet.

Umgang mit Angst beim Patienten –

Angst ist eine häufige Reaktion auf Krankheit, Eingriffe und Klinikaufenthalt. Pflegerischer Umgang zielt auf Sicherheit, Information und emotionale Entlastung.

SYMPTOME

- Unruhe, Anspannung, Nervosität
- Vegetative Zeichen (Herzrasen, Schwitzen, Zittern)
- Vermeidung, Rückzug oder Klammern
- Fragen/Rückversicherung, Schlafstörungen
- Konzentrations-/ Kooperationsprobleme

DIAGNOSTIK

- Angst und Auslöser erfragen/ beobachten
- Vegetative Zeichen wahrnehmen
- Informationsbedarf einschätzen
- Vorerfahrungen/ Bewältigungsmuster erfragen

THERAPIE

- Sichere, ruhige Atmosphäre, Präsenz
- Verständliche Information und Aufklärung
- Beteiligung und Kontrolle ermöglichen
- Beruhigungs-/ Entspannungstechniken
- Bei Bedarf ärztliche/ psychologische Unterstützung

Pflegeproblem	Angst r/t Krankheit/Eingriff/Klinikaufenthalt m/d/s Unruhe, vegetativen Zeichen, Rückversicherungsbedarf
Ressourcen	Patient äußert sich, Angehörige unterstützen, Bewältigungserfahrungen vorhanden
Pflegeziel	Der Patient fühlt sich sicherer und ist merklich entlastet (ruhiger, kooperativer)
Maßnahmen	• Ruhige, sichere Atmosphäre und Präsenz • Verständlich informieren und aufklären • Mitbestimmung/Kontrolle ermöglichen • Entspannungs-/Ablenkungsangebote • Bei starker Angst ärztliche/psychologische Unterstützung
Evaluation	Angst reduziert, ruhiger, kooperativer.

Validierender Umgang bei Demenz –

Kommunikationshaltung, die die Gefühle und die subjektive Wirklichkeit demenziell erkrankter Menschen wertschätzt, statt sie zu korrigieren (Validation).

SYMPTOME

- Desorientierung, Zeit-/ Ortsverwirrung
- Wiederholtes Fragen, Hinlauftendenz
- Unruhe, Angst, Aggression bei Korrektur
- Rückzug
- Herausforderndes Verhalten

DIAGNOSTIK

- Bedürfnisse hinter dem Verhalten erkennen
- Auslöser von Unruhe/Aggression beobachten
- Biografie und Gewohnheiten einbeziehen
- Kommunikationsfähigkeiten einschätzen

THERAPIE

- Validation: Gefühle bestätigen, nicht die Realität korrigieren
- Einfache, ruhige Kommunikation, Blickkontakt
- Biografiearbeit, vertraute Routinen
- Reizarme, sichere Umgebung
- Herausforderndes Verhalten verstehen statt sanktionieren

Pflegeproblem	Herausforderndes Verhalten/Unruhe r/t Demenz und Desorientierung m/d/s Angst, Aggression bei Korrektur
Ressourcen	Biografie bekannt, Angehörige unterstützen, Vertraute Routinen
Pflegeziel	Der Mensch mit Demenz fühlt sich verstanden und sicher; Unruhe/Aggression nehmen ab
Maßnahmen	• Validierend kommunizieren (Gefühle bestätigen, nicht korrigieren) • Einfache, ruhige Sprache, Blickkontakt, Zeit • Biografie/Routinen einbeziehen, Orientierungshilfen • Auslöser meiden, reizarme sichere Umgebung • Geduld und Wertschätzung, Angehörige einbeziehen
Evaluation	Weniger Unruhe/Aggression, fühlt sich sicherer und verstanden.

Deeskalation und Umgang mit Aggression –

Strategien zur Verhinderung und Entschärfung aggressiver oder gewaltträchtiger Situationen durch Kommunikation, Haltung und Eigenschutz.

SYMPTOME

- Zunehmende Anspannung, lautere Stimme
- Drohgebärden, motorische Unruhe
- Gereiztheit, Provokation
- Eingeengtes Denken
- Vorboten von Gewalt

DIAGNOSTIK

- Frühwarnzeichen wahrnehmen
- Auslöser/Bedürfnisse erkennen
- Eigene Sicherheit/Fluchtweg einschätzen
- Situationsdynamik beobachten

THERAPIE

- Ruhig bleiben, Distanz wahren, reizarm
- Aktiv zuhören, ernst nehmen, Optionen anbieten
- Klare, einfache Kommunikation, nicht provozieren
- Eigenschutz/Team, Hilfe holen
- Nachbesprechung/Reflexion

Pflegeproblem	Gefahr von Gewalt/Eskalation r/t Aggression m/d/s zunehmender Anspannung, Drohgebärden
Ressourcen	Team verfügbar, Deeskalationskompetenz, Erkennbare Auslöser
Pflegeziel	Die Situation wird deeskaliert; Patient und Mitarbeitende bleiben unversehrt
Maßnahmen	• Frühwarnzeichen erkennen und früh deeskalieren • Ruhe, Distanz, Eigenschutz, reizarme Umgebung • Aktiv zuhören, ernst nehmen, Optionen anbieten • Bei Gefährdung Team/Hilfe holen • Nachbesprechung und Reflexion der Auslöser
Evaluation	Situation entschärft, niemand verletzt, Auslöser reflektiert.

Kultursensible Kommunikation –

Pflege, die kulturelle, religiöse und sprachliche Hintergründe achtet und Missverständnisse vermeidet (transkulturelle Kompetenz).

SYMPTOME

- Sprachbarrieren, Missverständnisse
- Unterschiedliche Krankheits-/Schmerzkonzepte
- Religiöse/kulturelle Bedürfnisse (Ernährung, Rituale, Geschlecht)
- Unsicherheit/Rückzug
- Konflikte durch unterschiedliche Erwartungen

DIAGNOSTIK

- Sprach-/Verständigungsbedarf erfassen
- Kulturelle/religiöse Bedürfnisse erfragen
- Eigene Vorurteile reflektieren
- Ressourcen (Dolmetscher, Angehörige) klären

THERAPIE

- Respektvolle, offene Haltung, nachfragen statt annehmen
- Dolmetscher/Übersetzungshilfen nutzen
- Bedürfnisse (Ernährung, Rituale, Schamgefühl) berücksichtigen
- Einfache Sprache, nonverbale Kommunikation
- Individuell statt stereotyp

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Kommunikation r/t Sprach-/Kulturunterschieden m/d/s Missverständnissen, Unsicherheit
Ressourcen	Dolmetscher/Angehörige verfügbar, Patient kooperativ, Offenheit im Team
Pflegeziel	Die Verständigung gelingt; kulturelle/religiöse Bedürfnisse werden berücksichtigt
Maßnahmen	• Verständigung sichern (Dolmetscher, einfache Sprache, Hilfsmittel) • Kulturelle/religiöse Bedürfnisse erfragen und respektieren • Schamgefühl/Präferenzen beachten • Offen, individuell und ohne Stereotype handeln • Angehörige einbeziehen
Evaluation	Verständigung gelungen, Bedürfnisse berücksichtigt, weniger Konflikte.

Umgang mit depressiven Patienten –

Pflegerischer Umgang mit Menschen mit depressiver Symptomatik: Beziehung, Struktur, behutsame Aktivierung und Beobachtung – ohne Überforderung oder Bagatellisierung.

SYMPTOME

- Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit
- Interessenverlust, Rückzug
- Schlaf-/Appetitstörungen
- Negatives Denken, Hoffnungslosigkeit
- Verlangsamung, ggf. Suizidgedanken

DIAGNOSTIK

- Stimmung, Antrieb, Rückzug beobachten
- Auf Hoffnungslosigkeit/Suizidalität achten (offen ansprechen)
- Schlaf/Appetit/Tagesstruktur erfassen
- Ressourcen und Belastungen erfragen

THERAPIE

- Tragfähige, wertschätzende Beziehung
- Realistische Tagesstruktur, kleine erreichbare Ziele
- Behutsame Aktivierung ohne Überforderung
- Medikamentöse/ psychotherapeutische Behandlung nach AO
- Bei Suizidalität Schutz und ärztliche Einbindung

Pflegeproblem	Antriebslosigkeit und sozialer Rückzug r/t depressiver Symptomatik m/d/s Interessenverlust, Hoffnungslosigkeit
Ressourcen	Patient lässt Kontakt zu, Angehörige unterstützen, Behandlung läuft
Pflegeziel	Der Patient nimmt zunehmend an Struktur/Aktivitäten teil; Suizidalität wird sicher erfasst
Maßnahmen	• Wertschätzende, geduldige Beziehung, ernst nehmen • Tagesstruktur und kleine erreichbare Ziele unterstützen • Behutsam aktivieren, Erfolge würdigen • Schlaf/Ernährung/Körperpflege fördern • Auf Suizidalität achten, offen ansprechen, Arzt/Team einbeziehen
Evaluation	Mehr Teilnahme/Antrieb, Suizidalität erfasst und adressiert.

Gynäkologie

17 Krankheitsbilder

Mammakarzinom C50

Häufigste Krebserkrankung der Frau (30% aller Karzinome). Invasives duktales oder lobuläres Karzinom. Risikofaktoren: BRCA1/2, Alter, Hormone, Adipositas. 5-Jahres-Überleben Stad. I: >95%.

SYMPTOME

- Schmerzlose Verhärtung der Brust
- Hautveränderungen (Orangenhaut, Einziehungen)
- Brustwarzeneinziehung oder -ausfluss
- Axilläre Lymphknotenschwellung
- Asymmetrie der Brust
- Hautrötung/Überwärmung (inflammatorisch)

DIAGNOSTIK

- Mammographie (Screening ab 50)
- Sonographie
- MRT Mamma
- Stanzbiopsie (Histologie)
- Sentinel-Lymphknoten-Biopsie
- Staging: CT, Knochenszintigraphie

THERAPIE

- Operation: BET (brusterhaltend) oder Mastektomie
- Sentinel-LK-Biopsie / Axilladissektion
- Strahlentherapie nach BET
- Chemotherapie (neo-/adjuvant)
- Antihormontherapie (Tamoxifen, Aromatasehemmer)
- Herceptin bei HER2-positiv

Pflegeproblem	Beeinträchtigtes Körperbild r/t Mastektomie/Narbe m/d/s Patientin betrachtet Wunde nicht, äußert Scham
Ressourcen	Vertrauensvolle Beziehung zur Pflegekraft, Unterstützender Partner, Offenheit für Gespräche
Pflegeziel	Patientin betrachtet Wundbereich und benennt 2 positive Aspekte ihres Körpers bis zur Entlassung
Maßnahmen	• Einfühlsame Wundpflege: Patientin einbeziehen, nicht drängen • Aktives Zuhören: Gefühle ernst nehmen, nicht bagatellisieren • Informationen über Brustprothesen, Rekonstruktion anbieten • Kontakt zu Selbsthilfegruppe (z.B. Frauenselbsthilfe nach Krebs) • Sexualberatung bei Bedarf ansprechen • Psychoonkologischen Dienst einbeziehen
Evaluation	Täglich Gesprächsbereitschaft beobachten, Körperbildwahrnehmung erfragen

Pflegeproblem	Risiko Lymphödem r/t Axilladissektion m/d/s Einschränkung Lymphabfluss rechter Arm
Ressourcen	Versteht Prophylaxemaßnahmen, Kooperativ
Pflegeziel	Patientin benennt Lymphödem-Prophylaxemaßnahmen korrekt vor Entlassung
Maßnahmen	• Keine Blutdruck-Messungen, Injektionen, Blutabnahmen am betroffenen Arm • Armlymphödem-Prophylaxe schulen: kein enger Schmuck, keine Hitze • Manuelle Lymphdrainage nach Anordnung • Kompressionshandschuh/-ärmel anpassen • Auf Infektionszeichen achten (Rötung, Schwellung, Wärme) • Arm bei Ruhe hochlagern
Evaluation	Armumfang täglich messen, Ödem dokumentieren

KONTROLLFRAGEN

34 **Was bedeutet BET in der Mammakarzinom-Therapie?**

- A Beidseitige Entfernung der Tumore
- B Brusterhaltende Therapie: Tumorektomie + Strahlentherapie statt Mastektomie
- C Eine Chemotherapie-Art
- D Biologische Ersatztherapie

35 **Was ist beim Lymphödem-Risiko nach Axilladissektion zu beachten?**

- A Kein Problem
- B Kein RR-Messen, keine Injektionen, keine Blutabnahmen am betroffenen Arm – Infektionsschutz!
- C Nur keine heißen Bäder
- D Nur Armhochlagerung

36 **Was ist der Sentinel-Lymphknoten?**

- A Der größte Lymphknoten
- B Der erste drainierende Lymphknoten = Wächterlymphknoten: Befall → höheres Metastasierungsrisiko
- C Ein gesunder Lymphknoten
- D Der entfernteste Lymphknoten

Präeklampsie / Eklampsie O14

Hypertensive Schwangerschaftserkrankung ab 20. SSW. Präeklampsie: RR ≥140/90 + Proteinurie. Schwere Form: HELLP-Syndrom. Eklampsie: zerebrale Krampfanfälle. Lebensbedrohlich für Mutter und Kind.

SYMPTOME

- RR ≥ 140/90 mmHg nach 20. SSW
- Proteinurie > 0,3g/24h
- Ödeme (Gesicht, Hände)
- Kopfschmerzen
- Sehstörungen, Flimmern
- Oberbauchschmerzen (HELLP)
- Übelkeit, Erbrechen
- Hyperreflexie

DIAGNOSTIK

- RR-Messung (mehrfach)
- Proteinurie (Streifentest, 24h-Urin)
- Labor: Thrombozyten, Transaminasen, LDH, Harnsäure
- CTG, Doppler-Sonographie
- Augenhintergrund

THERAPIE

- Stationäre Überwachung
- Antihypertensiva: Methyldopa, Nifedipin, Labetalol
- Magnesium i.v. (Eklampsie-Prophylaxe!)
- Bei Eklampsie: Diazepam, Sicherung Atemweg
- Entbindung = einzige Heilung
- Frühgeburt einkalkulieren

Pflegeproblem	Risiko mütterlicher Verletzung r/t möglichem Eklampsie-Anfall m/d/s RR 160/100, Hyperreflexie
Ressourcen	Hospitalisiert, CTG-Monitoring vorhanden, Kooperative Patientin
Pflegeziel	Patientin erleidet keinen Krampfanfall durch konsequente Prophylaxe und Überwachung
Maßnahmen	• RR alle 15-30 Min. messen und dokumentieren • Magnesium i.v. nach Anordnung: Laufrate kontrollieren • Patellarsehnenreflex stündlich prüfen (Mg-Toxizität!) • Atemfrequenz überwachen (> 12/Min.!) • Antidot Calciumgluconat griffbereit halten • Reizarme Umgebung: Licht dimmen, Ruhe • Sturzprophylaxe: Bettgitter hochstellen • Krampfbereitschaft: Beißkeil, Sauger, O_2 bereit
Evaluation	Kontinuierliches Monitoring, sofort Arzt bei RR > 160/110 oder Reflexveränderungen

KONTROLLFRAGEN

37 **Was ist das HELLP-Syndrom?**

A) Ein Herzfehler
B) Schwere Präeklampsie: Hämolyse + Elevated Liver enzymes + Low Platelets – lebensbedrohlich!
C) Eine Allergie
D) Ein Atemwegsproblem

38 **Warum wird Magnesiumsulfat bei Eklampsie eingesetzt?**

A) Als Diuretikum
B) Krampfprophylaxe und -therapie: Mg hemmt neuromuskuläre Übertragung – Antidot: Calciumgluconat!
C) Als Blutdruckmittel
D) Als Tokolytikum

39 **Wann spricht man von Eklampsie?**

A) Bei hohem Blutdruck allein
B) Bei Krampfanfall im Rahmen einer Präeklampsie – medizinischer Notfall!
C) Bei Ödemen
D) Bei Proteinurie

Endometriose N80

Vorkommen von gebärmutterschleimhaut-ähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutterhöhle. Häufige Ursache chronischer Unterbauchschmerzen und von Unfruchtbarkeit.

SYMPTOME

- Zyklusabhängige, oft starke Unterbauchschmerzen
- Dysmenorrhö (schmerzhafte Regel)
- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
- Zyklusstörungen
- Unerfüllter Kinderwunsch
- Müdigkeit

DIAGNOSTIK

- Anamnese (zyklusabhängiger Schmerz)
- Gynäkologische Untersuchung
- Sonografie
- Laparoskopie (Sicherung)
- Schmerzverlauf/Zyklusbezug

THERAPIE

- Schmerztherapie nach AO
- Hormontherapie nach AO
- Operative Entfernung der Herde (Laparoskopie)
- Kinderwunschbehandlung bei Bedarf
- Begleitung/Beratung

Pflegeproblem	Chronischer Schmerz r/t Endometriose m/d/s zyklusabhängigem Unterbauchschmerz, Dysmenorrhö
Ressourcen	Patientin kooperativ, Behandlung läuft
Pflegeziel	Die Patientin ist schmerzgelindert (NRS ≤ 3) und kann mit der Erkrankung umgehen
Maßnahmen	• Schmerzmanagement nach AO, Wirkung/Zyklusbezug dokumentieren • Wärme/Entspannung anbieten • Perioperative Pflege bei Eingriff • Psychische Unterstützung (Schmerz, Kinderwunsch) • Edukation zu Hormon-/Schmerztherapie
Evaluation	Schmerz gelindert, Patientin informiert und entlastet.

Uterus myomatosus (Myome) D25

Gutartige Muskelknoten der Gebärmutter (Myome). Häufig; können Blutungsstörungen, Druckgefühl und Schmerzen verursachen.

SYMPTOME

- Verstärkte/verlängerte Regelblutung
- Unterbauchschmerzen/ Druckgefühl
- Blutungsanämie möglich
- Harndrang/Obstipation bei Druck
- Oft auch beschwerdefrei

DIAGNOSTIK

- Gynäkologische Untersuchung
- Sonografie
- Labor (Anämie bei starker Blutung)
- Ggf. Hysteroskopie
- Verlaufskontrolle

THERAPIE

- Beobachtung bei Beschwerdefreiheit
- Hormon-/Blutungstherapie nach AO
- Operative Entfernung (Myomenukleation) oder Hysterektomie
- Behandlung der Anämie
- Beratung

Pflegeproblem	Gefahr einer Anämie r/t verstärkter Blutung bei Uterus myomatosus m/d/s Hypermenorrhö, Müdigkeit
Ressourcen	Patientin kooperativ, Behandlung verfügbar
Pflegeziel	Die Blutung ist kontrolliert; eine Anämie wird erkannt und behandelt
Maßnahmen	• Blutungsstärke und Anämiezeichen beobachten • Labor/Eisentherapie nach AO unterstützen • Schmerzmanagement nach AO • Perioperative Pflege bei OP • Edukation zu Therapieoptionen
Evaluation	Blutung kontrolliert, keine/behandelte Anämie, Patientin informiert.

Ovarialkarzinom C56

Bösartiger Tumor der Eierstöcke, oft spät symptomatisch und daher häufig erst in fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert.

SYMPTOME

- Lange unspezifisch/symptomarm
- Zunehmender Bauchumfang/ Aszites
- Druck-/Völlegefühl, Verdauungsbeschwerden
- Unterbauchschmerzen
- Gewichtsverlust, Leistungsminderung

DIAGNOSTIK

- Gynäkologische Untersuchung
- Sonografie/CT
- Tumormarker (z. B. CA-125) nach AO
- Histologie (operativ)
- Staging

THERAPIE

- Operative Tumorentfernung
- Chemotherapie nach AO
- Symptom-/Aszitesmanagement
- Supportive/palliative Therapie bei Bedarf
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Belastung durch Symptome und Diagnose r/t Ovarialkarzinom m/d/s Aszites, Schmerzen, Sorge
Ressourcen	Angehörige unterstützen, Psychoonkologie verfügbar
Pflegeziel	Die Patientin ist symptomkontrolliert und fühlt sich in der Krankheitsbewältigung unterstützt
Maßnahmen	• Perioperative/onkologische Pflege, Symptomkontrolle • Aszites/Bauchumfang/Ernährung/Bilanz beobachten • Chemotherapie-Nebenwirkungen nach AO managen • Schmerztherapie nach AO • Psychoonkologische Begleitung, Angehörige einbeziehen
Evaluation	Symptome kontrolliert, Patientin unterstützt und informiert.

Zervixkarzinom (Gebärmutterhalskrebs) C53

Bösartiger Tumor des Gebärmutterhalses, meist durch HPV-Infektion bedingt. Früherkennung (Vorsorge) und HPV-Impfung sind wichtig.

SYMPTOME

- Frühstadium oft symptomlos
- Kontaktblutungen (z. B. nach Verkehr)
- Zwischen-/Postmenopausenblutungen
- Ausfluss
- Fortgeschritten: Schmerzen, Beschwerden

DIAGNOSTIK

- Vorsorge: Zytologie (Pap), HPV-Test
- Kolposkopie, Biopsie
- Bildgebung zum Staging
- Gynäkologische Untersuchung

THERAPIE

- Operative Therapie (je nach Stadium)
- Strahlen-/Chemotherapie nach AO
- Nachsorge
- Prävention: HPV-Impfung, Vorsorge
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Belastung und Symptome r/t Zervixkarzinom und Therapie m/d/s Blutungen, Sorge, Therapienebenwirkungen
Ressourcen	Patientin kooperativ, Psychoonkologie/Angehörige
Pflegeziel	Die Patientin ist symptomkontrolliert und in der Bewältigung unterstützt
Maßnahmen	• Perioperative/onkologische Pflege • Therapienebenwirkungen nach AO managen • Schmerz-/Symptomkontrolle, Intimsphäre wahren • Psychische Unterstützung • Edukation zu Vorsorge/HPV-Impfung
Evaluation	Symptome kontrolliert, Patientin informiert und unterstützt.

Extrauteringravidität (Eileiterschwangerschaft) OOO

Einnistung der befruchteten Eizelle außerhalb der Gebärmutterhöhle, meist im Eileiter. Notfall bei Ruptur mit Blutungsgefahr.

SYMPTOME

- Einseitige Unterbauchschmerzen
- Ausbleiben der Regel/positiver Schwangerschaftstest
- Schmierblutung
- Bei Ruptur: akute starke Schmerzen, Kreislaufschock
- Schulterschmerz bei Blutung ins Abdomen

DIAGNOSTIK

- Schwangerschaftstest/β-HCG-Verlauf
- Vaginale Sonografie
- Klinik (Schmerz, Kreislauf)
- Vitalzeichen
- Bei Rupturverdacht rasche Abklärung

THERAPIE

- Engmaschige Kontrolle/medikamentös bei frühem, stabilem Befund nach AO
- Operative Versorgung (oft laparoskopisch)
- Bei Ruptur: Notfall-OP, Volumen/Kreislauf
- Schmerztherapie
- Psychische Begleitung

Pflegeproblem	Gefahr eines hämorrhagischen Schocks r/t möglicher Tubarruptur m/d/s einseitigem Schmerz, Blutungsrisiko
Ressourcen	Frühzeitige Vorstellung, Stationäre Versorgung
Pflegeziel	Eine Ruptur/Blutung wird früh erkannt; die Patientin bleibt kreislaufstabil
Maßnahmen	• Vitalzeichen/Schmerz engmaschig, auf Schockzeichen achten • Bei Ruptur OP-Vorbereitung, i.v.-Volumen nach AO • Schmerzmanagement nach AO • Blutung beobachten, Bilanz • Psychische Begleitung
Evaluation	Kreislaufstabil, Komplikation früh erkannt, Patientin begleitet.

Adnexitis (Eileiter-/Eierstockentzündung) N70

Entzündung der Adnexe (Eileiter/Eierstöcke), meist als aufsteigende Infektion. Kann zu Komplikationen (Abszess, Unfruchtbarkeit) führen.

SYMPTOME

- Unterbauchschmerzen (oft beidseitig)
- Fieber
- Ausfluss
- Schmerzen beim Verkehr
- Allgemeines Krankheitsgefühl
- Druck-/Portioschiebeschmerz

DIAGNOSTIK

- Gynäkologische Untersuchung
- Labor (Entzündungswerte)
- Abstrich/Erregernachweis
- Sonografie (Abszess?)
- Vitalzeichen

THERAPIE

- Antibiotika nach AO
- Schmerz-/Antipyrese nach AO
- Schonung
- Bei Abszess ggf. operative Therapie
- Partnerbehandlung/Beratung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Infektion r/t Adnexitis m/d/s Unterbauchschmerz, Fieber
Ressourcen	Patientin kooperativ, Frühzeitige Behandlung
Pflegeziel	Die Patientin ist schmerzarm (NRS ≤ 3) und fieberfrei; Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Schmerz-/Temperaturüberwachung • Antibiotika/Analgesie nach AO • Schonung, Wärme anbieten • Auf Abszess-/Peritonitiszeichen achten • Edukation zu Therapietreue/Prävention
Evaluation	Schmerz reduziert, fieberfrei, keine Komplikationen.

Descensus genitalis (Beckenbodensenkung) N81

Senkung von Gebärmutter und/oder Scheidenwänden durch Beckenbodenschwäche, teils bis zum Vorfall (Prolaps). Häufig nach Geburten und im Alter.

SYMPTOME

- Fremdkörper-/Druckgefühl nach unten
- Sicht-/tastbarer Vorfall
- Harninkontinenz oder Entleerungsstörung
- Stuhlentleerungsstörung
- Rückenschmerz/Ziehen im Unterbauch

DIAGNOSTIK

- Gynäkologische Untersuchung
- Beurteilung des Senkungsgrades
- Miktions-/Kontinenzanamnese
- Ggf. Restharnbestimmung
- Verlaufsbeurteilung

THERAPIE

- Beckenbodentraining/ Physiotherapie
- Pessartherapie nach AO
- Operative Korrektur bei Bedarf
- Hormonelle Lokaltherapie nach AO
- Beratung (Heben/Gewicht)

Pflegeproblem	Beeinträchtigtes Wohlbefinden/Kontinenz r/t Beckenbodensenkung m/d/s Druckgefühl, Inkontinenz
Ressourcen	Patientin motiviert, Physiotherapie verfügbar
Pflegeziel	Die Patientin ist beschwerdegelindert und beherrscht Beckenbodenübungen/Maßnahmen
Maßnahmen	• Beckenbodentraining anleiten • Pessarpflege unterstützen, Haut kontrollieren • Kontinenz-/Miktionsbeobachtung, Hautschutz • Perioperative Pflege bei OP • Edukation: Heben/Pressen meiden, Obstipationsprophylaxe
Evaluation	Beschwerden gelindert, Übungen/Maßnahmen umgesetzt.

Wochenbett (Puerperium) O90

Zeitraum nach der Geburt (ca. 6–8 Wochen) mit Rückbildung der Geburtsveränderungen. Pflegerischer Fokus: Rückbildung, Wochenfluss, Stillen und Komplikationsprävention.

SYMPTOME

- Uterusrückbildung (Involution)
- Wochenfluss (Lochien)
- Brustveränderungen/ Milcheinschuss
- Erschöpfung, emotionale Labilität
- Risiken: Blutung, Infektion, Thrombose, postpartale Depression

DIAGNOSTIK

- Fundusstand/Uterusrückbildung beurteilen
- Lochien (Menge/Geruch/Farbe) beobachten
- Vitalzeichen, Blutungskontrolle
- Brust/Stillen, Ausscheidung
- Stimmung/psychisches Befinden

THERAPIE

- Rückbildung fördern (Mobilisation, Rückbildungsgymnastik)
- Stillberatung/Brustpflege
- Schmerz-/Wundmanagement (Damm/Sectio) nach AO
- Thrombose-/Infektionsprophylaxe
- Bei Komplikationen ärztliche Behandlung

Pflegeproblem	Gefahr von postpartaler Blutung/Infektion r/t Wochenbett m/d/s Uterusrückbildung, Wochenfluss, Wundheilung
Ressourcen	Mutter motiviert, Unterstützung durch Partner/Familie
Pflegeziel	Die Rückbildung verläuft komplikationslos; Blutungs-/Infektionszeichen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Fundusstand und Lochien regelmäßig beobachten und dokumentieren • Vitalzeichen, auf Infektions-/Thrombosezeichen achten • Stillberatung, Brust-/Dammpflege, Hygiene • Mobilisation und Thromboseprophylaxe • Auf psychisches Befinden achten, Anleitung/Edukation
Evaluation	Rückbildung regelrecht, keine Blutung/Infektion, Mutter angeleitet.

Spontangeburt (physiologische Geburt) O80

Regelrechte vaginale Geburt aus Schädellage am Termin (37+0 bis 41+6 SSW) ohne operative Eingriffe. Verläuft in Phasen: Eröffnungsphase, Austreibungsphase und Nachgeburtsphase.

SYMPTOME

- Regelmäßige, zunehmende Wehen
- Zeichnen (blutig-schleimiger Schleimpfropf)
- Blasensprung (Fruchtwasserabgang)
- Muttermunderöffnung 0 bis 10 cm
- Presswehen in der Austreibungsphase

DIAGNOSTIK

- CTG (Wehentätigkeit + kindliche Herztöne)
- Vaginale Untersuchung (Muttermundweite, Höhenstand)
- Leopold-Handgriffe (Lage des Kindes)
- Vitalzeichen und Temperatur der Mutter
- Fruchtwasser beurteilen (klar/grün = Mekonium)

THERAPIE

- Geburtsbegleitung durch Hebamme/Arzt
- Wehenmanagement und Positionswechsel
- Schmerzlinderung (Atmung, Bewegung, ggf. PDA)
- Dammschutz in der Austreibungsphase
- Abnabeln und frühes Bonding (Haut-zu-Haut)

Pflegeproblem	Schmerz und Erschöpfung unter der Geburt r/t Wehentätigkeit m/d/s Schmerzäußerung, Anspannung, Unruhe
Ressourcen	Gebärende ist motiviert, Begleitperson anwesend, Hebamme betreut kontinuierlich
Pflegeziel	Die Gebärende bewältigt die Geburt möglichst schmerzarm, sicher und selbstbestimmt
Maßnahmen	• Atem- und Entspannungstechniken anleiten • Positionswechsel und Bewegung ermöglichen • Kontinuierliche CTG- und Vitalzeichenüberwachung • Emotionale Begleitung und Information • Blasenentleerung fördern
Evaluation	Geburt komplikationslos, Gebärende fühlt sich sicher begleitet, Kind wohlauf.

KONTROLLFRAGEN

40 **In welcher Reihenfolge verlaufen die Geburtsphasen?**

A) Austreibung – Eröffnung – Nachgeburt
B) Eröffnungsphase – Austreibungsphase – Nachgeburtsphase
C) Nachgeburt – Eröffnung – Austreibung
D) Es gibt nur eine Phase

41 **Welches sind sichere Zeichen des Geburtsbeginns?**

A) Nur Rückenschmerzen
B) Regelmäßige, zunehmende Wehen, Blasensprung und Zeichnen
C) Übelkeit
D) Sodbrennen

42 **Warum wird unter der Geburt ein CTG geschrieben?**

A) Nur zur Dokumentation
B) Um Wehentätigkeit und kindliche Herztöne zu überwachen und eine Sauerstoffunterversorgung früh zu erkennen
C) Um den Blutdruck zu messen
D) Um das Gewicht zu bestimmen

Sectio caesarea (Kaiserschnitt) O82

Operative Entbindung durch Bauchschnitt. Primäre Sectio = geplant, sekundäre/Not-Sectio = während der Geburt bei akuter Gefahr. Häufigste geburtshilfliche Operation.

SYMPTOME

- Indikation z. B. Querlage oder Missverhältnis
- Pathologisches CTG (fetale Hypoxie)
- Placenta praevia
- Schwere Präeklampsie/HELLP
- Geburtsstillstand

DIAGNOSTIK

- CTG und Vitalzeichen
- Labor (Blutbild, Gerinnung, Blutgruppe/Kreuzblut)
- OP-Vorbereitung und Aufklärung
- Sonographie (Lage, Plazentasitz)

THERAPIE

- Sectio in Spinal-/Periduralanästhesie oder Vollnarkose
- Postoperative Überwachung
- Schmerztherapie nach Stufenschema
- Thromboseprophylaxe (erhöhtes Risiko)

Pflegeproblem	Postoperative Schmerzen und Thrombosegefahr r/t abdominaler Operation und eingeschränkter Mobilität m/d/s Wundschmerz, Bewegungseinschränkung
Ressourcen	Mutter motiviert zu Mobilisation, Analgesie angeordnet, Unterstützung durch Personal/Familie
Pflegeziel	Die Wöchnerin ist ausreichend schmerzarm, wird frühzeitig mobilisiert und entwickelt keine Thrombose
Maßnahmen	• Schmerztherapie nach Plan und vor Mobilisation/Stillen • Thromboseprophylaxe: LMWH, Kompressionsstrümpfe, frühe Mobilisation • Wunde und Verband regelmäßig kontrollieren • Fundusstand und Lochien überwachen • Beim Stillen und Bonding aktiv unterstützen
Evaluation	Schmerzarm, frühzeitig mobilisiert, keine Thrombose-/Wundkomplikation, Stillbeginn gelungen.

KONTROLLFRAGEN

43 **Was ist eine typische Indikation für eine Not-Sectio?**

(A) Wunsch nach schneller Geburt

(B) Akute Gefährdung des Kindes, z. B. pathologisches CTG mit drohender Hypoxie

(C) Leichte Wehen

(D) Erschöpfung der Mutter allein

44 **Worauf ist nach einer Sectio pflegerisch besonders zu achten?**

(A) Nur auf die Wunde

(B) Konsequente Thromboseprophylaxe – das Thromboserisiko ist nach OP und in Wochenbett deutlich erhöht

(C) Bettruhe für 2 Wochen

(D) Kein Stillen

45 **Ist Stillen nach einem Kaiserschnitt möglich?**

(A) Nein, grundsätzlich nicht

(B) Ja – es ist möglich, oft aber anfangs erschwert und braucht aktive Unterstützung

(C) Nur mit Medikamenten

(D) Nur nach 6 Wochen

Neugeborenenversorgung (Erstversorgung, APGAR) Z38

Erstversorgung und Überwachung des Neugeborenen nach der Geburt: postnatale Adaptation, Wärmeerhalt, APGAR-Beurteilung, Prophylaxen sowie U1/U2 und Neugeborenen-Screening.

SYMPTOME

- Postnatale Adaptation (erster Atemzug, Kreislaufumstellung)
- APGAR bei 1/5/10 Minuten
- Physiologische Neugeborenengelbsucht möglich
- Wärmeempfindlichkeit (Hypothermiegefahr)

DIAGNOSTIK

- APGAR-Score (Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen, Reflexe) bei 1/5/10 min
- U1 direkt nach Geburt, U2 am 3.–10. Lebenstag
- Neugeborenen-Screening (Fersenblut)
- Pulsoxymetrie-Screening
- Gewicht, Länge, Kopfumfang

THERAPIE

- Wärmeerhalt (Haut-zu-Haut, Wärmelampe, Mütze)
- Abtrocknen, ggf. Absaugen
- Vitamin-K-Prophylaxe
- Augenprophylaxe nach Bedarf
- Frühes Anlegen und Bonding

Pflegeproblem	Gefahr der Hypothermie und gestörten Adaptation r/t unreifer Thermoregulation m/d/s großer Körperoberfläche und Nässe nach Geburt
Ressourcen	Mutter für Haut-zu-Haut bereit, Wärmelampe/Erstversorgungsplatz vorhanden
Pflegeziel	Das Neugeborene hält eine stabile Körpertemperatur und adaptiert komplikationslos
Maßnahmen	• Sofort abtrocknen und Wärme erhalten (Haut-zu-Haut, Wärmelampe, Mütze) • APGAR und Vitalzeichen erheben • Atmung, Hautfarbe und Temperatur überwachen • Bonding und erstes Anlegen fördern • Prophylaxen und Screening durchführen
Evaluation	Temperatur stabil, Adaptation regelrecht, APGAR gut, Bonding gelungen.

KONTROLLFRAGEN

46 **Wofür stehen die Buchstaben im APGAR-Score?**

A) Alter, Puls, Gewicht, Atmung, Reflexe

B) Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen (Hautfarbe), Reflexe

C) Aussehen, Puls, Größe, Atmung, Reaktion

D) Atmung, Position, Gewicht, Alter, Reflexe

47 **Warum ist der Wärmeerhalt beim Neugeborenen so wichtig?**

A) Aus Komfortgründen

B) Neugeborene kühlen wegen großer Körperoberfläche und unreifer Thermoregulation schnell aus (Hypothermiegefahr)

C) Damit sie schlafen

D) Nur bei Frühgeborenen relevant

48 **Wann wird die U1 durchgeführt?**

A) Am 10. Lebenstag

B) Direkt nach der Geburt

C) Nach 6 Wochen

D) Erst bei Auffälligkeiten

Stillen und Laktation Z39.1

Ernährung des Säuglings mit Muttermilch. Die Laktation wird durch Prolaktin (Milchbildung) und Oxytocin (Milchflussreflex) gesteuert. Milchreifung von Kolostrum über Übergangs- zu reifer Milch.

SYMPTOME

- Milcheinschuss um den 2.–4. Tag
- Let-down-Reflex (Milchspendereflex)
- Mögliche wunde Mamillen
- Möglicher Milchstau
- Mögliche Mastitis (Brustentzündung)

DIAGNOSTIK

- Anlege- und Stillposition beurteilen
- Trinkverhalten und Gewichtsverlauf des Kindes
- Brust auf Rötung/Stau/Überwärmung prüfen
- Ausscheidung des Kindes (nasse Windeln)

THERAPIE

- Korrekte Anlegetechnik anleiten
- Häufiges Anlegen nach Bedarf
- Verschiedene Stillpositionen zeigen
- Milchstau: entleeren, wärmen vor/kühlen nach dem Stillen
- Mastitis: weiterstillen/entleeren, ggf. Antibiose

Pflegeproblem	Stillschwierigkeiten und wunde Mamillen r/t fehlerhafter Anlegetechnik m/d/s Schmerz beim Anlegen, Unsicherheit der Mutter
Ressourcen	Mutter motiviert zu stillen, Stillberatung verfügbar, Kind trinkt grundsätzlich
Pflegeziel	Die Mutter legt schmerzfrei korrekt an und stillt sicher und selbstständig
Maßnahmen	• Anlegetechnik anleiten (Kind erfasst Warzenhof, nicht nur Mamille) • Verschiedene Stillpositionen zeigen • Mamillenpflege beraten • Zu häufigem Anlegen ermutigen • Milchstau/Mastitis vorbeugen und Zeichen erklären
Evaluation	Anlegen schmerzfrei, Mamillen intakt, Mutter stillt sicher, Kind nimmt zu.

KONTROLLFRAGEN

49 **Welche Hormone steuern die Laktation?**

A) Insulin und Adrenalin
B) Prolaktin (Milchbildung) und Oxytocin (Milchflussreflex)
C) Östrogen und Testosteron
D) Cortisol und Thyroxin

50 **Wie geht man bei einer beginnenden Mastitis in der Regel vor?**

A) Sofort abstillen
B) In der Regel weiterstillen/entleeren, kühlen und schonen – bei Bedarf Antibiose
C) Nur kühlen und nicht mehr anlegen
D) Nichts tun

51 **Was ist ein Zeichen für eine korrekte Anlegetechnik?**

A) Das Kind erfasst nur die Brustwarze
B) Das Kind erfasst Mamille und großen Teil des Warzenhofs, Lippen sind nach außen gestülpt
C) Die Mutter hat starke Schmerzen
D) Das Kind saugt nur kurz an

Gestationsdiabetes (GDM) O24.4

Erstmals in der Schwangerschaft auftretende Glukosetoleranzstörung. Häufigste Schwangerschaftskomplikation. Risiken: kindliche Makrosomie, Geburtskomplikationen, neonatale Hypoglykämie, späteres Diabetesrisiko der Mutter.

SYMPTOME

- Meist symptomarm – Screening entscheidend
- Mögliche Makrosomie (großes Kind)
- Mögliches Polyhydramnion (viel Fruchtwasser)
- Nach Geburt: Hypoglykämiegefahr des Kindes

DIAGNOSTIK

- Oraler Glukosetoleranztest (oGTT) in der 24.–28. SSW
- Blutzucker-Tagesprofil
- HbA1c ergänzend
- Sonographie (kindliches Wachstum, Fruchtwassermenge)

THERAPIE

- Basis: Ernährungsumstellung und Bewegung
- Blutzucker-Selbstkontrolle
- Bei unzureichender Einstellung: Insulin (keine oralen Antidiabetika in der Schwangerschaft)
- Engmaschige Betreuung

Pflegeproblem	Erhöhtes Blutzuckerniveau r/t Gestationsdiabetes m/d/s pathologischem oGTT
Ressourcen	Schwangere motiviert, Ernährungsberatung verfügbar, BZ-Messgerät vorhanden
Pflegeziel	Die Blutzuckerwerte liegen im Zielbereich, die Schwangerschaft verläuft komplikationslos
Maßnahmen	• Blutzucker-Selbstmessung anleiten und dokumentieren lassen • Ernährungsumstellung und Bewegung unterstützen • Ggf. Insulingabe schulen und überwachen • Auf Zielwerte und Warnzeichen achten • Nach Geburt: Neugeborenes auf Hypoglykämie kontrollieren
Evaluation	BZ-Werte im Zielbereich, keine Komplikationen, Kind ohne Hypoglykämie.

KONTROLLFRAGEN

52 **Wann wird das Screening auf Gestationsdiabetes (oGTT) durchgeführt?**

- A) In der 6. SSW
- B) In der 24. bis 28. SSW
- C) Erst nach der Geburt
- D) Im ersten Trimenon immer

53 **Welche medikamentöse Therapie ist bei GDM zulässig, wenn Ernährung nicht ausreicht?**

- A) Orale Antidiabetika (Tabletten)
- B) Insulin – orale Antidiabetika sind in der Schwangerschaft nicht Mittel der Wahl
- C) Gar keine
- D) Cortison

54 **Worauf muss das Neugeborene einer Mutter mit GDM nach der Geburt überwacht werden?**

- A) Auf Fieber
- B) Auf Hypoglykämie (Unterzucker)
- C) Auf Bluthochdruck
- D) Auf Übergewicht sofort

HELLP-Syndrom O14.2

Schwere Verlaufsform der Präeklampsie. HELLP steht für Hemolysis (Hämolyse), Elevated Liver enzymes (erhöhte Leberwerte) und Low Platelets (Thrombozytopenie). Lebensbedrohlich für Mutter und Kind.

SYMPTOME

- Rechtsseitiger Oberbauchschmerz (Leberkapselspannung)
- Übelkeit und Erbrechen
- Kopfschmerzen, Sehstörungen
- Hypertonie und Ödeme
- Gefahr von Eklampsie, Leberruptur, Gerinnungsstörung (DIC)

DIAGNOSTIK

- Labor: Hämolysezeichen (LDH erhöht), Transaminasen erhöht, Thrombozyten erniedrigt
- Blutdruckmessung
- Proteinurie (Urin)
- Gerinnungsstatus
- CTG (kindliches Befinden)

THERAPIE

- Einzige kausale Therapie: Entbindung
- Blutdrucksenkung
- Magnesium zur Krampfprophylaxe
- Kortison zur Lungenreife des Kindes
- Intensivüberwachung

Pflegeproblem	Lebensbedrohliche Komplikationsgefahr (Eklampsie, Leberruptur) r/t HELLP-Syndrom m/d/s Oberbauchschmerz, Hypertonie, pathologischem Labor
Ressourcen	Klinik/Personal vorbereitet, Intensiv-/OP-Bereitschaft vorhanden
Pflegeziel	Komplikationen werden früh erkannt, Mutter und Kind bleiben stabil bis zur Entbindung
Maßnahmen	• Engmaschige Überwachung von RR, Neurologie, Reflexen und Oberbauchschmerz • Reizarme Umgebung zur Eklampsie-Prophylaxe • Magnesiumtherapie überwachen (Reflexe, Atemfrequenz, Urinausscheidung) • Ein-/Ausfuhr bilanzieren, Labor kontrollieren • Notfall- und OP-Bereitschaft sicherstellen
Evaluation	Keine Eklampsie/Blutung, Werte stabilisiert, rechtzeitige Entbindung.

KONTROLLFRAGEN

55 **Wofür steht die Abkürzung HELLP?**

(A) High Energy Low Level Pressure

(B) Hämolyse, erhöhte Leberwerte (Elevated Liver enzymes), erniedrigte Thrombozyten (Low Platelets)

(C) Herz-, Leber- und Lungen-Problem

(D) Hypertonie, Ejektion, Laktat, Leukozyten, Puls

56 **Welches ist ein typisches Leitsymptom des HELLP-Syndroms?**

(A) Schmerzen im linken Bein

(B) Rechtsseitiger Oberbauchschmerz (Leberkapselspannung)

(C) Halsschmerzen

(D) Ohrenschmerzen

57 **Was ist die einzige kausale Therapie des HELLP-Syndroms?**

(A) Bettruhe

(B) Die Entbindung

(C) Antibiotika

(D) Abwarten bis zum Termin

Frühgeburt / vorzeitige Wehen O60

Geburt vor abgeschlossener 37. Schwangerschaftswoche (37+0 SSW). Vorzeitige Wehen sind muttermundwirksame Wehen vor diesem Zeitpunkt. Häufigste Ursache perinataler Morbidität und Mortalität.

SYMPTOME

- Vorzeitige, regelmäßige Wehen
- Vorzeitiger Blasensprung
- Muttermundverkürzung und -eröffnung
- Ggf. vaginale Blutung
- Druckgefühl nach unten

DIAGNOSTIK

- CTG (Wehentätigkeit)
- Vaginale Untersuchung und Zervixlängenmessung (Sonographie)
- Fibronektin-Test
- Infektionsparameter (Labor, Abstrich)
- Fruchtwasser-/Blasensprungnachweis

THERAPIE

- Tokolyse (Wehenhemmung, z. B. Atosiban/Fenoterol)
- Lungenreifeinduktion mit Kortison (Betamethason)
- Magnesium zur Neuroprotektion des Kindes
- Antibiotika bei Infektion
- Verlegung in ein Perinatalzentrum

Pflegeproblem	Gefahr der Frühgeburt r/t vorzeitiger Wehentätigkeit m/d/s regelmäßiger Wehen, Zervixverkürzung
Ressourcen	Schwangere kooperativ, Tokolyse verfügbar, Perinatalzentrum erreichbar
Pflegeziel	Die Schwangerschaft wird möglichst prolongiert, die Lungenreife des Kindes abgeschlossen
Maßnahmen	• CTG- und Wehenüberwachung • Tokolyse nach Anordnung, Nebenwirkungen kontrollieren • Lungenreifegabe sicherstellen • Körperliche Schonung ermöglichen, Infektzeichen beobachten • Psychische Begleitung, Verlegung/Frühgeborenenversorgung vorbereiten
Evaluation	Wehen sistieren/reduziert, Lungenreife abgeschlossen, Kind bestmöglich versorgt.

KONTROLLFRAGEN

58 **Ab wann spricht man von einer Frühgeburt?**

A) Geburt vor der 40. SSW
B) Geburt vor abgeschlossener 37. SSW (vor 37+0)
C) Geburt nach der 42. SSW
D) Jede Geburt per Sectio

59 **Warum wird bei drohender Frühgeburt Kortison gegeben?**

A) Zur Wehenhemmung
B) Zur Lungenreifeinduktion des Kindes (Surfactant-Bildung)
C) Gegen Schmerzen
D) Zur Blutdrucksenkung

60 **Was ist das Ziel einer Tokolyse?**

A) Die Wehen zu verstärken
B) Die Wehentätigkeit zu hemmen und die Geburt hinauszuzögern
C) Den Blutdruck zu senken
D) Die Geburt einzuleiten

Urologie

10 Krankheitsbilder

Harnwegsinfekt (HWI) N39.0

Häufigste bakterielle Infektion. Unkompliziert: Zystitis (Blase). Kompliziert: Pyelonephritis (Niere), katheterassoziiert (CAUTI). Häufigster Erreger: E. coli (80%). Frauen 10× häufiger betroffen.

SYMPTOME

- Dysurie (Brennen beim Wasserlassen)
- Pollakisurie (häufiger Harndrang)
- Hämaturie
- Übelriechender/trüber Urin
- Unterbauchschmerzen/-druck
- Bei Pyelonephritis: Fieber, Flanken-/Klopfschmerz
- Verwirrtheit (bei alten Menschen oft einziges Zeichen!)

DIAGNOSTIK

- Urinstreifentest (Nitrit, Leukozyten)
- Urinstatus + Kultur (Mittelstrahlurin!)
- Blutbild, CRP
- Sonographie Nieren bei Pyelonephritis
- Blutkultur bei Sepsisverdacht

THERAPIE

- Unkompliziert: Nitrofurantoin, Fosfomycin, Trimethoprim
- Pyelonephritis: Fluorochinolone, Cephalosporine i.v.
- Katheter-HWI: Antibiose + Katheterwechsel
- Viel trinken (2-3L/Tag)
- Wärme (Wärmflasche Unterbauch)

Pflegeproblem	Risiko katheterassoziierter Harnwegsinfektion r/t liegendem DK m/d/s Immunsuppression
Ressourcen	Kooperativer Patient, Pflegepersonal geschult
Pflegeziel	Patient entwickelt keine Katheterinfektion (kein Fieber, kein Urin-Befund) über Liegedauer
Maßnahmen	• Tägliche Indikationsprüfung: DK wirklich nötig? → frühzeitig entfernen! • Sterile Anlage, geschlossenes System immer erhalten • Intimhygiene 2x täglich mit Wasser (kein Desinfektionsmittel!) • Beutel immer unter Blasenniveau, niemals auf Boden • Kein Abklemmen des Katheters • Auf Katheterstau/Knick achten • Flüssigkeitszufuhr 1,5-2L/Tag sichern • Täglich: Urin beurteilen (Trübung, Geruch, Farbe)
Evaluation	Täglich Urinbeschaffenheit, Temperatur, Befinden

KONTROLLFRAGEN

61 **Wie nimmt man einen Mittelstrahl-Urin korrekt ab?**

(A) Einfach laufen lassen

(B) Ersten Harnstrahl verwerfen, Mittelstrahl in steriles Gefäß auffangen, letzten Strahl verwerfen

(C) Katheter nötig

(D) Alles auffangen

62 **Warum ist die tägliche Indikationsprüfung des Dauerkatheters so wichtig?**

(A) Nur zur Dokumentation

(B) Jeder Kathetertag erhöht CAUTI-Risiko um 3-7% – frühzeitiger Entfernung = wichtigste Prophylaxe!

(C) Wegen Kosten

(D) Nur bei Frauen

63 **Welches Zeichen eines HWI ist bei alten Menschen oft das einzige Symptom?**

A Brennen beim Wasserlassen

B Verwirrtheit/Delir – klassische Symptome können fehlen!

C Fieber

D Hämaturie

Benignes Prostataadenom (BPH) N40

Gutartige Vergrößerung der Prostata. Betrifft 50% der Männer >50J, 90% der >80-Jährigen. Führt zu Blasenausflussobstruktion mit LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). Kein Krebsrisiko per se.

SYMPTOME

- Abschwächung des Harnstrahls
- Harnstottern (intermittierender Strahl)
- Restharngefühl
- Nykturie (nächtliches Wasserlassen)
- Pollakisurie
- Harndrang
- Harnverhalt (akut)

DIAGNOSTIK

- IPSS-Score (International Prostate Symptom Score)
- PSA-Wert
- Sonographie (Prostatavolumen, Restharn)
- Urodynamik
- Uroflowmetrie
- Rektale Untersuchung

THERAPIE

- Medikamentös: Alpha-1-Blocker (Tamsulosin), 5-Alpha-Reduktasehemmer
- Operative Entfernung: TURP (transurethrale Resektion)
- Laser-Verfahren
- Notfall Harnverhalt: transurethraler Katheter

Pflegeproblem	Akuter Harnverhalt r/t BPH m/d/s Restharn 600ml, starker Harndrang, Unterbauchschmerzen
Ressourcen	Kooperativer Patient, Schmerzmittel vorhanden
Pflegeziel	Blasenentlastung durch Katheteranlage innerhalb 30 Min., Schmerzfreiheit
Maßnahmen	• Transurethralen Katheter nach ärztl. Anordnung anlegen (aseptisch!) • Urin langsam ablassen: nicht mehr als 500ml auf einmal (Hypotension, Hämaturie vermeiden) • Urinmenge, -farbe, -geruch dokumentieren • Schmerzerfassung (NRS) vor und nach Katheteranlage • Wärme auf Unterbauch (prä-/periinterventionell) • Aufklärung über TURP wenn geplant • Sturzprophylaxe: Drang → Stürze bei Eile
Evaluation	Restharnkontrolle nach Miktion (Sonographie), Schmerz-NRS

KONTROLLFRAGEN

64 **Was ist TURP?**

A Eine Medikamentengruppe

B Transurethrale Resektion der Prostata: endoskopische Abtragung des Prostatagewebes über die Harnröhre

C Eine Prostata-Biopsie

D Ein Bluttest

65 **Warum darf man bei akutem Harnverhalt nicht sofort die gesamte Urinmenge ablassen?**

A Kein Grund

B Dekompressionsbedingte Hämaturie und Blutdruckabfall (Dekompressionsschock) möglich – max. 500ml auf einmal!

C Wegen Infektionsrisiko

D Nur bei Frauen relevant

66 **Was ist der IPSS?**

A Ein Bluttest

B International Prostate Symptom Score: Fragebogen zur Einschätzung des Schweregrades der Miktionsbeschwerden

C Ein Ultraschallwert

D Ein Krebsmarker

Urolithiasis / Nierenkolik (Harnsteine) N20

Steine in Niere/Harnleiter, die bei Abgang heftige kolikartige Schmerzen verursachen können. Gefahr von Harnstau und Infektion.

SYMPTOME

- Heftige, kolikartige Flankenschmerzen
- Ausstrahlung in Unterbauch/Leiste
- Übelkeit/Erbrechen
- Hämaturie (Blut im Urin)
- Harndrang, Unruhe
- Bei Infekt/Stau: Fieber

DIAGNOSTIK

- Klinik (Kolik), Urinstatus (Hämaturie)
- Sonografie/CT
- Labor (Entzündung, Nierenwerte)
- Vitalzeichen
- Auf Harnstau/Infekt achten

THERAPIE

- Analgesie/Spasmolyse nach AO
- Ausreichend Flüssigkeit, Bewegung
- Steinabgang fördern; ggf. Steinzertrümmerung (ESWL)/ endoskopische Entfernung
- Bei Harnstau/Infekt rasche Entlastung nach AO
- Metaphylaxe/Beratung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Nierenkolik m/d/s heftigem Flankenschmerz, Übelkeit
Ressourcen	Patient kooperativ, Behandlung verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist rasch schmerzgelindert (NRS ≤ 3); Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Analgesie/Spasmolyse nach AO, Wirkung kontrollieren • Flüssigkeit fördern, Urin beobachten/sieben, Bilanz • Auf Fieber/Harnstau achten • Bewegung unterstützen • Edukation zu Trinkmenge/Steinprophylaxe
Evaluation	Schmerz gelindert, kein Harnstau/Infekt, Steinabgang/Behandlung erfolgt.

Prostatakarzinom C61

Häufigster bösartiger Tumor des Mannes, oft langsam wachsend. Früh meist symptomlos; Vorsorge und individuelle Therapieentscheidung sind zentral.

SYMPTOME

- Frühstadium meist symptomlos
- Miktionsbeschwerden (spät)
- Hämaturie/Hämatospermie (selten)
- Bei Metastasen: Knochenschmerzen
- Leistungsminderung

DIAGNOSTIK

- Tastuntersuchung (DRU), PSA-Wert nach AO
- Biopsie (Sicherung)
- Bildgebung/Staging
- Verlaufskontrolle

THERAPIE

- Aktive Überwachung bei Niedrigrisiko
- Operation (Prostatektomie) oder Strahlentherapie
- Hormon-/Systemtherapie nach AO
- Symptom-/Schmerzkontrolle
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Belastung und mögliche Inkontinenz r/t Prostatakarzinom/Therapie m/d/s Miktionsbeschwerden, Sorge
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige/Psychoonkologie
Pflegeziel	Der Patient ist symptomkontrolliert und in Bewältigung/Kontinenz unterstützt
Maßnahmen	• Perioperative/onkologische Pflege • Kontinenz-/Beckenbodentraining, Katheterpflege • Therapienebenwirkungen nach AO managen • Schmerz-/Symptomkontrolle • Psychische Unterstützung, Edukation
Evaluation	Symptome kontrolliert, Kontinenz verbessert, Patient unterstützt.

Harninkontinenz N39.3

Unwillkürlicher Harnverlust verschiedener Formen (z. B. Belastungs-, Drang-, Misch-, Überlaufinkontinenz). Häufig, mit hoher Belastung der Lebensqualität.

SYMPTOME

- Unwillkürlicher Urinverlust (bei Belastung/Drang)
- Häufiger/imperativer Harndrang
- Nächtliches Wasserlassen
- Hautprobleme im Intimbereich
- Sozialer Rückzug/Scham

DIAGNOSTIK

- Miktions-/Inkontinenztagebuch
- Anamnese (Form/Auslöser)
- Restharnbestimmung
- Urinstatus (Infekt ausschließen)
- Ärztliche Abklärung

THERAPIE

- Form-spezifisch: Beckenbodentraining, Blasentraining
- Medikamente nach AO
- Hilfsmittelversorgung
- Operative Optionen bei Bedarf
- Gewichts-/Lebensstilberatung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Ausscheidung und Hautgefahr r/t Harninkontinenz m/d/s unwillkürlichem Urinverlust
Ressourcen	Patient/in motiviert, Hilfsmittel verfügbar
Pflegeziel	Die Kontinenzsituation verbessert sich; die Haut bleibt intakt und die Würde gewahrt
Maßnahmen	• Form/Auslöser erfassen, Toilettentraining/-rhythmus • Beckenboden-/Blasentraining anleiten • Hautschutz, geeignete Hilfsmittel • Intimsphäre/Würde wahren • Edukation, Flüssigkeits-/Toilettenmanagement
Evaluation	Weniger Urinverlust, Haut intakt, Lebensqualität verbessert.

Harnblasenkarzinom C67

Bösartiger Tumor der Harnblase, Risikofaktor v. a. Rauchen. Leitsymptom ist oft die schmerzlose Hämaturie.

SYMPTOME

- Schmerzlose Hämaturie (Blut im Urin)
- Häufiger Harndrang
- Schmerzen/Brennen beim Wasserlassen (später)
- Bei Fortschreiten: Beschwerden/ Stau
- Leistungsminderung

DIAGNOSTIK

- Urinstatus/-zytologie
- Zystoskopie (Sicherung)
- Bildgebung/Staging
- Labor
- Verlaufskontrolle

THERAPIE

- Transurethrale Resektion (TUR-B)
- Lokale Instillationstherapie nach AO
- Bei Fortschreiten: radikale Therapie/Zystektomie (ggf. Harnableitung)
- Chemo-/Systemtherapie nach AO
- Nachsorge

Pflegeproblem	Belastung und Ausscheidungsveränderung r/t Blasenkarzinom/Therapie m/d/s Hämaturie, ggf. Harnableitung
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige/Stomatherapie
Pflegeziel	Der Patient ist symptomkontrolliert und versorgt seine Ausscheidung/Harnableitung zunehmend selbstständig
Maßnahmen	• Perioperative/onkologische Pflege, Spülung/Katheter nach AO • Urin/Hämaturie beobachten, Bilanz • Bei Harnableitung Versorgung/Anleitung, Hautschutz • Therapienebenwirkungen nach AO managen • Psychische Unterstützung, Edukation (Rauchstopp)
Evaluation	Symptome kontrolliert, Versorgung sicher, zunehmende Selbstständigkeit.

Akuter Harnverhalt R33

Plötzliche Unfähigkeit, die volle Blase zu entleeren – ein schmerzhafter Notfall, häufig bei BPH, postoperativ oder medikamentös bedingt.

SYMPTOME

- Starker Harndrang ohne Entleerung
- Schmerzen/Druck im Unterbauch
- Tastbare, prall gefüllte Blase
- Unruhe
- Überlaufinkontinenz (tröpfelnd) möglich

DIAGNOSTIK

- Klinik (prall gefüllte Blase)
- Sonografie/Restharnbestimmung
- Ursachensuche (BPH, Medikamente, postoperativ)
- Vitalzeichen

THERAPIE

- Sofortige Entlastung durch Katheterisierung nach AO (langsam ablassen)
- Ursache behandeln (z. B. BPH, Medikamente)
- Schmerztherapie
- Bilanz/Beobachtung nach Entlastung
- Beratung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Harnverhalt r/t Blasenentleerungsstörung m/d/s prall gefüllter Blase, Unterbauchschmerz
Ressourcen	Stationäre Versorgung, Patient kooperativ
Pflegeziel	Die Blase wird sicher entlastet; der Patient ist schmerzfrei und kreislaufstabil
Maßnahmen	• Katheterisierung nach AO, Urin langsam ablassen, Menge dokumentieren • Schmerz-/Vitalzeichenüberwachung • Nach Entlastung Bilanz und Kreislauf beobachten • Katheterpflege/Hygiene • Ursache klären, Edukation
Evaluation	Blase entlastet, schmerzfrei, kreislaufstabil.

Pyelonephritis (Nierenbeckenentzündung) N10

Bakterielle Entzündung von Nierenbecken und Nierengewebe, meist aufsteigend. Fieberhafte, ernste Form des Harnwegsinfekts.

SYMPTOME

- Hohes Fieber, Schüttelfrost
- Flankenschmerz/Klopfschmerz der Nierenlager
- Dysurie/Pollakisurie
- Übelkeit/Erbrechen
- Allgemeines Krankheitsgefühl

DIAGNOSTIK

- Urinstatus/-kultur
- Labor (Entzündungswerte)
- Sonografie (Stau/Abszess)
- Vitalzeichen
- Auf Komplikationen (Urosepsis) achten

THERAPIE

- Antibiotika nach AO
- Ausreichend Flüssigkeit
- Antipyrese/Analgesie nach AO
- Bei Harnstau Entlastung nach AO
- Stationär bei schwerem Verlauf

Pflegeproblem	Erhöhte Körpertemperatur und Infektion r/t Pyelonephritis m/d/s Fieber, Flankenschmerz
Ressourcen	Patient kooperativ, Frühzeitige Behandlung
Pflegeziel	Der Patient ist innerhalb weniger Tage fieberfrei und schmerzgelindert; eine Urosepsis wird früh erkannt
Maßnahmen	• Temperatur-/Vitalzeichen-/Schmerzüberwachung • Antibiotika zeitgerecht nach AO • Flüssigkeit fördern, Bilanz, Urin beobachten • Auf Urosepsiszeichen achten • Edukation zu Therapietreue/Prävention
Evaluation	Fieber rückläufig, schmerzgelindert, keine Urosepsis.

Hodentorsion N44

Verdrehung des Hodens mit Unterbrechung der Durchblutung – ein urologischer Notfall. Ohne rasche Behandlung droht der Verlust des Hodens.

SYMPTOME

- Plötzlicher, heftiger Hodenschmerz
- Schwellung/Rötung des Hodens
- Übelkeit/Erbrechen
- Hochstand/Querlage des Hodens
- Schmerz oft ohne Linderung bei Anheben

DIAGNOSTIK

- Klinik (akuter Hodenschmerz)
- Dopplersonografie (Durchblutung)
- Rasche urologische Abklärung
- Vitalzeichen
- Zeit ist entscheidend!

THERAPIE

- Sofortige operative Freilegung/ Detorsion (Notfall!)
- Schmerztherapie nach AO
- Nüchtern, OP-Vorbereitung
- Rasche Klinik-/Facharztvorstellung
- Beobachtung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Organgefahr r/t Hodentorsion m/d/s heftigem Hodenschmerz, Durchblutungsstörung
Ressourcen	Rasche Versorgung möglich, Patient kooperativ
Pflegeziel	Die Durchblutung wird rasch wiederhergestellt; der Patient ist schmerzgelindert
Maßnahmen	• Als Notfall behandeln: sofortige OP-Vorbereitung, nüchtern • Schmerzmanagement nach AO, Vitalzeichen • Patienten beruhigen, Dringlichkeit kommunizieren • Postoperative Pflege • Psychische Unterstützung/Edukation
Evaluation	Rasch operiert, Hoden erhalten, schmerzgelindert.

Transurethraler Dauerkatheter (DK) – Pflege Z46.6

Liegender Blasenkatheter zur Harnableitung. Pflegerischer Schwerpunkt: Hygiene, Infektionsprävention (CAUTI) und sichere Handhabung; die Indikation ist regelmäßig zu prüfen.

SYMPTOME

- Liegender transurethraler Katheter mit Ableitungssystem
- Risiko: katheterassoziierter Harnwegsinfekt (CAUTI)
- Mögliche Probleme: Verstopfung, Leckage, Diskonnektion
- Blasenkrämpfe/Druckgefühl
- Hautreizung/Verletzung im Genitalbereich

DIAGNOSTIK

- Urin (Menge/Farbe/Beimengungen) beobachten, Bilanz
- Auf Infektzeichen achten (trüber/ riechender Urin, Fieber)
- Durchgängigkeit/Lage des Systems prüfen
- Indikation regelmäßig überprüfen

THERAPIE

- Aseptische Anlage und geschlossenes System
- Katheter nur so lange wie nötig (Indikation prüfen)
- Bei Infekt/Komplikation Behandlung nach AO
- Ausreichend Flüssigkeit
- Frühzeitige Entfernung anstreben

Pflegeproblem	Infektionsgefahr r/t liegendem Blasenkatheter m/d/s Fremdkörper in den Harnwegen, CAUTI-Risiko
Ressourcen	Patient kooperativ, Funktionierendes System
Pflegeziel	Der Patient entwickelt keinen katheterassoziierten Harnwegsinfekt; die Ableitung funktioniert sicher
Maßnahmen	• Geschlossenes System, Beutel unter Blasenniveau, kein Abknicken • Tägliche Katheter-/Meatuspflege, konsequente Händehygiene • Urin/Bilanz beobachten, auf Infektzeichen achten • Ausreichend Flüssigkeit fördern • Indikation täglich prüfen, frühe Entfernung anstreben
Evaluation	Kein CAUTI, Ableitung sicher, Katheter so kurz wie möglich.

Neurologie

10 Krankheitsbilder

Schlaganfall (Apoplex) I63 / I61

Plötzliche fokale Hirnschädigung durch Ischämie (85%, I63) oder Blutung (15%, I61). Time is Brain: jede Minute = 1,9 Mio. Neuronenverluste. Thrombolyse-Fenster: 4,5h (ischämisch).

SYMPTOME

- Plötzliche einseitige Lähmung (Hemiparese/-plegie)
- Gesichtslähmung (faziale Parese)
- Sprach-/Sprechstörung (Aphasie/ Dysarthrie)
- Schluckstörung (Dysphagie)
- Sehstörungen (Hemianopsie)
- Schwindel, Gangstörung
- Starke Kopfschmerzen (bei Blutung)
- Bewusstlosigkeit

DIAGNOSTIK

- FAST-Test (Prehospital)
- CT Schädel sofort (Blutung ausschließen!)
- MRT Schädel (diffusionsgewichtet)
- CT-/MR-Angiographie
- EKG (Vorhofflimmern?)
- Labor: Gerinnung, BZ

THERAPIE

- Stroke Unit!
- Ischämisch: Lyse rtPA i.v. (bis 4,5h) oder Thrombektomie (bis 24h)
- Blutung: neurochirurgisch ggf.
- Sekundärprophylaxe: ASS, Antikoagulation
- Frührehabilitation: Physio, Ergo, Logo ab Tag 1
- Dysphagie-Screening vor erstem Schluck!

Pflegeproblem	Risiko Aspiration r/t Schluckstörung (Dysphagie) nach Schlaganfall m/d/s positives Dysphagie-Screening
Ressourcen	Patient kooperiert trotz Aphasie, Logopädie verfügbar
Pflegeziel	Patient aspiriert nicht – sichere Nahrungsaufnahme durch angepasste Konsistenz nach logopädischer Freigabe
Maßnahmen	• Vor ERSTEM Schluck: standardisiertes Dysphagie-Screening (z.B. 3-Unzen-Wassertest) • Bis Screening-Ergebnis: NICHTS per oral, Mund feucht halten • Nach Logo-Freigabe: angepasste Kost (Andickungsmittel, weiche Kost) • Beim Essen: aufrechte Position 90°, betroffene Seite unterstützen • Essen nie überstürzen, genug Zeit lassen • Absauggerät bereithalten • Nach Essen 30 Min. aufrecht bleiben • Angehörige in sicheres Füttern schulen
Evaluation	Täglich Schluckfähigkeit beobachten, Aspirationszeichen (Husten, Stimmveränderung)

Pflegeproblem	Beeinträchtigte körperliche Mobilität r/t Hemiparese links m/d/s Patient kann linken Arm/Bein nicht heben
Ressourcen	Hohe Motivation, Vorhandenes Pflegebett mit Hilfsmitteln
Pflegeziel	Patient dreht sich mit geringer Hilfe auf betroffene Seite nach 3 Tagen Frührehabilitation
Maßnahmen	• Bobath-Lagerung: betroffene Seite einbeziehen, nicht kompensieren • Stundenlageplan: alle 2h Umlagerung • Patient von betroffener Seite ansprechen (Förderung Aufmerksamkeit zur Seite) • Frührehabilitation: Physiotherapie ab Tag 1 nach Anordnung • Transfertraining (Bett → Stuhl) mit PT • Hilfsmittel: Rollator, Handschiene nach Ergotherapie • Antispastik-Lagerung beachten (Armschiene)
Evaluation	Täglich Motorik, Tonus, Lagerungstoleranz

KONTROLLFRAGEN

67 **Was bedeutet FAST beim Schlaganfall?**

A) Ein Medikament

B) F=Face, A=Arms, S=Speech, T=Time – Schlaganfall-Schnelltest, sofort 112!

C) Ein Bildgebungsverfahren

D) Eine Lagerungstechnik

68 **Warum muss vor dem ersten Schluck ein Dysphagie-Screening erfolgen?**

A) Nur Routine

B) Stille Aspiration möglich: Patient schluckt und hustet nicht – Pneumonie- und Asphyxie-Risiko!

C) Nur bei Bewusstlosen

D) Nur bei Beatmeten

69 **Was ist das Bobath-Konzept bei der Schlaganfallpflege?**

A) Bettruhe

B) Betroffene Körperseite aktiv einbeziehen, nicht kompensieren – fördert Neuroplastizität und verhindert Vernachlässigung

C) Nur für Physiotherapeuten

D) Schmerztherapiekonzept

Epilepsie G40

Chronische Erkrankung mit rezidivierenden epileptischen Anfällen durch unkontrollierte synchrone Entladungen von Neuronenverbänden. Prävalenz: 0,5-1%. Fokal oder generalisiert. Status epilepticus: Anfall > 5 Min. = Notfall.

SYMPTOME

- Tonisch-klonischer Anfall (grand mal)
- Absence (kurze Bewusstseinsunterbrechung)
- Aura (subjektive Vorboten)
- Myoklonien
- Postiktale Phase: Verwirrtheit, Erschöpfung
- Status epilepticus: Anfall > 5 Min.

DIAGNOSTIK

- EEG (interiktal/iktal)
- MRT Schädel
- Labor: BZ, Elektrolyte, Antiepileptika-Spiegel
- Provokationsfaktoren erfragen

THERAPIE

- Antiepileptika: Valproat, Lamotrigin, Levetiracetam, Carbamazepin
- Status epilepticus: Lorazepam i.v. → Phenytoin → Narkose
- Anfallsauslöser vermeiden (Schlafentzug, Alkohol, Flackerlicht)
- Führerschein: 12 Monate anfallsfrei

Pflegeproblem	Risiko sturzbedingte Verletzung r/t unkontrollierten Krampfanfällen m/d/s Epilepsie, letzter Anfall vor 3 Tagen
Ressourcen	Versteht Sicherheitsmaßnahmen, Kooperativ
Pflegeziel	Patient verletzt sich bei möglichem Anfall nicht durch konsequente Sturzprophylaxe
Maßnahmen	• Bettgitter tagsüber nur nach Risiko-Assessment – nicht pauschal! • Scharfe Gegenstände aus Griffweite entfernen • Bett auf niedrigste Position • Bei Anfall: NIEMALS festhalten, Atemweg freihalten, Zeit stoppen • Kein Beißkeil! (Verletzungsgefahr, Aspiration) • Patienten NICHT alleine lassen während Anfall • Nach Anfall: stabile Seitenlage, Sauerstoff, Vitalzeichen • Anfall dokumentieren: Beginn, Dauer, Verlauf, postiktale Phase
Evaluation	Bei jedem Anfall: Dauer, Art, Verlauf dokumentieren

KONTROLLFRAGEN

70 **Was tut man NICHT bei einem epileptischen Anfall?**

A) Atemweg freihalten

B) Beißkeil einlegen und festhalten – beides falsch und gefährlich!

C) Zeit stoppen

D) Verletzungsschutz sichern

71 **Ab wann gilt ein epileptischer Anfall als Status epilepticus?**

A) Ab 1 Min.

B) Ab 5 Min. – medizinischer Notfall, sofortige Therapie!

C) Ab 30 Min.

D) Nur bei mehreren Anfällen

72 **Was bedeutet 'postiktale Phase'?**

A) Die Aura vor dem Anfall

B) Erschöpfungs-/Verwirrtheitszustand nach dem Anfall – kann Minuten bis Stunden dauern

C) Der Anfall selbst

D) Ein EEG-Befund

Morbus Parkinson G20

Chronisch-neurodegenerative Erkrankung mit Dopaminmangel. Leitsymptome: Rigor, Tremor, Brady-/Akinese, posturale Instabilität.

SYMPTOME

- Ruhetremor
- Rigor (Muskelsteifigkeit)
- Bradykinese/Akinese (verlangsamte Bewegung)
- Posturale Instabilität, kleinschrittiger Gang
- Maskengesicht, leise Sprache, Mikrografie

DIAGNOSTIK

- Klinische Diagnose (Kardinalsymptome)
- Anamnese, neurologische Untersuchung
- L-Dopa-Test
- Bildgebung zum Ausschluss
- Verlaufsbeurteilung

THERAPIE

- Medikamentös (L-Dopa, Dopaminagonisten) nach AO – pünktliche Gabe!
- Physio-/Ergo-/Logopädie
- Sturzprophylaxe, Hilfsmittel
- Ggf. tiefe Hirnstimulation
- Ernährung, Obstipationsprophylaxe

Pflegeproblem	Sturzgefahr und beeinträchtigte Mobilität r/t Parkinson m/d/s Rigor, Bradykinese, posturaler Instabilität
Ressourcen	Motiviert, Angehörige unterstützen, Physiotherapie verfügbar
Pflegeziel	Der Patient bleibt sturzfrei und so mobil/selbstständig wie möglich
Maßnahmen	• Medikamente exakt pünktlich nach AO, On-/Off-Phasen beobachten • Sturzprophylaxe, sichere Mobilisation, Hilfsmittel • Zeit lassen, Selbstständigkeit fördern • Schluckstörung/Aspiration beachten, Ernährung anpassen • Obstipations-/Dekubitusprophylaxe, Physiotherapie einbinden
Evaluation	Sturzfrei, Mobilität/Selbstständigkeit erhalten, Medikamentenwirkung stabil.

Multiple Sklerose G35

Chronisch-entzündliche, demyelinisierende Erkrankung des ZNS mit schubförmigem oder progredientem Verlauf und vielfältigen neurologischen Ausfällen.

SYMPTOME

- Sehstörungen (z. B. Optikusneuritis)
- Sensibilitätsstörungen, Missempfindungen
- Paresen, Spastik
- Gangunsicherheit, Koordinationsstörungen
- Fatigue, Blasenstörungen

DIAGNOSTIK

- MRT (Entzündungsherde)
- Liquordiagnostik
- Evozierte Potenziale
- Neurologische Untersuchung
- Verlauf (Schübe)

THERAPIE

- Schubtherapie (Kortison) nach AO
- Verlaufsmodifizierende Immuntherapie nach AO
- Symptomatische Therapie (Spastik, Blase, Fatigue)
- Physio-/Ergotherapie
- Rehabilitation

Pflegeproblem	Fatigue und beeinträchtigte Mobilität r/t Multipler Sklerose m/d/s Erschöpfung, Paresen/Spastik
Ressourcen	Patient kennt seine Erkrankung, Therapie läuft, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Der Patient teilt seine Energie ein und bleibt im Rahmen seiner Möglichkeiten mobil/selbstständig
Maßnahmen	• Fatigue-Management, Aktivitäten und Pausen planen • Mobilität/Spastik unterstützen (Lagerung, Hilfsmittel, Sturzprophylaxe) • Blasen-/Darmmanagement, Hautschutz • Schubtherapie nach AO begleiten • Ressourcen fördern, psychische Unterstützung
Evaluation	Energie besser eingeteilt, Mobilität erhalten, Komplikationen vermieden.

Migräne G43

Anfallsartige, oft einseitige Kopfschmerzen, häufig mit Übelkeit und Licht-/Lärmempfindlichkeit, teils mit Aura. Chronisch-rezidivierend.

SYMPTOME

- Pulsierender, oft einseitiger Kopfschmerz
- Übelkeit/Erbrechen
- Licht-/Lärm-/Geruchsempfindlichkeit
- Verstärkung bei Bewegung
- Ggf. Aura (z. B. Sehstörungen) vor dem Schmerz

DIAGNOSTIK

- Klinische Diagnose, Anamnese (Trigger, Verlauf)
- Kopfschmerztagebuch
- Ausschluss anderer Ursachen (Red Flags)
- Neurologische Untersuchung

THERAPIE

- Akut: Analgetika/Triptane nach AO, früh einnehmen
- Reizabschirmung, Ruhe
- Antiemetika nach AO
- Prophylaxe bei häufigen Attacken nach AO
- Triggervermeidung, Lebensstil

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Migräneattacke m/d/s pulsierendem Kopfschmerz, Übelkeit, Reizempfindlichkeit
Ressourcen	Patient kennt Auslöser, Medikamente verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist während der Attacke deutlich schmerzgelindert (NRS ≤ 3)
Maßnahmen	• Reizarme, abgedunkelte, ruhige Umgebung schaffen • Medikamente früh nach AO geben, Wirkung kontrollieren • Übelkeit/Erbrechen behandeln, Flüssigkeit anbieten • Kopfschmerztagebuch/Triggervermeidung unterstützen • Edukation zu früher Einnahme und Auslösern
Evaluation	Schmerz gelindert, Übelkeit kontrolliert, Trigger reflektiert.

Demenz (Alzheimer-Typ) G30

Fortschreitender Verlust kognitiver Fähigkeiten (v. a. Gedächtnis), häufigste Form ist Alzheimer. Beeinträchtigt Alltag und Selbstständigkeit zunehmend.

SYMPTOME

- Gedächtnisstörungen (v. a. Kurzzeitgedächtnis)
- Orientierungsstörungen (Zeit/Ort)
- Wortfindungs-/Sprachstörungen
- Beeinträchtigte Alltagskompetenz
- Verhaltensänderungen, Unruhe, Tag-Nacht-Umkehr

DIAGNOSTIK

- Kognitive Tests (z. B. MMST/ Uhrentest)
- Anamnese (Eigen-/ Fremdanamnese)
- Bildgebung, Labor (Ausschluss)
- Verlaufsbeurteilung

THERAPIE

- Antidementiva nach AO
- Nicht-medikamentöse Förderung (Aktivierung, Biografiearbeit)
- Strukturierter, sicherer Alltag
- Behandlung von Begleitsymptomen
- Angehörigenberatung/-entlastung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Orientierung und Selbstständigkeit r/t Demenz m/d/s Gedächtnis-/ Orientierungsstörungen, Unruhe
Ressourcen	Biografie bekannt, Angehörige unterstützen, Erhaltene Ressourcen
Pflegeziel	Der Mensch mit Demenz ist sicher, orientiert sich im Rahmen seiner Möglichkeiten und behält Selbstständigkeit/Würde
Maßnahmen	• Klare Tagesstruktur, Orientierungshilfen, vertraute Routinen • Validierender, ruhiger Umgang, einfache Kommunikation • Sicherheit gewährleisten (Sturz-/Hinlaufprophylaxe), reizarm • Ressourcen/Selbstständigkeit fördern, Biografiearbeit • Ernährung/Flüssigkeit sichern, Angehörige beraten/entlasten
Evaluation	Sicher, im Rahmen orientiert, Selbstständigkeit/Würde gewahrt.

Bakterielle Meningitis G00

Bakterielle Entzündung der Hirnhäute, ein lebensbedrohlicher Notfall. Schnelle Diagnose und Antibiotikatherapie sind entscheidend.

SYMPTOME

- Hohes Fieber
- Starke Kopfschmerzen
- Meningismus (Nackensteife)
- Licht-/Geräuschempfindlichkeit, Übelkeit
- Bewusstseinstrübung, ggf. Petechien (Meningokokken)

DIAGNOSTIK

- Klinik (Meningismus, Brudzinski/ Kernig)
- Liquorpunktion nach AO
- Labor/Blutkultur
- Bildgebung bei Indikation
- Vitalzeichen/Bewusstsein

THERAPIE

- Sofortige Antibiotikatherapie nach AO (nicht verzögern!)
- Ggf. Kortison nach AO
- Intensivüberwachung, Kreislauf-/ Atemstabilisierung
- Isolation (je nach Erreger)
- Symptomatische Therapie

Pflegeproblem	Gefahr der Verschlechterung r/t bakterieller Meningitis m/d/s Fieber, Meningismus, Bewusstseinstrübung
Ressourcen	Stationäre/intensive Versorgung, Frühzeitige Therapie
Pflegeziel	Eine Verschlechterung wird früh erkannt; der Patient bleibt kreislauf- und neurologisch stabil
Maßnahmen	• Vitalzeichen/Bewusstsein engmaschig überwachen • Antibiotika/Medikamente zeitgerecht nach AO • Reizarme, abgedunkelte Umgebung, Schmerz-/Fiebermanagement • Isolation nach Standard, konsequente Hygiene • Auf Petechien/Komplikationen achten, Intensiv
Evaluation	Früh erkannt, stabil, Therapie zeitgerecht, keine Übertragung.

Guillain-Barré-Syndrom G61

Akute, meist postinfektiöse Entzündung peripherer Nerven mit aufsteigenden, symmetrischen Lähmungen. Gefahr der Atemlähmung.

SYMPTOME

- Aufsteigende, symmetrische Muskelschwäche (von den Beinen)
- Reflexverlust
- Sensibilitätsstörungen/ Missempfindungen
- Gangunsicherheit
- Bei Progredienz: Atem-/ Schluckstörung, autonome Störungen

DIAGNOSTIK

- Klinik (aufsteigende Paresen, Areflexie)
- Liquor (Eiweißerhöhung)
- Elektroneurografie
- Atemfunktion überwachen
- Verlaufsbeobachtung

THERAPIE

- Immuntherapie (z. B. Immunglobuline/Plasmapherese) nach AO
- Engmaschige Überwachung der Atmung (Intensiv!)
- Thrombose-/Pneumonie-/ Dekubitusprophylaxe
- Physiotherapie
- Schmerz-/Symptomtherapie

Pflegeproblem	Gefahr der respiratorischen Insuffizienz r/t aufsteigender Lähmung bei GBS m/d/s zunehmender Muskelschwäche
Ressourcen	Intensive Überwachung möglich, Therapie läuft
Pflegeziel	Eine respiratorische Verschlechterung wird früh erkannt; der Patient bleibt ausreichend ventiliert
Maßnahmen	• Atmung/Vitalkapazität engmaschig überwachen, Beatmungsbereitschaft • Schluckstörung/Aspiration beachten • Thrombose-/Pneumonie-/Dekubitus-/Kontrakturprophylaxe • Immuntherapie nach AO begleiten, Physiotherapie • Psychische Unterstützung, Kommunikation sichern
Evaluation	Atmung früh überwacht, ausreichend ventiliert, keine Prophylaxe-Komplikation.

Polyneuropathie G62

Erkrankung mehrerer peripherer Nerven, häufig durch Diabetes oder Alkohol. Typisch: distal-symmetrische Sensibilitätsstörungen und Missempfindungen.

SYMPTOME

- Kribbeln, Brennen, Taubheit (v. a. Füße, 'Socken'-Muster)
- Sensibilitätsstörungen, vermindertes Schmerzempfinden
- Muskelschwäche (fortgeschritten)
- Gang-/Standunsicherheit
- Erhöhte Verletzungs-/Wundgefahr (z. B. Fußulkus)

DIAGNOSTIK

- Anamnese (Diabetes, Alkohol), Neurologie
- Sensibilitäts-/Reflexprüfung
- Elektroneurografie
- Labor (Ursachensuche)
- Fußinspektion

THERAPIE

- Grunderkrankung behandeln (BZ-Einstellung, Alkoholkarenz)
- Schmerztherapie nach AO
- Fußpflege/Verletzungsschutz
- Physiotherapie
- Vitaminsubstitution nach AO bei Mangel

Pflegeproblem	Verletzungs-/Sturzgefahr r/t verminderter Sensibilität bei Polyneuropathie m/d/s Taubheit, Gangunsicherheit
Ressourcen	Patient lernbereit, Grunderkrankung behandelbar
Pflegeziel	Der Patient bleibt sturz- und verletzungsfrei; die Füße bleiben intakt
Maßnahmen	• Füße/Haut täglich inspizieren, Druck/Verletzungen vermeiden • Sturzprophylaxe, sichere Mobilisation • Schmerz-/Missempfindungen nach AO managen • Geeignetes Schuhwerk/Fußpflege, Vorsicht mit Wärmequellen • Grunderkrankung (BZ/Alkohol) unterstützen, Edukation
Evaluation	Sturz-/verletzungsfrei, Füße intakt, Beschwerden gelindert.

Fazialisparese G51

Lähmung des Gesichtsnervs (N. facialis), meist einseitig und idiopathisch (Bell-Parese). Halbseitige Gesichtslähmung; wichtig ist der Schutz des Auges.

SYMPTOME

- Einseitig hängender Mundwinkel
- Unvollständiger Lidschluss (betroffenes Auge)
- Fehlende Stirnrunzelung (periphere Parese)
- Verwaschene Sprache, Speichelfluss
- Geschmacks-/Hörveränderungen möglich

DIAGNOSTIK

- Klinik (einseitige mimische Schwäche, Stirn betroffen?)
- Abgrenzung zentral/peripher
- Neurologische Untersuchung
- Ggf. weitere Abklärung (Ursachen)

THERAPIE

- Ggf. Kortison nach AO (früh)
- Augenschutz (Tränenersatz, Uhrglasverband) zwingend
- Mimische Übungen/ Physiotherapie/Logopädie
- Ursachenbehandlung
- Verlaufskontrolle

Pflegeproblem	Gefahr einer Hornhautschädigung r/t unvollständigem Lidschluss bei Fazialisparese m/d/s fehlendem Lidschluss, trockenem Auge
Ressourcen	Patient kooperativ, Therapie früh begonnen
Pflegeziel	Das betroffene Auge bleibt geschützt und reizfrei (keine Hornhautschädigung)
Maßnahmen	• Augenschutz konsequent (Tränenersatz, ggf. Uhrglasverband), Augenkontrolle • Bei Mahlzeiten Aspiration/Speichelfluss beachten, Mundpflege • Mimische Übungen/Physio-/Logopädie unterstützen • Medikamente (z. B. Kortison) nach AO • Psychische Unterstützung, Edukation
Evaluation	Auge geschützt und reizfrei, keine Hornhautschädigung, Therapie umgesetzt.

HNO

10 Krankheitsbilder

Tracheotomie-Pflege Z93.0

Tracheotomie = operativer Zugang zur Trachea. Temporär (PDT: perkutane Dilatationstracheotomie bei Langzeitbeatmung) oder dauerhaft (Laryngektomie). Sichert Atemweg, erleichtert Weaning. Tracheostomaversorgung ist Kernkompetenz der Intensivpflege und HNO.

SYMPTOME

- Atemnot bei Verlegung der Kanüle
- Sekretansammlung
- Hautreizung um Stoma
- Granulationen
- Kanülenobstruktion

DIAGNOSTIK

- Klinische Beurteilung (Atemgeräusche, Sekret)
- Laryngoskopie bei Komplikationen
- Bronchoskopie bei Verdacht Sekretpfropf

THERAPIE

- Regelmäßige Kanülenpflege
- Absaugung (steril/aseptisch nach Standard)
- Innenkanüle wechseln
- Feuchtigkeitserhalt (HME-Filter, Befeuchtung)
- Stöma-Hautpflege
- Sprechen: Sprechkanüle, Passy-Muir-Ventil

Pflegeproblem	Ineffektive Atemwegsclearance r/t Tracheotomie und eingeschränktem Hustenmechanismus m/d/s zähes Sekret, Absaugbedarf
Ressourcen	Patient kann bei Absaugung mitarbeiten, Absaugeinheit vorhanden
Pflegeziel	Atemwege bleiben frei, $SpO_2 \geq 94\%$, Absaugintervall > 2h ohne Atemnot
Maßnahmen	• Absaugung: NUR bei Bedarf (nicht nach Schema!), sterile Technik • Vor Absaugen: präoxygenieren (FiO_2 erhöhen, bei Beatmung) • Einführtiefe: max. 0,5cm über Kanülenspitze – nicht tiefer! • Sog max. 150-200 cmH_2O, max. 15 Sek. pro Absaugvorgang • Innenkanüle alle 8h wechseln/reinigen • HME-Filter 24h-Wechsel (Befeuchtung, Bakterienfilter) • Ausreichend Flüssigkeit sichern (Sekretverflüssigung) • Raumluftbefeuchtung • Stöma täglich reinigen: sterile NaCl-Kompressen
Evaluation	Atemgeräusche, SpO_2, Sekretmenge/-beschaffenheit, Hautbefund

KONTROLLFRAGEN

73 **Was ist der Unterschied zwischen PDT und chirurgischer Tracheotomie?**

(A) Kein Unterschied

(B) PDT = perkutane Dilatation am Patientenbett (Intensiv, Notfall), chirurgische = OP-Saal, präziser bei Adipositas/Kurzalshals

(C) PDT ist dauerhafter

(D) PDT ist nur für Kinder

74 **Warum wird bei der Tracheostomaabsaugung präoxygeniert?**

A Nur bei Beatmeten nötig

B Absaugung unterbricht Ventilation/Oxygenierung → SpO_2-Abfall → vorherige O_2-Erhöhung verhindert Hypoxie

C Nur wegen Keimfreiheit

D Keine Begründung

75 **Was ist ein HME-Filter bei Tracheotomie?**

A Ein Absaugkatheter

B Heat and Moisture Exchanger: Wärme-Feuchtigkeits-Austauscher + Bakterienfilter – ersetzt Nasenrachen-Funktion

C Ein Sprechventil

D Eine Kanülenart

Otitis media (Mittelohrentzündung) H66

Häufigste bakterielle Infektion im Kindesalter (70% aller Kinder bis 3J. mindestens einmal). Akut: meist viral/bakteriell (Pneumokokken, H. influenzae). Chronisch: Gefahr Komplikationen. Wichtig für GPA-Pädiatrie-Einsatz.

SYMPTOME

- Starke Ohrenschmerzen (Otalgie)
- Fieber
- Hörverlust (Schallleitungsschwerhörigkeit)
- Reizbarkeit (Säuglinge)
- Ohrziehen (Kinder)
- Druckgefühl im Ohr
- Eitrige Sekretion bei Perforation (dann Schmerzlinderung!)

DIAGNOSTIK

- Otoskopie: gerötet, vorgewölbt, Lichtreflex fehlt
- Tympanometrie
- Audiometrie bei chronischer Form
- Abstrich bei Sekretion

THERAPIE

- Schmerztherapie: Ibuprofen, Paracetamol
- Abschwellende Nasentropfen
- Abwartend bei unkomplizierter akuter Otitis (7 Tage)
- Antibiotika: Amoxicillin bei Komplikationen/Risikogruppen
- Parazentese (Einschnitt Trommelfell) bei starken Schmerzen
- Paukenröhrchen bei rezidivierender Otitis

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Mittelohrentzündung m/d/s Kind weint, NRS-Kinderskala 7, Ohrziehen
Ressourcen	Eltern kooperativ, Kind ablenkbar
Pflegeziel	Schmerz auf NRS-Kinderskala ≤ 3 innerhalb von 1h nach Analgesie
Maßnahmen	• Analgetikum nach Anordnung: Ibuprofen (bevorzugt, auch antiinflammatorisch) oder Paracetamol gewichtsadaptiert • Wärme auf Ohr (Kirschkernsäckchen, wenn kein Abszess!) • Abschwellende Nasentropfen nach Anordnung • Ablenkung: Spielzeug, Eltern einbeziehen • Keine Wattepfropfen ins Ohr! • Lagerung: betroffene Seite oben → erleichtert Drainage • Fiebersenkung nach Anordnung
Evaluation	NRS-Kinderskala 30 Min. nach Analgesie

KONTROLLFRAGEN

76 **Warum sind Kinder häufiger von Otitis media betroffen als Erwachsene?**

A) Kindliche Immunschwäche allein

B) Eustachische Röhre kürzer, horizontaler und weicher – schlechtere Belüftung + leichterer Keimaufstieg aus dem Nasopharynx

C) Nur wegen Infektionen

D) Kein Unterschied

77 **Was bedeutet es, wenn bei Otitis media plötzlich Eiter aus dem Ohr fließt?**

A) Verschlimmerung

B) Trommelfellperforation → Druckentlastung → Schmerzlinderung! Oft positive Wendung.

C) Sofortiger Notfall

D) Kein Zeichen

78 **Was ist ein Paukenröhrchen?**

A) Ein Hörgerät

B) Kleines Titanröhrchen im Trommelfell: belüftet Mittelohr, lässt Sekret abfließen – bei rezidivierender Otitis

C) Ein Antibiotikum

D) Ein Diagnoseinstrument

Tonsillitis (Angina tonsillaris) J03

Akute Entzündung der Gaumenmandeln, meist bakteriell (Streptokokken) oder viral. Häufig mit Halsschmerzen und Fieber.

SYMPTOME

- Halsschmerzen, Schluckbeschwerden
- Gerötete, geschwollene Mandeln (ggf. Beläge)
- Fieber
- Geschwollene Halslymphknoten
- Kopf-/Gliederschmerzen
- Mundgeruch

DIAGNOSTIK

- Racheninspektion
- Anamnese, Temperatur
- Ggf. Streptokokken-Schnelltest
- Auf Komplikationen achten (Abszess)
- Labor bei Bedarf

THERAPIE

- Analgesie/Antipyrese nach AO
- Antibiotika bei bakterieller Genese nach AO
- Ausreichend Flüssigkeit, Schonung
- Bei rezidivierender Tonsillitis ggf. Tonsillektomie
- Lokale Maßnahmen

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Tonsillitis m/d/s Halsschmerz, Schluckbeschwerden, Fieber
Ressourcen	Patient kooperativ, Behandlung verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist schmerzgelindert (NRS ≤ 3), fieberfrei und nimmt ausreichend Flüssigkeit
Maßnahmen	• Schmerz-/Fiebermanagement nach AO • Weiche Kost, ausreichend (kühle) Flüssigkeit • Auf Schluck-/Atembeschwerden und Abszesszeichen achten • Mundpflege • Edukation (Therapietreue, Ansteckung)
Evaluation	Schmerz gelindert, fieberfrei, ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.

Sinusitis (Rhinosinusitis) J32

Entzündung der Nasennebenhöhlen, oft nach Erkältung. Akut oder chronisch; meist viral, teils bakteriell.

SYMPTOME

- Druck-/Kopfschmerz (verstärkt beim Bücken)
- Behinderte Nasenatmung
- Eitriges Nasensekret
- Riechminderung
- Druckschmerz über den Nebenhöhlen
- Ggf. Fieber

DIAGNOSTIK

- Klinik (Druckschmerz, Sekret)
- Anamnese
- Ggf. Endoskopie/Bildgebung
- Auf Komplikationen achten
- Temperatur

THERAPIE

- Abschwellende Maßnahmen (Nasenspray/Spülung) nach AO
- Analgesie nach AO
- Antibiotika nur bei bakterieller/komplizierter Genese nach AO
- Ausreichend Flüssigkeit, Inhalation
- Bei chronischem Verlauf HNO

Pflegeproblem	Schmerz und behinderte Nasenatmung r/t Sinusitis m/d/s Gesichtsdruck, Sekretstau
Ressourcen	Patient kooperativ, Behandlung verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist schmerzgelindert und atmet freier durch die Nase
Maßnahmen	• Abschwellende Maßnahmen/Nasenpflege nach AO • Inhalation/Befeuchtung, ausreichend Flüssigkeit • Schmerz-/Fiebermanagement nach AO • Oberkörper hoch, Ruhe • Edukation zu Anwendung/Warnzeichen
Evaluation	Schmerz gelindert, Nasenatmung verbessert, kein Komplikationshinweis.

Epistaxis (Nasenbluten) R04.0

Blutung aus der Nase, meist aus dem vorderen Nasenseptum (Locus Kiesselbachi). Meist harmlos, selten bedrohlich (z. B. bei Antikoagulation/Hypertonie).

SYMPTOME

- Blutung aus der Nase (ein-/beidseitig)
- Blutfluss in den Rachen möglich
- Bei starker Blutung: Kreislaufzeichen
- Angst/Unruhe
- Ggf. Hinweise auf Ursache (Hypertonie, Antikoagulation)

DIAGNOSTIK

- Blutungsquelle/-stärke beurteilen
- Vitalzeichen (RR, Puls)
- Anamnese (Antikoagulation, Hypertonie, Trauma)
- Auf Kreislaufrelevanz achten

THERAPIE

- Oberkörper aufrecht, Kopf nach vorne, Nasenflügel komprimieren
- Kühlung (Nacken), ggf. abschwellende/blutstillende Maßnahmen nach AO
- Bei starker Blutung Tamponade/HNO nach AO
- Ursache behandeln (RR, Gerinnung)
- Beruhigung

Pflegeproblem	Gefahr von Blutverlust und Angst r/t Epistaxis m/d/s Nasenblutung, Unruhe
Ressourcen	Patient kooperativ, Sofortmaßnahmen möglich
Pflegeziel	Die Blutung steht; der Patient ist kreislaufstabil und beruhigt
Maßnahmen	• Sofortmaßnahmen (aufrecht, Kopf nach vorne, Nasenflügel komprimieren, Nacken kühlen) • Beruhigen, Blut ausspucken lassen • Vitalzeichen/Blutungsstärke überwachen • Bei Tamponade Pflege/Beobachtung • Ursachen (RR/Gerinnung) beachten, Edukation
Evaluation	Blutung gestillt, kreislaufstabil, beruhigt.

Hörsturz H91.2

Plötzliche, meist einseitige Innenohr-Schwerhörigkeit ohne erkennbare äußere Ursache. Wird als HNO-Eilfall behandelt.

SYMPTOME

- Plötzliche einseitige Hörminderung
- Ohrdruck/'Wattegefühl'
- Häufig Tinnitus
- Ggf. leichter Schwindel
- Keine Schmerzen

DIAGNOSTIK

- HNO-Untersuchung, Hörtests (Audiometrie)
- Otoskopie (Ausschluss anderer Ursachen)
- Anamnese
- Verlaufskontrolle

THERAPIE

- Glukokortikoide nach AO (oft hochdosiert/lokal)
- Ggf. durchblutungsfördernde Maßnahmen nach AO
- Ruhe, Stressreduktion
- HNO-Verlaufskontrolle
- Aufklärung

Pflegeproblem	Belastung durch akute Hörminderung r/t Hörsturz m/d/s einseitiger Hörminderung, Tinnitus, Sorge
Ressourcen	Patient kooperativ, Frühzeitige Behandlung
Pflegeziel	Der Patient erhält zeitgerecht die Therapie und ist im Umgang mit der Situation unterstützt
Maßnahmen	• Medikamente nach AO geben, Wirkung/Nebenwirkung beobachten • Ruhe/Stressreduktion fördern • Bei Schwindel Sturzprophylaxe • Psychische Unterstützung • Edukation zu Therapie/Verlauf
Evaluation	Therapie zeitgerecht, Patient unterstützt, Verlauf beobachtet.

Morbus Menière (Drehschwindel) H81.0

Innenohrerkrankung mit anfallsartigem Drehschwindel, Hörminderung und Tinnitus, bedingt durch Endolymphschwankungen.

SYMPTOME

- Anfallsartiger heftiger Drehschwindel (Minuten bis Stunden)
- Übelkeit/Erbrechen
- Einseitige Hörminderung
- Tinnitus
- Druckgefühl im Ohr, Fallneigung

DIAGNOSTIK

- HNO-Untersuchung, Hörtests
- Gleichgewichtsdiagnostik
- Anamnese (Anfallsmuster)
- Ausschluss anderer Ursachen

THERAPIE

- Im Anfall: Ruhe, Antiemetika/Antivertiginosa nach AO
- Sturzschutz
- Langfristig: medikamentös/diätetisch nach AO
- HNO-Betreuung
- Aufklärung/Schulung

Pflegeproblem	Sturzgefahr r/t anfallsartigem Drehschwindel bei Morbus Menière m/d/s Schwindel, Übelkeit, Fallneigung
Ressourcen	Patient kooperativ, Begleitung verfügbar
Pflegeziel	Der Patient bleibt im Anfall sturzfrei und ist symptomgelindert
Maßnahmen	• Sturzprophylaxe, reizarme Umgebung, ruhige Lagerung, beruhigen • Antiemetika/Antivertiginosa nach AO, Erbrechen managen • Begleitung beim Gehen • Flüssigkeit/Ernährung anpassen • Edukation zu Verhalten im Anfall
Evaluation	Sturzfrei, Schwindel/Übelkeit gelindert.

Larynxkarzinom (Kehlkopfkarzinom) C32

Bösartiger Tumor des Kehlkopfs, Hauptrisikofaktoren Rauchen und Alkohol. Häufig anhaltende Heiserkeit als Frühzeichen.

SYMPTOME

- Anhaltende Heiserkeit
- Fremdkörpergefühl/Räusperzwang
- Schluckbeschwerden
- Husten, ggf. blutiger Auswurf
- Bei Fortschreiten: Atemnot, Halslymphknoten

DIAGNOSTIK

- HNO-Untersuchung, Laryngoskopie
- Biopsie (Sicherung)
- Bildgebung/Staging
- Anamnese (Rauchen/Alkohol)

THERAPIE

- Operative Therapie (Teil-/Laryngektomie)
- Strahlen-/Chemotherapie nach AO
- Bei Laryngektomie: Tracheostoma, Stimmrehabilitation
- Nachsorge
- Rauch-/Alkoholkarenz

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Kommunikation und Atemwegssicherheit r/t Larynxkarzinom/Laryngektomie m/d/s Stimmverlust, Tracheostoma
Ressourcen	Patient lernbereit, Logopädie/Stomatherapie verfügbar, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Der Atemweg ist sicher; der Patient kann sich verständigen und versorgt sein Tracheostoma zunehmend selbstständig
Maßnahmen	• Tracheostoma sicher versorgen/absaugen, Atmung/Sekret beobachten • Kommunikationshilfen bereitstellen (Schreibtafel, später Stimmrehabilitation) • Therapienebenwirkungen nach AO managen, Ernährung/Schlucken • Perioperative/onkologische Pflege • Psychische Unterstützung, Logopädie, Rauch-/Alkoholkarenz
Evaluation	Atemweg sicher, Verständigung möglich, zunehmende Selbstversorgung.

Peritonsillarabszess J36

Eiteransammlung neben der Gaumenmandel, meist als Komplikation einer Tonsillitis. Kann die Atmung gefährden – ein HNO-Notfall.

SYMPTOME

- Zunehmende, oft einseitige Halsschmerzen
- Hohes Fieber
- Kloßige Sprache
- Kieferklemme (Mundöffnung erschwert)
- Schluckunfähigkeit/Speichelfluss, einseitige Schwellung

DIAGNOSTIK

- Racheninspektion (einseitige Vorwölbung, Uvula-Verdrängung)
- Klinik, Temperatur
- HNO-Vorstellung
- Auf Atemwegsgefährdung achten

THERAPIE

- Abszessentlastung (Punktion/ Inzision) nach AO
- Antibiotika nach AO
- Analgesie/Antipyrese nach AO
- Flüssigkeit (oft i.v.)
- Auf Atemweg achten, ggf. stationär

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Atemwegsgefährdung r/t Peritonsillarabszess m/d/s einseitiger Schwellung, Schluckunfähigkeit
Ressourcen	Stationäre Versorgung, Frühzeitige Behandlung
Pflegeziel	Der Atemweg bleibt frei; der Patient ist schmerzgelindert und kann schlucken
Maßnahmen	• Atmung/Schlucken engmaschig beobachten (Atemwegsgefährdung) • Schmerz-/Fiebermanagement nach AO • Flüssigkeit (oft i.v.) sichern, Bilanz • Nach Abszessentlastung beobachten, Mundpflege • Beruhigen, Edukation
Evaluation	Atemweg frei, Schmerz gelindert, Schlucken möglich.

Otitis externa H60

Entzündung des äußeren Gehörgangs ('Bade-Otitis'), oft bakteriell oder durch Feuchtigkeit. Schmerzhaft, mit Juckreiz und Schwellung.

SYMPTOME

- Ohrenschmerzen (verstärkt bei Zug an der Ohrmuschel)
- Juckreiz im Gehörgang
- Schwellung/Rötung, Sekretion
- Hörminderung bei Schwellung
- Druckgefühl

DIAGNOSTIK

- Otoskopie (geröteter, geschwollener Gehörgang)
- Klinik (Tragus-/Zugschmerz)
- Ggf. Abstrich
- Anamnese (Wasser, Manipulation)

THERAPIE

- Reinigung des Gehörgangs (HNO) nach AO
- Lokale (antibiotisch/antiseptische) Ohrentropfen nach AO
- Analgesie nach AO
- Gehörgang trocken halten
- Manipulation/Wattestäbchen meiden

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Entzündung des äußeren Gehörgangs m/d/s Ohrenschmerz, Schwellung, Juckreiz
Ressourcen	Patient kooperativ, Behandlung verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist schmerzgelindert; die Entzündung klingt ab
Maßnahmen	• Ohrentropfen/Lokaltherapie nach AO korrekt anwenden/anleiten • Schmerzmanagement nach AO • Gehörgang trocken halten, vor Wasser schützen • Manipulation vermeiden, Edukation • Auf Besserung/Komplikation achten
Evaluation	Schmerz gelindert, Entzündung rückläufig.

Onkologie

10 Krankheitsbilder

Onkologische Pflegegrundlagen C00-C97

Onkologische Pflege umfasst alle pflegerischen Maßnahmen bei Krebserkrankungen: Prävention, Therapiebegleitung (OP, Chemo, Bestrahlung, Immuntherapie), Symptommanagement und Palliativpflege. Besondere Anforderungen an Kommunikation und Psychoonkologie.

SYMPTOME

- B-Symptome: Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust
- Fatigue (tumorbedingte Erschöpfung)
- Schmerzen (akut/chronisch)
- Nausea/Emesis (CINV)
- Mukositis (Schleimhautentzündung)
- Neutropenie (Infektionsgefahr)
- Thrombozytopenie (Blutungsrisiko)
- Alopecie (Haarausfall)

DIAGNOSTIK

- Staging: TNM-Klassifikation
- PET-CT, CT, MRT
- Tumormarker
- Biopsie
- Labor: Blutbild, Leber/Niere vor Chemo

THERAPIE

- Chirurgie
- Chemotherapie (Zytostatika)
- Strahlentherapie
- Immuntherapie (Checkpoint-Inhibitoren)
- Targeted Therapy (Tyrosinkinasehemmer)
- Palliativtherapie

Pflegeproblem	Übelkeit und Erbrechen r/t Chemotherapie (CINV) m/d/s Patient erbricht 5x täglich, Nahrungsablehnung
Ressourcen	Antiemetika vorhanden, Familie unterstützend, Motivation trotz Erschöpfung
Pflegeziel	CINV auf max. 2 Erbrechen/Tag reduziert, ausreichende Flüssigkeitszufuhr gesichert nach 48h
Maßnahmen	• Antiemetika nach Schema: prophylaktisch VOR Chemo-Gabe! • 5-HT3-Antagonisten (Ondansetron) + Dexamethason + NK1-Antagonisten (Aprepitant) je nach Emetogenität • Kalte/kühle Speisen bevorzugen (weniger Geruch) • Kleine, häufige Mahlzeiten (5-6/Tag statt 3 große) • Stark riechende Speisen vermeiden • Frische Luft, Fenster öffnen • Ingwer-Tee, Pfefferminze • Flüssigkeitsbilanz führen, bei > 1L Defizit: i.v.-Hydration • Mundpflege nach Erbrechen (Mundspülung)
Evaluation	Emesis-Tagebuch: Häufigkeit, Schwere (NCI-Skala)

Pflegeproblem	Risiko Infektion r/t Neutropenie durch Chemotherapie m/d/s Leukozyten 0,8 G/L, Fieber 38,5°C
Ressourcen	Patient kennt Infektionszeichen, Isolierungsmöglichkeit vorhanden
Pflegeziel	Keine lebensbedrohliche Infektion durch konsequente Schutzmaßnahmen; bei febriler Neutropenie: Antibiose innerhalb 1h
Maßnahmen	• Febrile Neutropenie = Notfall: Fieber ≥ 38,3°C bei Neutrophilen < 500/µl → sofort Arzt! • Blutkultur (2 Paare) VOR Antibiose (nicht verzögern!) • Breitband-Antibiose innerhalb 1h nach Anordnung • Umkehrisolation (protektive Isolation): Besucher mit MNS • Händehygiene: strikt WHO 5 Momente • Keine frischen Blumen/Topfpflanzen im Zimmer (Schimmel!) • Keine Rohkost, kein Rohmilchkäse (Low-Microbial-Diät nach Standard) • Täglich: Mundpflege Chlorhexidin, Körperpflege • GCSF nach Anordnung (Wachstumsfaktor für Neutrophile)
Evaluation	4-stündlich Temperatur, täglich Leukozyten/Neutrophile

KONTROLLFRAGEN

79 **Was bedeutet febrile Neutropenie?**

A) Normaler Verlauf der Chemotherapie

B) Fieber ≥ 38,3°C bei Neutrophilen < 500/µl – onkologischer Notfall, Antibiose innerhalb 1h!

C) Leichte Nebenwirkung

D) Nur bei Kindern

80 **Was ist CINV?**

A) Eine Krebsart

B) Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting – häufigste und gefürchtetste Nebenwirkung der Chemo

C) Ein Schmerzmittel

D) Eine Pflegediagnose

81 **Was ist Fatigue bei Krebspatienten?**

A) Normale Müdigkeit

B) Tumorbedingte Erschöpfung: multidimensional (körperlich, emotional, kognitiv), durch Schlaf nicht gebessert – häufig unterschätzt!

C) Ein Schmerzsyndrom

D) Eine Nebenwirkung nur der Bestrahlung

Palliativpflege Z51.5

Palliativpflege = aktive Gesamtbehandlung von Patienten mit unheilbarer, fortgeschrittener Erkrankung. Ziel: Lebensqualität, nicht Lebenszeit. WHO-Definition: weder Lebensverkürzung noch -verlängerung. Umfasst Schmerztherapie, Symptomkontrolle, psychosoziale/spirituelle Unterstützung.

SYMPTOME

- Schmerzen (häufig unzureichend behandelt)
- Dyspnoe
- Übelkeit
- Obstipation (durch Opioide)
- Mundtrockenheit
- Angst, Depression
- Delir (terminal)
- Rasselatmung (Sterbephase)

DIAGNOSTIK

- ECOG/KPS (Performance Status)
- ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale)
- Schmerzassessment: NRS, BPI
- Spirituelle Bedürfnisse: SPIR-Interview

THERAPIE

- Analgesie WHO-Stufenschema
- Opioide: Morphin, Oxycodon, Fentanyl transdermal
- Symptomkontrolle: Antiemetika, Laxanzien obligat zu Opioiden!
- Psychosoziale Unterstützung
- Seelsorge
- Angehörigenbegleitung

Pflegeproblem	Chronischer Schmerz r/t Tumorprogress m/d/s NRS 7 in Ruhe, Patient schläft nicht
Ressourcen	Offen für Opioidtherapie, Angehörige unterstützen Pflege
Pflegeziel	Dauerschmerz NRS ≤ 3, Nachtschlaf ≥ 5h nach Opioideinstellung innerhalb 48h
Maßnahmen	• Schmerzassessment: NRS, Lokalisation, Qualität, Verstärker/Linderung • Retardiertes Opioid nach Anordnung zur festen Zeit (nicht nach Bedarf!) • Schnellwirkendes Opioid als Reserve bei Durchbruchschmerz bereithalten • Laxans immer gleichzeitig zu Opioid verordnen lassen (keine Obstipation!) • Schmerztagebuch führen (Patient einbeziehen) • Komplementäre Maßnahmen: Lagerung, Wärme/Kälte, TENS, Entspannung • Nichts erzwingen: Patient darf Therapie ablehnen • Angehörige in Schmerzbeobachtung schulen
Evaluation	NRS 4-stündlich, Schlafqualität täglich, Nebenwirkungen (Obstipation, Übelkeit, Sedierung)

KONTROLLFRAGEN

82 **Was ist das WHO-Stufenschema der Schmerztherapie?**

A) Ein Pflegemodell

B) 3 Stufen: Nicht-Opioid → schwaches Opioid → starkes Opioid – immer Basisanalgesie, nicht nach Bedarf!

C) Nur für Krebsschmerzen

D) Ein Notfallschema

83 **Warum muss zu jedem Opioid ein Laxans verordnet werden?**

A) Nur bei alten Patienten

B) Opioide hemmen Darmmotilität (μ-Rezeptoren im Darm) – Obstipation tritt bei fast 100% auf und bessert sich NICHT durch Toleranz!

C) Nur bei hoher Dosis

D) Kein zwingender Grund

84 **Was ist Rasselatmung in der Sterbephase?**

A) Atemnot des Patienten

B) Geräuschvolle Atmung durch Sekretan sammlung im Rachen – Patient leidet meist nicht, aber Angehörige sehr!

C) Ein Notfall

D) Aspirationspneumonie

Bronchialkarzinom (Lungenkarzinom) C34

Bösartiger Lungentumor, Hauptrisikofaktor Rauchen. Oft spät symptomatisch; eingeteilt in klein- und nicht-kleinzellige Form.

SYMPTOME

- Anhaltender Husten/ Hustenveränderung
- Bluthaltiger Auswurf (Hämoptyse)
- Dyspnoe, thorakale Schmerzen
- Gewichtsverlust, Abgeschlagenheit
- Rezidivierende Atemwegsinfekte

DIAGNOSTIK

- Röntgen/CT-Thorax
- Bronchoskopie + Biopsie
- Labor, Staging
- Anamnese (Rauchen)
- Lungenfunktion

THERAPIE

- Operation (je nach Stadium)
- Strahlen-/Chemo-/zielgerichtete/ Immuntherapie nach AO
- Symptom-/Schmerzkontrolle, O_2 bei Bedarf
- Supportive/palliative Therapie
- Rauchstopp, psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Atmung und Belastung r/t Bronchialkarzinom/Therapie m/d/s Dyspnoe, Husten, Sorge
Ressourcen	Angehörige unterstützen, Psychoonkologie verfügbar
Pflegeziel	Der Patient ist atem- und symptomkontrolliert und in der Krankheitsbewältigung unterstützt
Maßnahmen	• Atmung/SpO_2 überwachen, O_2 nach AO, atemerleichternde Lagerung • Therapienebenwirkungen nach AO managen • Schmerz-/Symptomkontrolle, Ernährung • Psychoonkologische Begleitung, Angehörige einbeziehen • Atemtherapie/Mobilisation, Edukation (Rauchstopp)
Evaluation	Atmung/Symptome kontrolliert, Patient unterstützt.

Kolorektales Karzinom (Darmkrebs) C18

Bösartiger Tumor von Dick- oder Enddarm, häufig. Früherkennung (Vorsorge-Koloskopie) verbessert die Prognose deutlich.

SYMPTOME

- Veränderte Stuhlgewohnheiten
- Blut im Stuhl
- Leistungsminderung, Gewichtsverlust
- Anämie (okkulte Blutung)
- Bauchschmerzen, ggf. Ileuszeichen

DIAGNOSTIK

- Koloskopie + Biopsie
- Stuhltest (okkultes Blut)
- Bildgebung/Staging
- Labor (Anämie, Tumormarker nach AO)

THERAPIE

- Operative Tumorentfernung (ggf. Stoma)
- Chemo-/Strahlentherapie nach AO
- Symptom-/Schmerzkontrolle
- Nachsorge
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Belastung und Ausscheidungsveränderung r/t kolorektalem Karzinom/Therapie m/d/s Stuhlveränderung, ggf. Stoma, Sorge
Ressourcen	Patient kooperativ, Stomatherapie/Angehörige
Pflegeziel	Der Patient ist symptomkontrolliert und versorgt seine Ausscheidung/ein Stoma zunehmend selbstständig
Maßnahmen	• Perioperative/onkologische Pflege; bei Stoma Versorgung/Anleitung, Hautschutz • Ausscheidung/Blutung beobachten, Ernährung, Bilanz • Therapienebenwirkungen nach AO managen • Schmerz-/Symptomkontrolle • Psychische Unterstützung, Edukation (Vorsorge)
Evaluation	Symptome kontrolliert, Versorgung sicher, zunehmende Selbstständigkeit.

Leukämie C95

Bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems mit unkontrollierter Vermehrung unreifer weißer Blutzellen. Akut oder chronisch.

SYMPTOME

- Müdigkeit, Blässe (Anämie)
- Infektneigung (Mangel funktionsfähiger Leukozyten)
- Blutungsneigung (Thrombozytopenie)
- Fieber, Nachtschweiß
- Lymphknoten-/Milzschwellung, Knochenschmerzen

DIAGNOSTIK

- Blutbild (Zytopenien/Blasten)
- Knochenmarkpunktion
- Weiterführende Diagnostik/ Typisierung
- Verlaufskontrollen

THERAPIE

- Chemotherapie nach AO
- Ggf. Stammzelltransplantation
- Supportiv: Transfusionen, Infektprophylaxe/-therapie nach AO
- Symptomkontrolle
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Infektionsgefahr r/t therapiebedingter Immunsuppression bei Leukämie m/d/s Neutropenie, Fieberneigung
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige unterstützen
Pflegeziel	Der Patient entwickelt keine unbehandelte Infektion; Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Strenge Infektionsprophylaxe, Hygiene/ggf. Umkehrisolation • Temperatur überwachen, Fieber als Notfall behandeln (febrile Neutropenie) • Auf Blutungs-/Anämiezeichen achten, Transfusionen nach AO begleiten • Chemotherapie-Nebenwirkungen managen, Mund-/Hautpflege • Psychische Unterstützung, Edukation
Evaluation	Keine unbehandelte Infektion, Komplikationen früh erkannt.

Malignes Lymphom (Hodgkin/Non-Hodgkin) C85

Bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems mit Lymphknotenvergrößerung. Unterschieden werden Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome.

SYMPTOME

- Schmerzlose Lymphknotenschwellung
- B-Symptomatik: Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust
- Müdigkeit, Leistungsminderung
- Juckreiz
- Infektneigung möglich

DIAGNOSTIK

- Lymphknotenbiopsie
- Bildgebung/Staging
- Labor, Knochenmarkdiagnostik
- Verlaufskontrolle

THERAPIE

- Chemotherapie nach AO
- Strahlentherapie nach AO
- Ggf. Immun-/zielgerichtete Therapie
- Supportive Therapie
- Psychoonkologische Begleitung

Pflegeproblem	Belastung durch Erkrankung und Therapie r/t malignem Lymphom m/d/s B-Symptomatik, Therapienebenwirkungen
Ressourcen	Patient kooperativ, Angehörige/Psychoonkologie
Pflegeziel	Der Patient ist symptom- und nebenwirkungskontrolliert und in der Bewältigung unterstützt
Maßnahmen	• Therapienebenwirkungen nach AO managen (Übelkeit, Schleimhäute, Fatigue) • Infektionsprophylaxe, Temperatur überwachen • B-Symptomatik beobachten, Ernährung/Flüssigkeit • Schmerz-/Symptomkontrolle • Psychische Unterstützung, Edukation
Evaluation	Symptome/Nebenwirkungen kontrolliert, Patient unterstützt.

Chemotherapie – Nebenwirkungsmanagement Z51.1

Pflegerische Begleitung der zytostatischen Therapie mit Fokus auf Erkennung und Management typischer Nebenwirkungen sowie sicheren Umgang.

SYMPTOME

- Übelkeit/Erbrechen
- Knochenmarkdepression (Anämie, Infekt-, Blutungsneigung)
- Mukositis (Mundschleimhautentzündung)
- Haarausfall, Fatigue
- Haut-/Schleimhaut- und Magen-Darm-Probleme

DIAGNOSTIK

- Blutbild/Laborkontrollen nach AO
- Auf Fieber/Infektzeichen achten (febrile Neutropenie!)
- Mundschleimhaut/Haut beurteilen
- Übelkeit/Ernährung/Gewicht erfassen

THERAPIE

- Antiemese nach AO
- Infektprophylaxe/-therapie, Transfusionen nach AO
- Mundpflege/Mukositis-Prophylaxe
- Hautschutz, Ernährungsunterstützung
- Sicherer Umgang mit Zytostatika (Schutz, Extravasation vermeiden)

Pflegeproblem	Gefahr von Komplikationen r/t Chemotherapie-Nebenwirkungen m/d/s Übelkeit, Knochenmarkdepression, Mukositis
Ressourcen	Patient kooperativ, Behandlung strukturiert
Pflegeziel	Nebenwirkungen sind gelindert; Komplikationen (Infekt/Blutung) werden früh erkannt
Maßnahmen	• Antiemese nach AO, Übelkeit/Ernährung managen • Blutbild beachten, Infektionsprophylaxe, Fieber als Notfall behandeln • Mundpflege (Mukositisprophylaxe), Hautschutz • Fatigue-Management • Sicherer Umgang/Applikation, Extravasation beobachten, Edukation
Evaluation	Nebenwirkungen gelindert, Komplikationen früh erkannt, Therapie sicher.

Tumorschmerz (WHO-Stufenschema) R52

Schmerz bei Tumorerkrankungen, häufig chronisch. Behandlung nach WHO-Stufenschema; Ziel ist eine möglichst weitgehende Schmerzfreiheit.

SYMPTOME

- Anhaltender/wiederkehrender Schmerz
- Durchbruchschmerzen
- Beeinträchtigung von Schlaf/Alltag/Stimmung
- Bewegungs-/belastungsabhängiger Schmerz
- Begleitend Angst/Erschöpfung

DIAGNOSTIK

- Systematische Schmerzerfassung (Skala, Lokalisation, Charakter)
- Schmerzverlauf/-tagebuch
- Wirkung/Nebenwirkung der Therapie beurteilen
- Auf Durchbruchschmerz achten

THERAPIE

- WHO-Stufenschema (Nicht-Opioide → schwache → starke Opioide) nach AO
- Feste Basismedikation + Bedarfsmedikation (Durchbruchschmerz)
- Begleitmedikation (Koanalgetika) nach AO
- Nicht-medikamentös (Lagerung, Wärme/Kälte, Entspannung)
- Nebenwirkungsmanagement (z. B. Obstipationsprophylaxe bei Opioiden)

Pflegeproblem	Chronischer Schmerz r/t Tumorerkrankung m/d/s anhaltendem Schmerz, Durchbruchschmerzen
Ressourcen	Patient kooperativ, Schmerztherapie etabliert
Pflegeziel	Der Patient ist weitgehend schmerzgelindert (NRS ≤ 3) und kann am Alltag teilnehmen
Maßnahmen	• Schmerz regelmäßig erfassen (Skala) und dokumentieren • Basis-/Bedarfsmedikation nach AO, Wirkung kontrollieren • Opioid-Nebenwirkungen managen (Obstipationsprophylaxe, Übelkeit) • Nicht-medikamentöse Maßnahmen anbieten • Edukation und psychische Unterstützung
Evaluation	Schmerz weitgehend gelindert, Teilhabe verbessert, Nebenwirkungen beherrscht.

Febrile Neutropenie D70

Fieber bei stark verminderten neutrophilen Granulozyten (meist nach Chemotherapie) – ein onkologischer Notfall mit hoher Infektions-/Sepsisgefahr.

SYMPTOME

- Fieber bei bekannter/erwarteter Neutropenie
- Schüttelfrost, Krankheitsgefühl
- Oft wenig lokale Entzündungszeichen (durch Zellmangel)
- Mögliche rasche Verschlechterung (Sepsis)
- Kreislaufzeichen bei Sepsis

DIAGNOSTIK

- Temperatur + Blutbild (Neutropenie)
- Blutkulturen/Fokussuche nach AO
- Vitalzeichen, Sepsiszeichen
- Rasche ärztliche Einschätzung

THERAPIE

- Sofortige (kalkulierte) Antibiotikatherapie nach AO – nicht verzögern!
- Blutkulturen vor Antibiose nach AO
- Kreislaufüberwachung/-stabilisierung
- Strenge Infektionsprophylaxe/ Isolation
- Intensiv bei Sepsis

Pflegeproblem	Hohe Infektions-/Sepsisgefahr r/t febriler Neutropenie m/d/s Fieber bei Neutropenie
Ressourcen	Stationäre/rasche Versorgung, Frühzeitige Behandlung
Pflegeziel	Die Infektion wird zeitgerecht behandelt; der Patient bleibt kreislaufstabil (keine unerkannte Sepsis)
Maßnahmen	• Fieber als Notfall behandeln, sofort Arzt, Antibiose zeitgerecht nach AO • Blutkulturen/Diagnostik nach AO unterstützen • Vitalzeichen engmaschig, auf Sepsiszeichen achten • Strenge Hygiene/Schutzisolation • Edukation (Fieber sofort melden)
Evaluation	Antibiose zeitgerecht, kreislaufstabil, keine unerkannte Sepsis.

Portkatheter (Port) – Pflege Z45.2

Dauerhaft implantierter venöser Zugang (Portkammer unter der Haut) für Chemotherapie, Infusionen und Blutentnahmen. Pflegerischer Fokus: aseptische Handhabung und Komplikationsprävention.

SYMPTOME

- Implantierte Portkammer (meist subklavikulär tastbar)
- Nutzung nur mit Spezialnadel (Huber-Nadel)
- Risiken: Infektion, Thrombose, Diskonnektion, Paravasat
- Mögliche lokale Rötung/ Schwellung bei Komplikation
- Funktionsstörung (kein Rückfluss)

DIAGNOSTIK

- Punktionsstelle auf Infektion/ Entzündung beurteilen
- Durchgängigkeit/Rückfluss prüfen
- Auf Paravasat/Schwellung achten
- Hygiene-/Lagekontrolle

THERAPIE

- Aseptische Punktion mit Huber-Nadel, sterile Technik
- Spülung/Blockung nach Standard/ AO
- Bei Infektion/Komplikation Behandlung nach AO
- Korrekte Fixierung/Verband
- Nur geschultes Personal

Pflegeproblem	Infektions-/Komplikationsgefahr r/t implantiertem Portkatheter m/d/s zentralvenösem Zugang, Punktionen
Ressourcen	Geschultes Personal, Patient kooperativ
Pflegeziel	Der Port bleibt infektfrei und funktionsfähig; Komplikationen werden früh erkannt
Maßnahmen	• Streng aseptisch arbeiten, nur Huber-Nadel verwenden • Punktionsstelle auf Infektzeichen beobachten, steriler Verband • Durchgängigkeit prüfen, Spülung/Blockung nach Standard/AO • Auf Paravasat/Thrombose achten • Patientenedukation, Dokumentation
Evaluation	Port infektfrei und funktionsfähig, keine Komplikation.

Pädiatrie

10 Krankheitsbilder

Pseudokrupp (Laryngitis subglottica) J05.0

Virale Entzündung im subglottischen Larynxbereich mit Schleimhautschwellung. Typisch nachts bei Kleinkindern (6 Mon.–3 J.), meist selbstlimitierend.

SYMPTOME

- Bellender Husten
- Heiserkeit
- Inspiratorischer Stridor
- Einziehungen/Atemnot bei Schwere
- Meist nur subfebril
- Verschlechterung nachts und bei Aufregung

DIAGNOSTIK

- Klinische Diagnose (Anamnese, Auskultation)
- Schweregrad: Stridor in Ruhe? Einziehungen?
- SpO_2
- Keine routinemäßige Racheninspektion (cave Epiglottitis)

THERAPIE

- Ruhe, Kind aufrecht bei der Bezugsperson
- Kühle, feuchte Luft
- Glukokortikoid (z. B. Dexamethason/Prednisolon)
- Bei schwerem Stridor: vernebeltes Adrenalin
- O_2 bei Hypoxie
- Stationär bei Stridor in Ruhe/ Erschöpfung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Atmung r/t subglottischer Schleimhautschwellung m/d/s inspiratorischem Stridor, Einziehungen, Unruhe
Ressourcen	Eltern anwesend und beruhigend, Kind auf dem Arm der Eltern ruhig, Kooperative Familie
Pflegeziel	Kind atmet innerhalb von 2 h ruhiger, kein Stridor in Ruhe, $SpO_2 \geq 94$ %
Maßnahmen	• Kind aufrecht bei der Bezugsperson belassen, nicht aufregen • Kühle, feuchte Luft anbieten • Steroid und ggf. vernebeltes Adrenalin nach AO • SpO_2/Atemarbeit engmaschig, nach Adrenalin Rebound beobachten • Keine Racheninspektion ohne ärztliche Indikation
Evaluation	Stridor und Einziehungen rückläufig, SpO_2 stabil, Kind ruhig.

Bronchiolitis (RSV) J21.0

Meist durch RSV ausgelöste Entzündung der kleinen Atemwege bei Säuglingen (< 1–2 J.) mit obstruktiver Atemnot. Häufigste untere Atemwegsinfektion im 1. Lebensjahr.

SYMPTOME

- Vorausgehender Schnupfen
- Tachypnoe, Nasenflügeln
- Einziehungen
- Exspiratorisches Giemen/ feinblasige RGs
- Trinkschwäche
- Apnoen bei jungen Säuglingen

DIAGNOSTIK

- Klinische Diagnose
- SpO_2 und Atemfrequenz
- RSV-Schnelltest (optional)
- Beobachtung von Trinkverhalten/ Hydratation
- Röntgen nur bei Komplikationsverdacht

THERAPIE

- Atemwege freihalten (Nase absaugen)
- O_2 titriert (Zielsättigung)
- Flüssigkeitszufuhr sichern (kleine Mengen/Sonde/i.v.)
- Ggf. High-Flow/CPAP
- Monitoring (Apnoe!)
- Antibiotika nur bei bakterieller Superinfektion

Pflegeproblem	Ineffektive Atemwegsclearance r/t Sekretobstruktion der kleinen Atemwege m/d/s Giemen, Einziehungen, SpO_2-Abfall
Ressourcen	Eltern unterstützen die Pflege, Kind trinkt in kleinen Mengen, Zu Beginn stabiler Allgemeinzustand
Pflegeziel	Säugling zeigt innerhalb von 24 h freie Atemwege, SpO_2 im Zielbereich, keine Apnoen
Maßnahmen	• Nase regelmäßig absaugen/freihalten • Oberkörper leicht erhöht lagern • O_2 nach AO titrieren, SpO_2 kontinuierlich • Apnoe-Monitoring beim jungen Säugling • Trinkmenge sichern (kleine Mengen/Sonde nach AO), Aspiration vermeiden
Evaluation	Atemarbeit reduziert, SpO_2 stabil, keine Apnoen, ausreichende Trinkmenge.

Asthma bronchiale (im Kindesalter) J45

Chronisch-entzündliche Atemwegserkrankung mit variabler, reversibler Obstruktion und bronchialer Hyperreagibilität; anfallsartige Atemnot.

SYMPTOME

- Anfallsartige Atemnot
- Exspiratorisches Giemen, verlängertes Exspirium
- Trockener Husten (oft nachts)
- Engegefühl in der Brust
- Bei schwerem Anfall: Sprechdyspnoe, Einziehungen, Tachykardie

DIAGNOSTIK

- Anamnese (Trigger, Atopie)
- Auskultation (Giemen)
- Peak-Flow/Spirometrie (ältere Kinder)
- SpO_2
- Reversibilität nach Bronchodilatator

THERAPIE

- Anfall: inhalative kurzwirksame Beta-2-Mimetika (SABA)
- Systemische Steroide bei mittlerem/schwerem Anfall
- O_2 bei Hypoxie
- Dauertherapie: inhalative Steroide (ICS)
- Trigger meiden, Schulung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Atmung r/t bronchialer Obstruktion m/d/s Giemen, verlängertem Exspirium, Dyspnoe
Ressourcen	Kind kennt seine Inhalation, Eltern unterstützend, Bekannte Trigger
Pflegeziel	Kind atmet innerhalb von 1 h ruhiger, Giemen rückläufig, $SpO_2 \geq 94$ %
Maßnahmen	• Atemerleichternde Lagerung (Kutschersitz), Ruhe • Inhalative Bronchodilatatoren nach AO mit Spacer • SpO_2/Atemfrequenz/Atemarbeit engmaschig • Steroide nach AO bei mittlerem/schwerem Anfall • Kind und Eltern anleiten, Trigger meiden
Evaluation	Dyspnoe und Giemen rückläufig, SpO_2 stabil, Kind ruhig.

Akute Gastroenteritis mit Exsikkose A09

Meist virale (z. B. Rota-/Norovirus) Entzündung des Magen-Darm-Trakts mit Erbrechen/Durchfall. Bei Kleinkindern besteht rasche Dehydratationsgefahr.

SYMPTOME

- Erbrechen, wässrige Durchfälle
- Bauchschmerzen
- Eingesunkene Augen, trockene Schleimhäute
- Verlängerte Rekap-Zeit, reduzierter Hautturgor
- Verminderte Urinausscheidung
- Lethargie bei Schwere

DIAGNOSTIK

- Klinische Einschätzung des Dehydratationsgrades
- Gewichtsverlauf
- Vitalzeichen, Rekap-Zeit
- Bei Schwere: Elektrolyte, BZ
- Stuhldiagnostik nur bei Indikation

THERAPIE

- Orale Rehydratationslösung (ORS) in kleinen Mengen
- Bei schwerer Dehydratation/ Schock: i.v.-Rehydratation
- Frühe Wiederernährung
- Keine Motilitätshemmer bei Kleinkindern
- Hygiene/Isolation (Übertragung)

Pflegeproblem	Flüssigkeitsdefizit r/t Erbrechen und Durchfall m/d/s trockenen Schleimhäuten, verlängerter Rekap-Zeit, verminderter Urinausscheidung
Ressourcen	Kind nimmt kleine Mengen ORS an, Eltern beteiligen sich an der Pflege, Frühzeitige Vorstellung
Pflegeziel	Kind ist innerhalb von 24 h ausreichend hydriert (feuchte Schleimhäute, Rekap < 2 s, ausreichende Urinmenge)
Maßnahmen	• ORS in kleinen Mengen sehr häufig anbieten • Ein-/Ausfuhr und Gewicht dokumentieren • Vitalzeichen/Rekap-Zeit/Bewusstsein überwachen • Bei Versagen/Schockzeichen i.v.-Rehydratation nach AO • Hygiene/Isolation, Hautschutz im Windelbereich
Evaluation	Hydratationszeichen verbessert, Trink- und Urinmenge ausreichend, Gewicht stabilisiert.

Fieberkrampf R56.0

Mit Fieber assoziierter zerebraler Krampfanfall bei Kindern (meist 6 Mon.–5 J.) ohne ZNS-Infektion. Einfacher (kurz, generalisiert) vs. komplizierter Fieberkrampf.

SYMPTOME

- Generalisierter tonisch-klonischer Anfall im Fieber
- Bewusstseinsverlust
- Postiktale Schläfrigkeit
- Meist < 5 min (einfacher Fieberkrampf)
- Komplizierter: > 15 min, fokal oder wiederholt

DIAGNOSTIK

- Klinische Diagnose + Anamnese
- Meningitis/Enzephalitis ausschließen (Nackensteife, Petechien, Vigilanz!)
- Temperatur und Fokussuche
- Bei kompliziertem Krampf weiterführende Abklärung
- BZ bei Bewusstseinsstörung

THERAPIE

- Schützen, nichts in den Mund, Dauer messen
- Bei > 5 min: Benzodiazepin nach Notfallschema
- Fokus des Fiebers behandeln
- Aufklärung der Eltern (gute Prognose beim einfachen Fieberkrampf)

Pflegeproblem	Verletzungsgefahr r/t generalisiertem Krampfanfall m/d/s unkontrollierten Bewegungen und Bewusstseinsverlust
Ressourcen	Eltern anwesend, Rasche Reaktion des Teams, Kind zwischen den Anfällen stabil
Pflegeziel	Kind erleidet während und nach dem Anfall keine Verletzung; der Atemweg bleibt frei
Maßnahmen	• Umgebung sichern, vor Verletzung schützen, nichts in den Mund • Seitenlage, Atemweg/SpO_2 beobachten, Anfallsdauer messen • Bei > 5 min Medikation nach Notfallschema/AO • Postiktal Seitenlage und Vitalzeichen, Meningitis-Zeichen beobachten • Eltern beruhigen und über den Fieberkrampf aufklären
Evaluation	Keine Verletzung, Atemweg frei, Anfall sistiert, Eltern informiert.

Otitis media acuta H66.0

Akute Mittelohrentzündung (viral/bakteriell), häufig bei Kleinkindern nach Atemwegsinfekt. Meist selbstlimitierend.

SYMPTOME

- Ohrenschmerzen (Säuglinge: Greifen ans Ohr, Schreien)
- Fieber
- Hörminderung
- Unruhe/Schlafstörung
- Ggf. Ohrenfluss bei Trommelfellperforation

DIAGNOSTIK

- Otoskopie (gerötetes/vorgewölbtes Trommelfell)
- Anamnese
- Temperatur
- Hörprüfung bei Rezidiven

THERAPIE

- Analgesie/Antipyrese (Ibuprofen/Paracetamol)
- Abschwellende Maßnahmen
- Antibiotikum nach Indikation (Alter/Schwere)
- Abwartendes Offenhalten möglich
- HNO-Vorstellung bei Rezidiven

Pflegeproblem	Akuter Schmerz r/t Mittelohrentzündung m/d/s Greifen ans Ohr, Schreien, Unruhe
Ressourcen	Eltern unterstützend, Kind nimmt Medikamente an
Pflegeziel	Kind ist innerhalb von 24 h schmerzarm (altersgerechte Einschätzung) und schläft ruhiger
Maßnahmen	• Analgesie/Antipyrese nach AO geben und Wirkung kontrollieren • Kopf leicht erhöht lagern, Wärme anbieten • Ohr auf Sekretaustritt beobachten • Eltern zur Medikamentengabe und zu Warnzeichen anleiten • Ausreichend Flüssigkeit anbieten
Evaluation	Schmerz reduziert, Kind ruhiger, kein Hinweis auf Komplikation.

Pertussis (Keuchhusten) A37

Hochansteckende bakterielle Atemwegsinfektion (Bordetella pertussis) mit stakkatoartigen Hustenanfällen. Für junge Säuglinge gefährlich (Apnoen).

SYMPTOME

- Stakkatoartige Hustenanfälle mit inspiratorischem Ziehen
- Hustenattacken bis zum Erbrechen
- Zyanose/Apnoen (Säuglinge!)
- Wochenlang anhaltender Husten
- Anfangs erkältungsähnlich

DIAGNOSTIK

- Klinik + Anamnese (Impfstatus, Kontakt)
- Erregernachweis (PCR/Abstrich)
- Beobachtung der Hustenanfälle/ Apnoen
- SpO_2

THERAPIE

- Antibiotikum (Makrolid), v. a. früh/ zum Schutz
- Stationär bei jungen Säuglingen (Apnoe-Monitoring)
- O_2/Atemunterstützung bei Bedarf
- Isolation (hochansteckend)
- Impfung/Umgebungsprophylaxe

Pflegeproblem	Ineffektive Atmung r/t paroxysmalen Hustenanfällen m/d/s Apnoen, Zyanose, Erschöpfung
Ressourcen	Eltern anwesend, Stationäre Überwachung möglich
Pflegeziel	Säugling zeigt während der Überwachung keine unbehandelten Apnoen, SpO_2 im Zielbereich
Maßnahmen	• Kontinuierliches Apnoe-/SpO_2-Monitoring • Hustenanfälle begleiten, beruhigen, O_2 nach AO • Kleine, häufige Mahlzeiten wegen Erbrechen • Isolation und konsequente Hygiene • Antibiotikum nach AO, Eltern zu Impfung/Prophylaxe beraten
Evaluation	Apnoen erkannt und behandelt, SpO_2 stabil, ausreichende Nahrungsaufnahme.

Pneumonie im Kindesalter J18

Akute Entzündung des Lungenparenchyms (viral/bakteriell) mit Husten, Fieber und Atemnot; bei Kindern häufige stationäre Ursache.

SYMPTOME

- Fieber, Husten
- Tachypnoe, Nasenflügeln, Einziehungen
- Knisterrasseln/abgeschwächtes Atemgeräusch
- Trinkschwäche, Abgeschlagenheit
- Ggf. Bauch-/Flankenschmerz

DIAGNOSTIK

- Klinik + Auskultation
- SpO_2, Atemfrequenz
- Röntgen Thorax bei Indikation
- Entzündungswerte bei Bedarf
- Erregerdiagnostik nach Indikation

THERAPIE

- O_2 bei Hypoxie
- Antibiotikum bei bakterieller Genese nach AO
- Antipyrese, ausreichende Flüssigkeit
- Sekretmanagement/Lagerung
- Stationär bei Atemnot/ Trinkschwäche

Pflegeproblem	Beeinträchtigter Gasaustausch r/t Lungenparenchymentzündung m/d/s Tachypnoe, Einziehungen, SpO_2-Abfall
Ressourcen	Eltern unterstützend, Kind kooperiert bei Inhalation
Pflegeziel	Kind zeigt innerhalb von 48 h $SpO_2 \geq 94$ % und eine reduzierte Atemarbeit
Maßnahmen	• O_2 nach AO, SpO_2 kontinuierlich • Oberkörper erhöht, Sekretmanagement • Antipyrese und ausreichende Flüssigkeit nach AO • Atemfrequenz/Atemarbeit dokumentieren • Antibiotikum nach AO, Eltern einbeziehen
Evaluation	SpO_2 stabil, Atemarbeit reduziert, Fieber rückläufig.

Harnwegsinfekt / Pyelonephritis (Kind) N10

Bakterielle Harnwegsinfektion; bei Kindern auch fieberhaft als Pyelonephritis. Bei Säuglingen oft unspezifisch (Fieber, Trinkschwäche).

SYMPTOME

- Fieber (oft einziges Zeichen beim Säugling)
- Dysurie/Pollakisurie (ältere Kinder)
- Bauch-/Flankenschmerz
- Übelriechender Urin
- Trinkschwäche/Gedeihstörung
- Reizbarkeit

DIAGNOSTIK

- Urinstatus/-kultur (sachgerechte Gewinnung!)
- Entzündungswerte
- Sonografie der Harnwege
- Temperatur
- Bei Rezidiven weiterführende Abklärung

THERAPIE

- Antibiotikum nach AO/ Antibiogramm
- Ausreichende Flüssigkeit
- Antipyrese/Analgesie
- Bei fieberhafter Pyelonephritis ggf. stationär
- Abklärung anatomischer Ursachen (Reflux)

Pflegeproblem	Erhöhte Körpertemperatur r/t Harnwegsinfektion m/d/s Fieber, Reizbarkeit, Trinkschwäche
Ressourcen	Eltern unterstützend, Kind trinkt mit Anleitung
Pflegeziel	Kind ist innerhalb von 48 h fieberfrei und trinkt ausreichend
Maßnahmen	• Temperatur überwachen, Antipyrese nach AO • Sachgerechte Uringewinnung, Ein-/Ausfuhr • Trinkmenge fördern und dokumentieren • Antibiotikum nach AO, Wirkung beobachten • Intimhygiene anleiten, Eltern zur Prophylaxe beraten
Evaluation	Fieber rückläufig, ausreichende Trink-/Urinmenge, Wohlbefinden gebessert.

Invagination (Darmeinstülpung) K56.1

Einstülpung eines Darmabschnitts in den folgenden, v. a. bei Säuglingen/Kleinkindern. Akuter Notfall mit Ileus-/ Ischämiegefahr.

SYMPTOME

- Plötzliche kolikartige Bauchschmerzen (anfallsweise Schreien, Anziehen der Beine)
- Schmerzfreie Intervalle
- Erbrechen
- Himbeergeleeartiger (blutig-schleimiger) Stuhl
- Tastbare walzenförmige Resistenz
- Zunehmende Apathie

DIAGNOSTIK

- Klinik + Anamnese
- Abdomen-Sonografie (Kokarde/ Target-Zeichen)
- Vitalzeichen
- Ausschluss Ileus/Peritonitis

THERAPIE

- Nüchtern, i.v.-Zugang/Volumen
- Sonografisch gesteuerte hydrostatische/pneumatische Reposition
- Bei Versagen/Peritonitis operative Versorgung
- Monitoring, Analgesie nach AO

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Komplikationsgefahr r/t Darmeinstülpung m/d/s anfallsartigem Schreien, Erbrechen, blutigem Stuhl
Ressourcen	Eltern anwesend, Frühzeitige Vorstellung, Stationäre Versorgung
Pflegeziel	Kind ist nüchtern und kreislaufstabil; eine drohende Verschlechterung wird früh erkannt
Maßnahmen	• Nüchtern lassen, i.v.-Zugang/Volumen nach AO • Vitalzeichen, Schmerz und Bauchbefund engmaschig • Stuhl und Erbrechen beobachten/dokumentieren • Repositions-/OP-Vorbereitung nach AO • Eltern begleiten und aufklären
Evaluation	Kreislaufstabil, Schmerz kontrolliert, Reposition/OP erfolgreich, keine Peritonitiszeichen.

Orthopädie

10 Krankheitsbilder

Schenkelhalsfraktur (proximale Femurfraktur) S72.0

Bruch des proximalen Oberschenkels, häufig bei älteren Menschen nach Sturz (Osteoporose). Hohe Bedeutung wegen Immobilität und Komplikationen.

SYMPTOME

- Schmerzhafte Bewegungseinschränkung der Hüfte
- Bein verkürzt und außenrotiert
- Belastungsunfähigkeit
- Schwellung/Hämatom
- Sturzanamnese

DIAGNOSTIK

- Röntgen Hüfte/Becken
- Klinische Untersuchung
- Labor/EKG (OP-Vorbereitung)
- Begleitverletzungen ausschließen

THERAPIE

- Meist operativ (Osteosynthese oder Endoprothese)
- Frühmobilisation
- Analgesie
- Thrombose-/Pneumonie-/Dekubitusprophylaxe
- Osteoporose-Abklärung

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Mobilität r/t proximaler Femurfraktur und postoperativem Zustand m/d/s Schmerz, Belastungseinschränkung
Ressourcen	Motiviert mitzuarbeiten, Angehörige unterstützen, Vor Sturz selbstständig mobil
Pflegeziel	Patient mobilisiert in den ersten postoperativen Tagen nach AO schmerzarm (NRS ≤ 3) mit Hilfsmittel
Maßnahmen	• Schmerzmanagement nach AO, vor Mobilisation analgetisch abdecken • Frühmobilisation nach ärztlicher Freigabe, Physiotherapie einbeziehen • Thrombose-, Pneumonie- und Dekubitusprophylaxe konsequent • Durchblutung/Sensomotorik/Wundkontrolle dokumentieren • Sturzprophylaxe, Hilfsmittel bereitstellen
Evaluation	Schmerzarme Mobilisation gelingt, keine prophylaxeassoziierten Komplikationen.

Distale Radiusfraktur S52.5

Häufigste Fraktur des Erwachsenen, meist Sturz auf die ausgestreckte Hand. Versorgung konservativ (Gips) oder operativ (Platte).

SYMPTOME

- Schmerz/Schwellung am Handgelenk
- Fehlstellung (z. B. Gabel-/Bajonettstellung)
- Bewegungs-/Belastungseinschränkung
- Hämatom
- Ggf. Sensibilitätsstörung (N. medianus)

DIAGNOSTIK

- Röntgen Handgelenk in 2 Ebenen
- Durchblutung/Motorik/Sensibilität (DMS) prüfen
- Klinische Untersuchung

THERAPIE

- Reposition + Gips (konservativ) oder Osteosynthese
- Analgesie
- Hochlagerung, Schwellungskontrolle
- Frühfunktionelle Übungsbehandlung
- Gips-/Verbandkontrolle

Pflegeproblem	Gefahr peripherer neurovaskulärer Beeinträchtigung r/t Fraktur und Gipsverband m/d/s Schwellung, möglicher Einengung
Ressourcen	Patient kooperativ, Versteht die Anleitung
Pflegeziel	Durchblutung, Motorik und Sensibilität der Hand bleiben während des Aufenthalts intakt
Maßnahmen	• Hand konsequent hochlagern, Schwellung beobachten • DMS-Kontrolle regelmäßig dokumentieren • Gips/Verband auf Einengung prüfen, bei Zeichen sofort Arzt • Schmerzmanagement nach AO • Zu Fingerbewegungen und Selbstpflege anleiten
Evaluation	DMS intakt, keine Einengungszeichen, Schwellung rückläufig.

Koxarthrose (Hüftarthrose) M16

Degenerativer Verschleiß des Hüftgelenks mit Knorpelabbau, Schmerz und Bewegungseinschränkung. Endstadium: Hüft-Endoprothese (TEP).

SYMPTOME

- Belastungs-/Anlaufschmerz in Hüfte/Leiste
- Bewegungseinschränkung (v. a. Innenrotation)
- Hinken
- Schmerzausstrahlung bis ins Knie
- Zunehmende Verkürzung der Gehstrecke

DIAGNOSTIK

- Röntgen Hüfte (Gelenkspaltverschmälerung, Osteophyten)
- Klinische Funktionsprüfung
- Anamnese, Schmerzverlauf

THERAPIE

- Konservativ: Bewegung, Physiotherapie, Gewichtsreduktion, Analgesie
- Gelenkerhaltende Maßnahmen
- Hüft-Endoprothese (TEP) im Endstadium
- Postoperativ Mobilisation + Prophylaxen

Pflegeproblem	Chronischer Schmerz und beeinträchtigte Mobilität r/t Hüftarthrose (bzw. postoperativ nach TEP) m/d/s Belastungsschmerz, Bewegungseinschränkung
Ressourcen	Motiviert, Angehörige unterstützen, Versteht Bewegungsregeln
Pflegeziel	Patient bewegt sich schmerzarm (NRS ≤ 3) und hält nach TEP die Luxationsprophylaxe ein
Maßnahmen	• Schmerzmanagement nach AO, vor Mobilisation abdecken • Nach TEP Luxationsprophylaxe anleiten und überwachen • Frühmobilisation/Physiotherapie, Hilfsmittel schulen • Thrombose-/Pneumonie-/Dekubitusprophylaxe • Selbstständigkeit im Alltag fördern
Evaluation	Schmerzarme Mobilisation, Bewegungsregeln eingehalten, keine Komplikationen.

Gonarthrose (Kniearthrose) M17

Degenerativer Verschleiß des Kniegelenks mit Schmerz, Schwellung und Funktionsverlust. Endstadium: Knie-Endoprothese.

SYMPTOME

- Belastungs-/Anlaufschmerz im Knie
- Schwellung, Krepitation
- Bewegungseinschränkung
- Achsfehlstellung (O-/X-Bein)
- Verkürzung der Gehstrecke

DIAGNOSTIK

- Röntgen Knie (Gelenkspalt, Osteophyten)
- Klinische Funktionsprüfung
- Ggf. MRT bei Begleitschäden

THERAPIE

- Konservativ: Physiotherapie, Gewichtsreduktion, Analgesie
- Knie-Endoprothese im Endstadium
- Postoperativ: Mobilisation, Beweglichkeit (CPM-Schiene nach AO)
- Prophylaxen

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Mobilität r/t Kniearthrose (bzw. postoperativ nach Knie-TEP) m/d/s Schmerz, Schwellung, Bewegungseinschränkung
Ressourcen	Motiviert mitzuarbeiten, Physiotherapie verfügbar
Pflegeziel	Patient erreicht nach AO eine schmerzarme Mobilisation und zunehmende Kniebeweglichkeit
Maßnahmen	• Schmerz-/Schwellungsmanagement (Kühlung nach AO) • Frühmobilisation und Beweglichkeitsübungen nach AO • Thrombose-/Pneumonie-/Dekubitusprophylaxe • DMS- und Wundkontrolle dokumentieren • Gehschulung, Hilfsmittel bereitstellen
Evaluation	Zunehmende Beweglichkeit, schmerzarme Mobilisation, keine Komplikationen.

Lumbaler Bandscheibenvorfall M51.1

Verlagerung von Bandscheibengewebe mit möglicher Nervenwurzelkompression, meist lumbal (L4/5, L5/S1). Schmerz mit Ausstrahlung ins Bein.

SYMPTOME

- Rückenschmerz mit Ausstrahlung ins Bein (Ischialgie)
- Sensibilitätsstörungen/Kribbeln im Dermatom
- Kraftminderung
- Schmerzverstärkung bei Husten/Pressen
- Red Flags: Blasen-/Mastdarmstörung, Reithosenanästhesie

DIAGNOSTIK

- Neurologische Untersuchung (Kraft, Reflexe, Sensibilität)
- MRT der LWS
- Anamnese (Red Flags!)

THERAPIE

- Meist konservativ: Analgesie, Bewegung, Physiotherapie
- Entlastende Lagerung (z. B. Stufenbett)
- Operative Versorgung bei Lähmung/Kaudasyndrom (Notfall!)
- Rückenschule

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Gefahr neurologischer Ausfälle r/t Nervenwurzelkompression m/d/s ausstrahlendem Schmerz, Sensibilitätsstörung
Ressourcen	Patient kooperativ, Versteht rückenschonendes Verhalten
Pflegeziel	Patient ist schmerzarm (NRS ≤ 3); neue neurologische Ausfälle werden früh erkannt
Maßnahmen	• Schmerzmanagement nach AO, entlastende Lagerung (z. B. Stufenbett) • Neurologische Kontrolle (Kraft/Sensibilität, Blase/Mastdarm) dokumentieren • Mobilisation nach AO, rückengerechtes Verhalten anleiten • Bei Red Flags (Reithosenanästhesie/Blasenstörung) sofort Arzt • Sturz-/Dekubitusprophylaxe bei Immobilität
Evaluation	Schmerz reduziert, keine neuen Ausfälle, Mobilisation gelingt.

Osteoporose M81

Systemische Skeletterkrankung mit verminderter Knochendichte und erhöhter Frakturgefahr (typisch: Wirbelkörper, Hüfte, Radius). Häufig postmenopausal/altersbedingt.

SYMPTOME

- Oft lange asymptomatisch
- Frakturen bei geringem Trauma
- Rückenschmerzen, Größenabnahme
- Rundrücken (Hyperkyphose)
- Bewegungsangst/Immobilität

DIAGNOSTIK

- Knochendichtemessung (DXA, T-Wert)
- Röntgen (Wirbelkörperfrakturen)
- Labor (Kalzium, Vitamin D)
- Sturz-/Frakturrisiko erfassen

THERAPIE

- Kalzium + Vitamin D
- Antiresorptiva/Osteoanabolika nach AO
- Bewegung/Krafttraining
- Sturzprophylaxe
- Ernährungsberatung, Nikotin-/Alkoholkarenz

Pflegeproblem	Gefahr von Stürzen und Frakturen r/t verminderter Knochendichte m/d/s Frakturanamnese, Bewegungsunsicherheit
Ressourcen	Motiviert, Angehörige unterstützen, Selbstständig mobil
Pflegeziel	Patient erleidet während des Aufenthalts keinen Sturz/keine Fraktur und kennt Prophylaxemaßnahmen
Maßnahmen	• Sturzrisiko erfassen, Umgebung sichern, Hilfsmittel bereitstellen • Bewegung/Krafttraining nach AO fördern • Medikamente (Kalzium/Vitamin D, Antiresorptiva) nach AO und Beratung • Schmerzmanagement bei Frakturen • Ernährungs-/Lebensstilberatung
Evaluation	Kein Sturz/keine Fraktur, Patient kennt und nutzt Prophylaxemaßnahmen.

Schulterluxation S43.0

Auskugelung des Schultergelenks (meist vordere Luxation), oft traumatisch. Gefahr von Gefäß-/Nervenschäden (N. axillaris).

SYMPTOME

- Starke Schmerzen, federnde Fixation
- Sichtbare Konturveränderung (leere Pfanne)
- Bewegungsunfähigkeit
- Ggf. Sensibilitätsstörung über dem Deltoid (N. axillaris)
- Schonhaltung

DIAGNOSTIK

- Röntgen vor und nach Reposition
- DMS prüfen (v. a. N. axillaris)
- Klinische Untersuchung

THERAPIE

- Rasche Reposition (ärztlich) + Analgesie/Sedierung
- Ruhigstellung (z. B. Gilchrist) nach AO
- Frühfunktionelle Nachbehandlung
- Bei Rezidiven operative Stabilisierung

Pflegeproblem	Akuter Schmerz und Gefahr neurovaskulärer Schädigung r/t Schulterluxation m/d/s federnder Fixation, möglicher Sensibilitätsstörung
Ressourcen	Patient kooperativ, Versteht die Anleitung
Pflegeziel	Patient ist schmerzarm; DMS bleibt intakt; die Ruhigstellung wird korrekt eingehalten
Maßnahmen	• DMS (insbesondere N. axillaris) vor/nach Reposition prüfen • Schmerzmanagement nach AO • Korrekte Ruhigstellung (z. B. Gilchrist) anleiten/kontrollieren • Bewegungsübungen nach AO • Hautpflege unter dem Verband
Evaluation	Schmerz reduziert, DMS intakt, Ruhigstellung korrekt.

Sprunggelenksfraktur (OSG) S82.6

Bruch im Bereich des oberen Sprunggelenks (Außen-/Innenknöchel), oft durch Umknicktrauma. Versorgung konservativ oder operativ.

SYMPTOME

- Schmerz/Schwellung am Knöchel
- Belastungsunfähigkeit
- Fehlstellung/Hämatom
- Bewegungsschmerz
- Druckschmerz über den Malleolen

DIAGNOSTIK

- Röntgen OSG in 2 Ebenen
- DMS prüfen
- Weichteil-/Hautbeurteilung (Spannungsblasen)

THERAPIE

- Konservativ (Gips/Orthese) oder Osteosynthese
- Hochlagerung, Schwellungs-/Weichteilmanagement
- Thromboseprophylaxe bei Immobilisation
- Teilbelastung nach AO
- Physiotherapie

Pflegeproblem	Gefahr peripherer neurovaskulärer Beeinträchtigung und Thrombose r/t Fraktur, Schwellung und Immobilisation m/d/s Schwellung, eingeschränkter Belastung
Ressourcen	Patient kooperativ, Versteht die Teilbelastung
Pflegeziel	DMS bleibt intakt, keine Thrombosezeichen, die Teilbelastung wird korrekt eingehalten
Maßnahmen	• Bein hochlagern, Schwellung/Weichteile (Spannungsblasen) beobachten • DMS-Kontrolle und Gips/Orthese auf Einengung prüfen • Thromboseprophylaxe nach AO • Mobilisation und Teilbelastung anleiten • Schmerzmanagement nach AO
Evaluation	DMS intakt, keine Thrombosezeichen, korrekte Teilbelastung.

Achillessehnenruptur S86.0

Riss der Achillessehne, oft bei sportlicher Belastung. Typisch: plötzlicher peitschenartiger Schmerz, eingeschränkte Plantarflexion.

SYMPTOME

- Plötzlicher peitschenartiger Schmerz an der Ferse
- Hörbares Schnalzen
- Kraftverlust beim Abstoßen, Zehenstand nicht möglich
- Tastbare Delle über der Sehne
- Positiver Thompson-Test (keine Plantarflexion bei Wadenkompression)

DIAGNOSTIK

- Klinik + Thompson-Test
- Sonografie/MRT
- Tastbefund (Delle)

THERAPIE

- Konservativ (Spezialschuh/Orthese in Spitzfußstellung) oder operativ
- Ruhigstellung, schrittweise Belastung nach AO
- Thromboseprophylaxe
- Physiotherapie
- Belastungsaufbau

Pflegeproblem	Beeinträchtigte Mobilität und Thrombosegefahr r/t Achillessehnenruptur und Ruhigstellung m/d/s Belastungsunfähigkeit, Immobilisation
Ressourcen	Patient motiviert, Versteht die Belastungsregeln
Pflegeziel	Patient hält Ruhigstellung und Belastungsstufen ein; keine Thrombosezeichen
Maßnahmen	• Korrekte Ruhigstellung (Spitzfußstellung) kontrollieren • Thromboseprophylaxe nach AO • DMS-/Schwellungskontrolle dokumentieren • Mobilisation und Belastungsaufbau nach AO anleiten • Schmerzmanagement nach AO
Evaluation	Ruhigstellung/Belastung korrekt, keine Thrombosezeichen, zunehmende Mobilität.

Vordere Kreuzbandruptur S83.5

Riss des vorderen Kreuzbandes (VKB), meist Sportverletzung mit Distorsionstrauma. Führt zu Instabilität des Kniegelenks.

SYMPTOME

- Akutes Knietrauma mit Schmerz
- Hörbares Knacken
- Schwellung/Gelenkerguss (Hämarthros)
- Instabilitätsgefühl (Giving-way)
- Bewegungseinschränkung

DIAGNOSTIK

- Klinische Tests (Lachman-/Schubladentest)
- MRT des Knies
- Gelenkpunktion bei Erguss (Hämarthros)

THERAPIE

- Akut: PECH-Schema (Pause, Eis, Compression, Hochlagern)
- Konservativ (Muskelaufbau) oder operativ (Kreuzbandplastik)
- Postoperativ: Mobilisation, Beweglichkeit, Belastung nach AO
- Thromboseprophylaxe
- Physiotherapie

Pflegeproblem	Akuter Schmerz/Schwellung und beeinträchtigte Mobilität r/t Kreuzbandruptur (bzw. postoperativ) m/d/s Gelenkerguss, Instabilität
Ressourcen	Patient motiviert, Physiotherapie verfügbar
Pflegeziel	Schwellung und Schmerz sind rückläufig; Patient hält Belastungs-/Bewegungsvorgaben ein
Maßnahmen	• Akut PECH-Schema, Schwellung/Erguss beobachten • Schmerzmanagement nach AO • Postoperativ Mobilisation/Beweglichkeit, Orthese nach AO • Thromboseprophylaxe, DMS-Kontrolle • Belastungsaufbau/Physiotherapie anleiten
Evaluation	Schwellung/Schmerz rückläufig, Vorgaben eingehalten, zunehmende Stabilität.

Lösungen der Kontrollfragen

Herzinsuffizienz

1 B NYHA III = Symptome (Dyspnoe, Erschöpfung) bereits bei leichter körperlicher Belastung wie Treppensteigen. NYHA I = keine Symptome, NYHA IV = Ruhedyspnoe.

2 B Oberkörperhochlagerung 30-45°: senkt venösen Rückstrom → entlastet das Herz, verbessert Atemmechanik. Bei Schock: flach lagern!

3 B Tägliche Gewichtskontrolle (gleiche Zeit, leichte Kleidung) + Ein-/Ausfuhrbilanz: Gewichtszunahme >1kg/Tag = Warnsignal für Flüssigkeitsretention → Arzt informieren!

COPD

4 B COPD-Patienten mit chronischer Hyperkapnie haben einen hypoxischen Atemantrieb. Zu viel O_2 (SpO_2 > 92%) → Atemdepression → CO_2-Narkose. Ziel-SpO_2: 88-92%!

5 B Kutschersitz: Patient sitzt, lehnt sich nach vorne, stützt Arme auf Oberschenkeln oder Tisch. Fixiert Schultergürtel → Atemhilfsmuskulatur (Mm. scaleni, sternocleidomastoideus) kann effizienter arbeiten.

6 B Lippenbremse: durch locker aufeinanderliegende Lippen langsam ausatmen. Erzeugt leichten Gegendruck → verhindert Bronchiolenkollaps beim Emphysem → effektivere Entleerung der Lungen.

Diabetes mellitus Typ 2

7 B BZ < 70 mg/dl + Patient wach → 20g KH oral (4 Traubenzuckertäfelchen, 200ml Fruchtsaft). BZ-Kontrolle nach 15 Min. Bei Bewusstlosigkeit: Glukose 40% i.v. oder Glukagon i.m.

8 B Wärmflasche ist KONTRAINDIZIERT! Diabetische Neuropathie → kein Temperaturempfinden → Verbrennungsgefahr! Korrekte Fußpflege: tägliche Inspektion, keine Hitze, professionelle Fußpflege, Druckentlastung.

9 B HbA1c = glykiertes Hämoglobin: zeigt den durchschnittlichen BZ der letzten 8-12 Wochen. Ziel bei Diabetes meist < 7% (53 mmol/mol). Vorteil: nicht von Tageszeit/Mahlzeiten abhängig.

Schlaganfall (Apoplex)

10 B FAST = schnelle Schlaganfallerkennung: F=Face (hängt eine Gesichtshälfte?), A=Arms (kann Patient beide Arme heben?), S=Speech (ist Sprache undeutlich/fehlt?), T=Time (Uhrzeit notieren, sofort 112!).

11 B Bobath: betroffene Seite aktivieren, nicht kompensatorisch mit gesunder Seite arbeiten. Patient von betroffener Seite ansprechen, Lagerung auf beiden Seiten, alle Aktivitäten beidseitig durchführen. Fördert Neuroplastizität.

12 B Dysphagie = Schluckstörung, häufig nach Schlaganfall. Stille Aspiration (kein Husten!) besonders gefährlich → Aspirationspneumonie. Logopädie-Schluckdiagnostik, angepasste Kostform (IDDSI), Oberkörperhochlagerung beim Essen, niemals mit Strohhalm!

Hypertonie

13 B Hypertonie: ≥ 140/90 mmHg (gemessen mehrfach in Ruhe). Optimaler RR: < 120/80. Hochnormaler RR: 130-139/85-89. Hypertensive Krise: > 180/120 mmHg mit Symptomen → Notfall!

14 B Korrekte RR-Messung: 5 Min. Ruhe, sitzen, Arm auf Herzhöhe, keine Kleidung am Oberarm, korrekte Manschettengröße (zu klein → falscher Wert!), beide Arme vergleichen (Differenz > 10 mmHg = abklären).

15 B Hypertensive Krise: RR > 180/120 + Endorganschäden (Herz, Hirn, Niere) → Hypertensiver Notfall! Maßnahmen: Arzt sofort, Patient beruhigen (Stress erhöht RR), flache Lagerung, RR-Monitoring alle 5 Min., i.v.-Antihypertensiva nach Anordnung.

Postoperative Pflege

16 B Postoperative Standardprophylaxen: Thrombose (NMH, Kompressionsstrümpfe, Frühmobilisation), Pneumonie (Atemübungen, OK-Hochlagerung, Mobilisation), Dekubitus (Umlagerung, Druckmessung), Sturz (Bettgitter, Klingel griffbereit).

17 B Frühmobilisation = so früh wie möglich! Vorteile: reduziert Pneumonie, Thrombose, Dekubitus, Muskelschwund, Delir. Beginn: nach Stabilisierung (Kreislauf stabil, Schmerz tolerierbar). Stufenweise: Sitzen → Stehen → Gehen.

18 B Sofortige Arzt-Information bei: Rötung + Wärme + Schwellung (Infektzeichen), eitriges Sekret, Fieber > 38°C, Wunddehiszenz (Wunde öffnet sich), plötzliche starke Schmerzsteigerung, Nachblutung.

Hüft-TEP / Knie-TEP

19 B Hüft-TEP Luxationsprophylaxe: Abduktionskeil zwischen Beine, Hüfte nicht > 90° beugen (erhöhte Sitzgelegenheiten!), keine Innenrotation, keine Adduktion (Beine nicht überkreuzen). Diese Regeln gelten 3-6 Monate!

20 B TEP-Operationen haben ohne Prophylaxe TVT-Rate bis 40%! Ursachen: Blutstase (Immobilität), Gefäßverletzung (OP), Hyperkoagulabilität. Maßnahmen: NMH (z.B. Enoxaparin 4-6 Wo.), Kompressionsstrümpfe, Frühmobilisation.

21 B Knie-TEP: Frühmobilisation ab Tag 1 (oft noch am OP-Tag!). Ziel: rasche Beugung (Tag 1: 60°, Tag 5: 90°). Motorschiene (CPM) möglich. Physio täglich. Thromboseprophylaxe bis 5-6 Wochen. Vollbelastung meist sofort erlaubt.

Appendizitis

22 B McBurney-Punkt: Druckschmerz im rechten Unterbauch, Mitte zwischen Nabel (Umbilikus) und rechtem Spina iliaca anterior superior. Typisch für Appendizitis. Blumberg-Zeichen = Loslassschmerz kontralateral = Peritonitis-Zeichen!

23 B KEINE Wärme bei Appendizitisverdacht! Wärme → Vasodilatation → Entzündungsförderung → erhöhtes Perforationsrisiko. Auch keine Laxanzien, keine Analgetika vor Diagnose (verdecken Befund – umstritten). Kühlung und Nahrungskarenz stattdessen.

24 B Postoperative Komplikationen: Wundinfektion (3-5%), intraabdomineller Abszess (bei perforierter Appendizitis), Darmparalyse/Ileus (Blähbauch, kein Darmgeräusch), Nachblutung, Narbenhernie (selten). Frühmobilisation und Kostaufbau reduzieren Ileus-Risiko.

Kommunikationsmodelle

25 B Schulz von Thun: jede Nachricht enthält 4 Ebenen: 1. Sachinhalt (was ist die Info?), 2. Selbstoffenbarung (was sage ich über mich?), 3. Beziehungsebene (was halte ich vom Empfänger?), 4. Appell (was soll der Empfänger tun?). Missverständnisse entstehen durch unterschiedliche Sender-/Empfänger-Ohren.

26 B Aktives Zuhören: Blickkontakt, zugewandte Körperhaltung, Nicken, Paraphrasieren ('Sie meinen also...'), Verbalisieren von Gefühlen ('Das klingt belastend'), offene Fragen ('Wie fühlen Sie sich dabei?'), keine vorschnellen Ratschläge. Zeigt echtes Interesse.

27 B GFK (Marshall Rosenberg): 1. Beobachtung (ohne Bewertung: 'Wenn ich sehe dass...'), 2. Gefühl ('fühle ich mich...'), 3. Bedürfnis ('weil ich brauche...'), 4. Bitte ('bitte ich Sie...'. Unterschied: Beobachtung ≠ Bewertung, Bitte ≠ Forderung. Reduziert Konflikte.

Stressbewältigung & Burnout

28 B Burnout-Trias nach Maslach: 1. Emotionale Erschöpfung ('ausgebrannt sein'), 2. Depersonalisation (Distanzierung, Zynismus gegenüber Patienten/Kollegen), 3. Reduzierte Leistungsfähigkeit (Gefühl nichts mehr zu schaffen). Messung: Maslach Burnout Inventory (MBI).

29 B PMR: Muskelgruppen nacheinander 5-10s anspannen → loslassen → Unterschied wahrnehmen. Beginnt bei Händen → Arme → Gesicht → Nacken → Rücken → Bauch → Beine. Führt zu tiefer Entspannung. Evidenzbasiert bei Stress, Angst, Schlafstörungen. Einfach erlernbar!

30 B Selbstfürsorge = Voraussetzung für gute Pflege! Erschöpfte Pflegekräfte machen mehr Fehler und können nicht empathisch sein. Maßnahmen: ausreichend Schlaf, Sport, soziale Kontakte, Hobbys, Supervision, Grenzen setzen, professionelle Hilfe rechtzeitig suchen.

Motivationstheorien

31 B Maslow (1943): 5 Hierarchiestufen: 1. Physiologisch (Essen, Trinken, Schlafen), 2. Sicherheit (Schutz, Stabilität), 3. Soziale Bedürfnisse (Zugehörigkeit, Liebe), 4. Anerkennung (Wertschätzung, Status), 5. Selbstverwirklichung. Erst wenn untere Ebene erfüllt, strebt Mensch nach oben. Pflegerelevant: Grundbedürfnisse zuerst!

32 B Motivational Interviewing (Miller & Rollnick): Patient soll eigene Motivation entwickeln, nicht durch Druck. Prinzipien: Empathie, Diskrepanz entwickeln (zwischen Ist und Ziel), Widerstand vermeiden, Selbstwirksamkeit stärken. Vorteil: höhere Nachhaltigkeit als direktive Beratung.

33 B TTM (Prochaska & DiClemente): 1. Absichtslosigkeit (kein Problembewusstsein), 2. Absichtsbildung (denkt darüber nach), 3. Vorbereitung (plant Änderung), 4. Handlung (ändert Verhalten), 5. Aufrechterhaltung (stabil > 6 Mo.). Pflege: Interventionen stadiengerecht anpassen!

Mammakarzinom

34 B BET = Brusterhaltende Therapie: Tumor wird mit Sicherheitsabstand entfernt (Lumpektomie/Segmentresektion) + obligate postoperative Bestrahlung der gesamten Brust. Gleichwertig zur Mastektomie bei geeigneten Tumoren (Größe, Lokalisation).

35 B Nach Axilladissektion: betroffener Arm absolut schonen vor Traumen. KEIN Blutdruck messen, keine venösen/arteriellen Punktionen, keine i.m.-Injektionen. Kein enger Schmuck. Keine Hitze (Sauna, Sonnenbrand). Sofort bei Rötung/Schwellung/Wärme: Arzt informieren (Erysipel-Risiko!).

36 B Sentinel-LK = Wächterlymphknoten: erster Lymphknoten in der Abflussbahn des Tumors. Wird intraoperativ markiert (radioaktiv/Farbstoff) und entfernt. Histologisch untersucht: kein Befall → keine Axilladissektion nötig → weniger Lymphödem-Risiko!

Präeklampsie / Eklampsie

37 B HELLP = H(emolysis) + E(levated) L(iver enzymes) + L(ow) P(latelets). Schwere Komplikation der Präeklampsie. Symptome: Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Thrombozytopenie → Blutungsrisiko, Hämolyse, Leberruptur möglich. Sofortige Entbindung oft nötig!

38 B Magnesiumsulfat: Standard-Antikonvulsivum bei Eklampsie und schwerer Präeklampsie. Überdosierung → Mg-Toxizität: erst Reflexverlust (PSR fehlt!), dann Atemdepression, dann Herzstillstand. Monitoring: PSR, Atemfrequenz, Diurese. Antidot: Calciumgluconat 10% i.v.!

39 B Eklampsie = tonisch-klonischer Krampfanfall bei Präeklampsie ohne andere Ursache. Häufig mit Bewusstlosigkeit. Notfallmaßnahmen: Seitenlage, Atemweg sichern, O_2, Diazepam i.v., Magnesium i.v., sofortige Entbindung vorbereiten.

Spontangeburt (physiologische Geburt)

40 B Eröffnungsphase (Muttermund öffnet sich bis 10 cm), Austreibungsphase (vollständige Eröffnung bis Geburt des Kindes, Presswehen), Nachgeburtsphase (Geburt der Plazenta). Danach folgt die Postplazentarphase (frühes Wochenbett).

41 B Geburtsbeginn zeigt sich durch regelmäßige, an Stärke und Frequenz zunehmende Wehen, den Blasensprung (Fruchtwasserabgang) und das Zeichnen (Abgang des blutig-schleimigen Schleimpfropfs).

42 B Das CTG (Kardiotokografie) zeichnet gleichzeitig die Wehen und die kindlichen Herztöne auf. Abfälle der Herzfrequenz können auf eine fetale Hypoxie (Sauerstoffmangel) hinweisen und erfordern rasches Handeln.

Sectio caesarea (Kaiserschnitt)

43 B Eine sekundäre/Not-Sectio wird bei akuter Gefahr für Mutter oder Kind durchgeführt, z. B. pathologisches CTG (fetale Hypoxie), Nabelschnurvorfall, vorzeitige Plazentalösung oder Geburtsstillstand.

44 B Nach der Operation und im Wochenbett ist das Thromboserisiko erhöht. Wichtig sind LMWH, Kompressionsstrümpfe und vor allem die frühe Mobilisation. Zusätzlich gelten die Wochenbett-Kontrollen (Fundus, Lochien).

45 B Stillen ist nach einer Sectio möglich. Durch Wundschmerz, verzögerten Milcheinschuss und eingeschränkte Mobilität ist der Start oft erschwert – hier hilft aktive Stillberatung, schmerzarme Positionen und frühes Anlegen.

Neugeborenenversorgung (Erstversorgung, APGAR)

46 B APGAR bewertet Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen (Hautfarbe) und Reflexe – je 0 bis 2 Punkte, erhoben bei 1, 5 und 10 Minuten. Ein Wert von 7 bis 10 gilt als unauffällig.

47 B Neugeborene verlieren wegen ihrer relativ großen Körperoberfläche und der unreifen Wärmeregulation rasch Wärme. Abtrocknen, Haut-zu-Haut-Kontakt und Mütze beugen einer gefährlichen Auskühlung vor.

48 B Die U1 erfolgt unmittelbar nach der Geburt (Erstuntersuchung inkl. APGAR). Die U2 folgt am 3. bis 10. Lebenstag, ergänzt durch das Neugeborenen-Screening aus Fersenblut.

Stillen und Laktation

49 B Prolaktin sorgt für die Milchbildung, Oxytocin löst den Milchspende-/Let-down-Reflex aus. Häufiges Anlegen fördert über den Saugreiz beide Hormone und damit die Milchmenge.

50 B Bei Mastitis wird meist weiter gestillt bzw. entleert (Milchstau lösen!), zusätzlich Kühlung nach dem Stillen, Schonung und ausreichend Flüssigkeit. Bei ausbleibender Besserung oder Fieber ggf. Antibiotikum – Abstillen ist selten nötig.

51 B Beim korrekten Anlegen erfasst das Kind die Mamille samt großem Teil des Warzenhofs, die Lippen sind nach außen gestülpt, Kinn berührt die Brust. Das beugt wunden Mamillen vor und sichert effektives Trinken.

Gestationsdiabetes (GDM)

52 B Der orale Glukosetoleranztest (oGTT) wird als Screening in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche durchgeführt, da der GDM meist symptomarm verläuft und sonst unentdeckt bliebe.

53 B Reichen Ernährung und Bewegung nicht aus, wird mit Insulin behandelt. Orale Antidiabetika werden in der Schwangerschaft in der Regel nicht eingesetzt. Basis bleibt immer die Ernährungsumstellung.

54 B Das Kind hat sich intrauterin an hohe Zuckerwerte angepasst und produziert vermehrt Insulin. Nach der Geburt fällt das mütterliche Zuckerangebot weg – es droht eine neonatale Hypoglykämie, die überwacht werden muss.

HELLP-Syndrom

55 B HELLP = Hemolysis (Hämolyse), Elevated Liver enzymes (erhöhte Leberwerte) und Low Platelets (niedrige Thrombozyten). Es ist eine schwere Verlaufsform der Präeklampsie.

56 B Der rechtsseitige Oberbauchschmerz entsteht durch die Spannung der Leberkapsel und ist ein Warnzeichen. Zusammen mit Übelkeit, Kopfschmerz und Hypertonie muss an ein HELLP-Syndrom gedacht werden.

57 B Ursächlich beseitigt wird das HELLP-Syndrom nur durch die Entbindung. Bis dahin werden Blutdruck gesenkt, Magnesium zur Krampfprophylaxe und Kortison zur Lungenreife gegeben und Mutter und Kind intensiv überwacht.

Frühgeburt / vorzeitige Wehen

58 B Eine Frühgeburt ist die Geburt vor abgeschlossener 37. Schwangerschaftswoche. Je unreifer das Kind, desto höher das Risiko für Atemprobleme, Infektionen und weitere Komplikationen.

59 B Kortison (z. B. Betamethason) beschleunigt die kindliche Lungenreife und die Surfactant-Bildung. Das senkt das Risiko für ein Atemnotsyndrom des Frühgeborenen deutlich.

60 B Die Tokolyse hemmt die Wehen und zögert die Geburt hinaus. Das gewonnene Zeitfenster wird genutzt, um die Lungenreifeinduktion abzuschließen und ggf. in ein Perinatalzentrum zu verlegen.

Harnwegsinfekt (HWI)

61 B Mittelstrahlurin: 1. Genitale reinigen (Frau: von vorne nach hinten), 2. Ersten Harnstrahl verwerfen (spült Harnröhre), 3. Mittelstrahl in steriles Gefäß, 4. Letzten Strahl verwerfen. Innerhalb 2h ins Labor oder kühlen. Kontamination durch falschen Einfangen verfälscht Ergebnis!

62 B CAUTI (Catheter-Associated Urinary Tract Infection): häufigste nosokomiale Infektion. Risiko steigt täglich. Jeder Tag ohne Indikation = vermeidbares Infektionsrisiko. Täglich fragen: Braucht der Patient den Katheter wirklich noch? Wenn nein: sofort entfernen! → wichtigste Prophylaxe.

63 B Bei alten Menschen: typische Symptome (Dysurie, Pollakisurie) oft nicht vorhanden! Häufig nur: Verwirrtheit, Delir, Stürze, Inappetenz, allgemeine Verschlechterung. Bei plötzlicher Verwirrtheit älterer Patienten immer HWI ausschließen (Urinstreifentest)!

Benignes Prostataadenom (BPH)

64 B TURP = Transurethrale Resektion der Prostata: Goldstandard bei BPH. Endoskopisch (kein Hautschnitt!): Resektoskop über Harnröhre → elektrische Schlinge trägt Prostatagewebe ab. Postoperativ: DK + Blasenspülung (Hämatocolpos). Cave: Ejakulationsprobleme (retrograde Ejakulation) häufig!

65 B Akuter Harnverhalt: Blase unter hohem Druck (bis 1000ml+). Sofortiger kompletter Ablauf → Druckabfall → Schleimhautgefäße rupturieren → Hämaturie (ex vacuo) + Vagotonie/Hypotonie möglich. Daher: max. 500ml ablassen, dann kurz abklemmen, weiter ablassen – langsam!

66 B IPSS (International Prostate Symptom Score): 7 Fragen zu Miktionssymptomen (Harnstrahl, Harndrang, Restharnfühl etc.) + 1 Frage Lebensqualität. 0-7 = leicht, 8-19 = mäßig, 20-35 = schwer. Wichtig für Therapieentscheidung und Verlaufskontrolle.

Schlaganfall (Apoplex)

67 B FAST = Schlaganfall-Schnelltest: F(ace) = Gesicht hängt? A(rms) = Arm sinkt ab bei Vorhalteversuch? S(peech) = Sprache verwaschen/fehlt? T(ime) = Uhrzeit notieren, SOFORT 112! Je schneller Stroke Unit, desto besser. Time is Brain!

68 B Nach Schlaganfall: Schluckreflexstörung häufig (50-60%). Gefährlich: stille Aspiration = Patient aspiriert ohne zu husten oder zu würgen! → Aspirationspneumonie → häufige Todesursache. Daher: KEIN Schluck (auch kein Wasser, Medikamente!) vor validiertem Dysphagie-Screening.

69 B Bobath: Pflege bezieht betroffene (paretische) Seite aktiv ein. Patient wird von betroffener Seite angesprochen, Pflege erfolgt von dieser Seite. Gegenteil: kompensieren mit gesunder Seite → verhindert Rehabilitation. Bobath fördert Neuroplastizität (Gehirn lernt neu). Lagerung: betroffenen Arm/Bein stützen, Spastik vermeiden.

Epilepsie

70 B Bei Anfall NICHT: festhalten (Frakturrisiko!), Beißkeil einlegen (Verletzung von Zähnen, Mund, Finger der Pflegekraft, Aspirationsgefahr!), in den Mund fassen. TUN: Zeit stoppen, Verletzungsschutz (Polster), stabile Seitenlage nach Anfall, O_2, ärztl. Information wenn > 5 Min. (Status epilepticus!).

71 B Status epilepticus: Anfall > 5 Min. ODER 2+ Anfälle ohne vollständige Erholung dazwischen. Notfall! Schädigung: je länger, desto mehr Neuronen. Therapie: Lorazepam i.v. 0,1mg/kg → 2. Stufe: Phenytoin/Valproat i.v. → bei Therapieversagen: Narkose (Propofol/Midazolam/Thiopental).

72 B Postiktale Phase: nach epileptischem Anfall. Patient: verwirrt, desorientiert, erschöpft, ggf. Aphasie (Todd-Parese). Kann Minuten bis Stunden dauern. Wichtig: Patient nicht alleine lassen, orientieren, sichern. Nicht mit Schlaganfall verwechseln! (Differenzierung: Vorgeschichte, Anfallsverlauf, EEG, CCT)

Tracheotomie-Pflege

73 B PDT (perkutane Dilatationstracheotomie): Bronchoskopisch kontrolliert, am Intensivbett möglich, schnell. Geeignet für unkomplizierte Anatomie. Chirurgische Tracheotomie: OP-Saal, bei erschwerter Anatomie (Adipositas, kurzer Hals, Struma), Kindertracheotomie, elektive Dauerlösungen (Laryngektomie). PDT heute häufiger auf ICU.

74 B Absaugung = Unterbrechung der Beatmung + Sog entzieht auch Alveolarluft → SpO_2 fällt. Präoxygenierung: FiO_2 für 1-2 Min. auf 100% erhöhen (beatmet) oder 2-3 tiefe Atemzüge ermöglichen (spontan). Maximal 15 Sek. absaugen, dann erneut beatmen/oxygenieren, DANN ggf. 2. Absaugvorgang.

75 B HME (Heat and Moisture Exchanger): kleines Gerät auf Tracheostoma/Kanüle. Speichert Wärme und Feuchtigkeit der Ausatemluft → gibt sie bei Einatmung zurück. Ersetzt Klimatisierungsfunktion der Nase. Verhindert Schleimhautaustrocknung und Sekreteindickung. Gleichzeitig Bakterienfilter. Wechsel alle 24h.

Otitis media (Mittelohrentzündung)

76 B Ohrtrompete (Tuba Eustachii) bei Kindern: kürzer (Erwachsene: 3,5cm, Kinder: 1,8cm), horizontaler (Erwachsene: 45°, Kinder: 10°), weicher (kollabiert leichter). → Schlechte Belüftung des Mittelohrs + leichter Keimaufstieg aus Rachen. Adenoide (Rachenmandeln) behindern zusätzlich.

77 B Trommelfellperforation bei Otitis media: Der Eiter entweicht nach außen → Druckentlastung im Mittelohr → oft deutliche Schmerzlinderung! Nicht dramatisch wirken: Eltern beruhigen, Abstrich abnehmen, Ohr trocken halten (kein Wasser!), Antibiose prüfen. Trommelfell heilt meist spontan zu.

78 B Paukenröhrchen (Tympanostomieröhrchen): chirurgisch ins Trommelfell eingesetzt (in Kurznarkose beim Kind). Belüftet das Mittelohr dauerhaft, lässt Sekret abfließen. Indikation: ≥3 Otitis-Episoden in 6 Monaten ODER Hörverlust durch Paukenerguss > 3 Monate. Fällt nach 6-18 Monaten meist selbst heraus.

Onkologische Pflegegrundlagen

79 B Febrile Neutropenie: onkologischer Notfall! Infektionen können ohne Neutrophile (die Abwehrzellen fehlen) rasend schnell zur Sepsis führen. Mortalität ohne schnelle Therapie hoch. Maßnahmen: 2x Blutkultur → sofort Breitband-Antibiose innerhalb 1h (nicht warten auf Kulturergebnis!). Häufige Erreger: E. coli, Klebsiella, Pseudomonas.

80 B CINV = durch Chemotherapie ausgelöste Übelkeit und Erbrechen. Akut (0-24h), verzögert (24-120h), antizipatorisch (Pawlow-Reflex). Prophylaxe nach Emetogenität: hoch emetogen (Cisplatin): 5-HT3-Antagonist + Dexamethason + Aprepitant + ggf. Olanzapin. Antiemetika VOR Chemo geben!

81 B Tumor-Fatigue: häufigste Nebenwirkung bei Krebs (>80%). Unterschied zu normaler Müdigkeit: durch Schlaf NICHT gebessert, beeinflusst alle Lebensbereiche. Ursachen: Tumor, Therapie, Anämie, Schmerz, Depression. Therapie: Aktivitätsmanagement (nicht schonen, sondern angepasste Bewegung!), Behandlung Anämie, kognitive Verhaltenstherapie.

Palliativpflege

82 B WHO-Stufenschema: Stufe 1 = Nicht-Opioide (NSAR, Paracetamol, ±Adjuvanzien). Stufe 2 = schwache Opioide (Tramadol, Tilidin). Stufe 3 = starke Opioide (Morphin, Oxycodon, Fentanyl). Prinzip: oral, regelmäßig (nach Uhr!), individuell, mit Begleitmedikation (Antiemetikum, Laxans). Koanalgetika: Antidepressiva, Antikonvulsiva bei Neuropathie.

83 B Opioide binden an μ-Opioid-Rezeptoren im Darm → Hemmung der Peristaltik → Obstipation bei nahezu allen Patienten. Im Gegensatz zu Übelkeit (bessert sich) und Sedierung (bessert sich) entwickelt sich KEINE Toleranz gegen Obstipation! Daher: Laxans von Anfang an, z.B. Macrogol, Natriumpicosulfat. Nie vergessen!

84 B Rasselatmung (death rattle): Sekret sammelt sich im Rachen/Rachen bei abgeschwächtem oder fehlendem Schluckreflex in der Sterbephase. Geräuschvoll, aber: Patient nimmt es meist nicht wahr (Bewusstsein stark reduziert). Maßnahmen: Seitenlage, Absaugen NUR wenn Patient leidet, Mundpflege, vor allem: Angehörige aufklären und begleiten – für sie ist es belastend.

Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.
Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf **plan-nrw.de**

© PLAN Digital · Patrick Schenkelberger. Nur für den persönlichen Gebrauch. Weitergabe, Weiterverkauf und Veröffentlichung nicht gestattet.